



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 18

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta vinculada a la imagen n° 1:

Su adjunto de pediatría que ha decidido dedicarle un tiempo para su docencia (a cambio de todos los informes que le ha hecho durante la semana), le muestra la siguiente radiografía de abdomen. Le cuenta que el paciente al que pertenece es un recién nacido que comenzó con vómitos biliosos y distensión del hemiabdomen superior. A continuación le ofrece 4 opciones para que se aventure en el diagnóstico. ¿Cuál sería la patología a la que se refiere?:

1. Atresia de esófago.
2. Atresia pilórica.
3. Enfermedad de Hirschsprung neonatal.
4. Atresia duodenal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La radiografía de tórax-abdomen mostrada es patognomónica de ATRESIA DUODENAL: muestra dos niveles hidroaéreos que corresponden al estómago y al bulbo duodenal ("imagen en doble burbuja") y ausencia casi total de aire distal. La clínica del paciente, como es lógico, es la de una obstrucción intestinal. Los vómitos son biliosos porque la obstrucción se localiza por debajo del esfínter de Oddi. Recordad que en la atresia pilórica la imagen radiológica sería de burbuja única.

2. Pregunta vinculada a la imagen n° 2:

Mujer de 45 años, fumadora y en tratamiento con anticonceptivos orales. Acude a urgencias por dolor torácico de inicio súbito junto con disnea de pequeños esfuerzos. A la exploración presenta una TA 140/60, FC 105 lpm, SatO₂ en situación basal de 93% y está afebril. El ECG muestra taquicardia sinusal sin alteraciones significativas de la repolarización, y en la GSA presenta una PaO₂ de 65 mmHg y una PaCO₂ de 32 mmHg. Un médico residente muy suspicaz le pide la prueba diagnóstica que nos muestra la imagen 2. ¿Cuál es el diagnóstico?:

1. Neumonía adquirida en la comunidad grave.
2. Angina inestable.
3. Aneurisma de aorta disecante.
4. Tromboembolismo pulmonar agudo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente de 45 años con clínica típica de tromboembolismo pulmonar y con antecedentes de tratamiento con anticonceptivos orales (factor de riesgo). ECG inespecíficamente anormal (recuerda que el principal hallazgo en el ECG es la taquicardia sinusal) y GSA con hipoxemia hipocapnica. En la imagen del Angio-TC se observan 2 ocupaciones endoluminales en ambas arterias pulmonares, lo que nos confirma la presencia de un

tromboembolismo pulmonar, aunque solo por la clínica ya se debería sospechar.

3. Pregunta vinculada a la imagen n° 3:

Un paciente ingresado después de un politraumatismo grave presenta a las 24 horas disnea progresiva. Una primera radiografía de tórax muestra mínimos infiltrados alveolares bilaterales. Pasadas unas horas se obtiene una nueva radiografía de tórax que se muestra en la imagen 3. ¿Cuál es su diagnóstico?:

1. Tromboembolismo pulmonar secundario a la inmovilización.
2. Contusión pulmonar.
3. Síndrome de distress respiratorio del adulto.
4. Hemorragia alveolar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente politraumatizado que desarrolla infiltrados alveolares bilaterales. El diagnóstico podría ser contusión pulmonar, aunque suele ser unilateral. La contusión pulmonar, y el politraumatismo aunque no afecte al tórax, son factores que favorecen la aparición de un distress respiratorio del adulto, por lo que debe monitorizarse a este paciente. En el caso de que aparezca insuficiencia respiratoria refractaria a oxigenoterapia, definida con cociente PaO₂/FiO₂ inferior a 200, podríamos denominarlo SDRA. Dado que nos dan en la Rx afectación bilateral y progresiva, nos piden que pensemos en un distress. Pero siendo honestos en el momento actual, sin insuficiencia respiratoria, no podríamos realizar ese diagnóstico, pues el diagnóstico de distress exige la presencia de hipoxemia refractaria. Técnicamente el paciente no tiene un distress puesto que no tiene insuficiencia respiratoria y no cumple criterios diagnósticos, pero el MIR es como es, y a veces la respuesta correcta es simplemente la menos mala.

4. Pregunta vinculada a la imagen n° 4:

Hombre de 66 años, fumador de 20 cigarillos/día y bebedor de más de 90 gramos de alcohol/día. Es diabético tipo II en tratamiento con metformina. Ingresó por presentar en los últimos 2 meses disnea progresiva hasta hacerse de reposo, ortopnea y crisis de disnea paroxística nocturna. En la exploración destaca soplo pansistólico, crepitantes de gruesa burbuja diseminados y edemas en extremidades inferiores. Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 130 lpm y bloqueo completo de rama izquierda. La radiografía de tórax se muestra en la imagen. ¿Cuál sería su primer diagnóstico de sospecha?:

1. Miocardiopatía restrictiva.
2. Pericarditis crónica constrictiva.

3. Miocardiopatía dilatada.
4. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La radiografía presenta cardiomegalia global, derrame pleural bilateral, y edema intersticial de predominio en bases. Ésta es una pregunta que no debe suponer mucha dificultad, pues en el caso clínico nos dan todos los datos necesarios para no dudar con el resto de las respuestas: te presentan el caso de un bebedor importante de alcohol con clínica de ICC global (disnea, ortopnea y DPN, crepitantes y edemas en MMII) con corazón dilatado en la Rx tórax (miocardiopatía dilatada). Dentro de la miocardiopatía dilatada, la más preguntada y la que debes estudiar bien como etiología específica es la miocardiopatía alcohólica, pues es la causa reversible más frecuente de miocardiopatía dilatada en España. La miocardiopatía dilatada alcohólica se produce por toxicidad directa del etanol sobre los miocitos y se manifiesta de igual manera que todas las miocardiopatías dilatadas: disfunción ventricular sistólica global con VI dilatado, GC bajo y resistencias periféricas elevadas. El soplo pansistólico que nos cuenta el enunciado es de insuficiencia mitral, que se produce fundamentalmente por la dilatación del anillo mitral que da lugar a un cierre incompleto de la válvula mitral en la sístole. Al volver la sangre hacia la AI ésta se va dilatando progresivamente. La dilatación de la AI provoca gran inestabilidad eléctrica que desemboca en fibrilación auricular. No olvides que aproximadamente un 30% de los pacientes con miocardiopatía dilatada (independientemente de la causa) desarrollan bloqueo de rama izquierda, que les provoca una marcada asincronía eléctrica y mecánica que puede contribuir a empeorar su situación hemodinámica (y que es la base de la terapia de resincronización). El tratamiento, a parte de las medidas habituales de manejo de la ICC sistólica es el cese absoluto del consumo de alcohol. Con ello la función ventricular mejora y en numerosos casos es completamente reversible.

- La miocardiopatía restrictiva no provoca cardiomegalia en la Rx de tórax.
- La clínica de la pericarditis constrictiva es de ICC de predominio derecho y no provoca cardiomegalia. Además nos cuentan el signo de Kussmaul, la calcificación del pericardio.
- La miocardiopatía hipertrófica no produce cardiomegalia y el soplo es diferente: se atenúa o se aumenta con la realización de determinadas maniobras, como la inspiración o el Valsalva.

5. Pregunta vinculada a la imagen nº 5:

Mujer de 47 años, natural de Bolivia, residente en España desde hace 10 años, sin antecedentes de interés, que acude a su consulta por presentar disfagia y estreñimiento crónico. En el enema opaco realizado se muestran los hallazgos que aparecen en la imagen 5. La prueba diagnóstica más rentable para el diagnóstico sería:

1. Panendoscopia oral y colonoscopia para toma de biopsias.

2. Aspirado de médula ósea para Leishmania sp.
3. Serología para T. cruzi.
4. Coprocultivo para enteropatógenos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La presencia de estreñimiento se justifica por el megacolon que vemos en el enema opaco. En un paciente procedente de un área endémica de Trypanosoma cruzi hay que plantearse el diagnóstico de Enfermedad de Chagas, que se confirma mediante una serología. La disfagia se explica porque la paciente presentará también un megaesófago debido al Chagas. Además de la afectación digestiva, la más frecuente, también existen las manifestaciones cardíacas en forma de cardiopatía dilatada con dilatación biventricular y bloqueos de rama derecha típicamente.

6. Pregunta vinculada a la imagen nº 6:

Un paciente ingresado por un IAM anterior extenso Killip III tratado mediante angioplastia primaria con colocación de un stent en la arteria descendente anterior presenta insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento convencional y se decide administrar levosimendan al 4º día del infarto. Inicialmente presenta una buena evolución clínica, pero a las 36 horas comienza con malestar general y se obtiene un ECG que se muestra en la imagen. La PA es de 100/66 mmHg. Indique la respuesta correcta:

1. Presenta una taquicardia helicoidal. Hay alto riesgo de fibrilación ventricular.
2. Presenta una taquicardia ventricular. Es probable que la administración de levosimendan haya tenido que ver.
3. Presenta una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Se debe realizar estrategia de control de frecuencia con beta-bloqueantes.
4. El ECG sugiere una complicación mecánica como causa más probable del empeoramiento clínico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el ECG se observan rachas de TV separadas escasamente por un latido sinusal. Además, dichas taquicardias son monomorfas (no es una taquicardia helicoidal) pero se originan por la aparición de post-potenciales precoces (la despolarización ventricular comienza en el periodo refractario relativo del latido sinusal que aparece, de ahí que esos latidos sinusales tengan un ST y onda T raros (son el inicio del siguiente QRS, que origina la TV). En este caso, es muy probable que el levosimendan, fármaco inotrope positivo con menor efecto arritmogénico que las aminas vasoactivas (noradrenalina, dobutamina.) pero que también lo tiene, esté implicado en el mecanismo fisiopatológico de la taquicardia.

7. Pregunta vinculada a la imagen n° 7:

Mujer de 77 años con obesidad moderada, dislipemia, hipertensión arterial mal controlada y estenosis aórtica leve (según indica la última revisión de hace 1 mes). Acude al Servicio de Urgencias porque desde hace 10 días presenta episodios de dolor opresivo, centrotorácico, que aparecen con el esfuerzo, asociados a sudoración y sensación de malestar. La sintomatología cede siempre con el reposo. Esta mañana, al despertarse, ha presentado un episodio de dolor similar estando en reposo. El dolor ha cedido de manera espontánea. Estando en la sala de urgencias, con ECG inicial normal, presenta un nuevo episodio de dolor en reposo. Se decide repetir el ECG que se muestra en la imagen. El dolor cede con la administración de nitroglicerina sublingual. ¿Cuál considera que es la respuesta correcta?:

1. Se trata de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo.
2. La lesión coronaria debe estar ubicada en la arteria descendente anterior puesto que presenta descenso del segmento ST en la cara anterior.
3. Es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de bajo riesgo.
4. Se trata de una angina inestable.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La clínica de la paciente unida a los cambios electrocardiográficos indican que estamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST) de alto riesgo. Se habla de SCASEST de alto riesgo cuando se asocian al dolor anginoso, alguna de las siguientes: persistencia de la angina, inestabilidad hemodinámica, aparición de arritmias ventriculares malignas, elevación de marcadores de necrosis miocárdica, elevación transitoria del ST o descenso del ST > 1mm. La opción 2 es falsa: el descenso del ST (al contrario que la elevación), no es localizador de la región dañada (no nos puede indicar la arteria responsable) Con los datos que nos dan sólo podemos hablar de SCASEST. Para poder clasificarlo como angina inestable o infarto de miocardio, debemos esperar a la determinación de enzimas miocárdicas. Opción 4 falsa.

8. Pregunta vinculada a la imagen n° 8:

A los 15 días de padecer una amigdalitis tratada con doxiciclina por vía oral, un niño de 15 años presenta un brote con aparición de las lesiones que se muestran en la imagen 8, que se distribuyen en tronco y miembros y presentan descamación. La patología de sospecha sería:

1. Dermatitis atópica.
2. Psoriasis en gotas.

3. Pityriasis rosada de Gilbert.
4. Toxicodermia por doxiciclina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos hablan de un adolescente con lesiones eritematodescamativas en tronco y miembros, de pequeño tamaño y que aparecen tras una aparente amigdalitis estreptocócica. Este es el típico modo de presentación de la psoriasis en gotas, que es el modo de inicio del 30% de los casos de psoriasis.

9. Pregunta vinculada a la imagen n° 9:

Paciente de 36 años que, tras accidente de moto, presenta la fractura que aparece en la radiografía. Los fragmentos óseos están expuestos a través de la piel, a través de una herida de unos 12 cm. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado?:

1. Limpieza de la herida, cierre cutáneo, enclavado endomedular y antibioterapia.
2. Limpieza, cierre cutáneo, fijador externo y antibioterapia.
3. Limpieza, cierre cutáneo, antibioterapia y osteosíntesis con placa y tornillo y empleo de injerto autólogo en caso de impactación del hueso esponjoso y defecto óseo.
4. Limpieza y cierre de la herida y antibioterapia e inmovilización con férula isquiomaleolar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Aunque no se puede saber si es una IIIA o IIIB lo que no haría nunca en una fractura grado III en agudo, es una osteosíntesis con placa y tornillos e injerto óseo (opción 3). Lo que estaría indicado es la limpieza, cierre cutáneo, fijador externo y antibioterapia (opción 2 correcta) y en un segundo tiempo, cuando el estado de las partes blandas lo permita, y si no hay signos de infección, valoraríamos la posibilidad de realizar una osteosíntesis con placa y tornillos e injerto óseo. Debemos recordar que un elevado sufrimiento de partes blandas, herida que no somos capaces de conseguir cerrar, o muy alta energía y contaminación, son contraindicaciones para implantar material de osteosíntesis en el foco de fractura, dado el alto riesgo de complicaciones.

10. Pregunta vinculada a la imagen n° 10:

Mujer de 40 años que desde hace varios años presenta cambio de coloración de las manos con el frío (imagen 10). En el último año ha notado endurecimiento cutáneo en dedos de la mano y tos seca persistente. Dentro de los criterios diagnósticos de esta enfermedad no se incluye:

1. Aftas orales dolorosas.
2. Enfermedad pulmonar intersticial.

3. Esclerodactilia.
4. Telangiectasias.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los criterios ACR/EULAR de 2013 Esclerosis sistémica presentan una sensibilidad y especificidad superior al 90%. Existe un único criterio mayor y suficiente: esclerosis proximal a la articulación metacarpofalángica. Si no aparece, existen criterios menores con puntuaciones distintas: esclerodactilia, alteraciones capilarescópicas, telangiectasias, hipertensión pulmonar o enfermedad intersticial pulmonar, fenómeno de Raynaud y anticuerpos relacionados con esclerodermia. No incluyen la presencia de aftas orales.

11. Pregunta vinculada a la imagen nº 11:

Durante una de sus primeras guardias como residente en el Servicio de Urgencias, recibe usted en su sala a una mujer de 80 años sin historia de deterioro cognitivo, que ha sido encontrada en su casa en el suelo por su hija con bajo nivel de consciencia. Tras obtener datos de laboratorio normales, incluyendo análisis de orina, usted solicita TC craneal, cuyo resultado se muestra en la imagen 11. Señale la opción CORRECTA:

1. Con toda probabilidad la paciente habrá sufrido un traumatismo craneal.
2. La mortalidad en estos casos es muy reducida.
3. Probablemente haya ocurrido una rotura de venas corticodurales.
4. La presencia de focalidad neurológica debería hacernos sospechar la presencia de un infarto cerebral con muy alta probabilidad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una imagen hiperintensa en forma de semiluna correspondiente a un hematoma subdural agudo, que es típico de edades avanzadas y puede darse ante mínimos traumatismos craneales o incluso en ausencia de traumatismo, tiene una alta mortalidad (mayor del 50%), puede cursar con focalidad neurológica al existir sangre en contacto directo con la corteza cerebral, y debe tratarse mediante craneotomía evacuadora. La causa suele ser la rotura de venas corticodurales (opción 3 correcta).

12. Pregunta vinculada a la imagen nº 12:

Hombre de 69 años con antecedentes de hipertensión arterial e hiperuricemia en tratamiento con amlodipino y alopurinol. Hace unas 2 semanas presentó un cuadro de lumbalgia por el que recibió tratamiento con diclofenaco. Acude a urgencias del hospital por presentar desde hace 48 horas una erupción cutánea confluyente en tronco y extremidades.

Se muestra una fotografía de dicha erupción, que presenta asimismo la afectación mucosa que se muestra. El signo de Nikolsky es positivo. El diagnóstico probable es:

1. Penfigoide ampolloso.
2. Necrosis tóxica epidérmica (NET).
3. Pénfigo vulgar.
4. Pénfigo paraneoplásico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

A la exploración se observan lesiones maculares eritematovioláceas muy extensas sobre las cuales aparecen ampollas y erosiones. Existe afectación (lesiones rosivocostrosas) de mucosa labial y oral. No suele ser frecuente que pregunten toxicodermias en el examen MIR, pero esta pregunta puede resolverse con dos datos: el antecedente del diclofenaco hace 2 semanas y el signo de Nikolsky positivo. El signo de Nikolsky consiste en el despegamiento de la piel al pasar un dedo sobre ella. Es característico de 3 enfermedades que te deben venir a la cabeza en cuanto te digan el nombre de este signo: NET, pénfigo y Síndrome de la piel escaldada estafilocócica o SSSS. En este paciente el Nikolsky positivo, así como por la descripción de lesiones eritemato-erosivas, junto con afectación de mucosas, y por el antecedente farmacológico, no nos cabe ninguna duda que estamos ante una NET.

13. Pregunta vinculada a la imagen nº 13:

Varón de 65 años diagnosticado de cáncer folicular de tiroides hace 2 años. Se realiza rastreo con I131 que se muestra en la imagen. Señale la FALSA:

1. La interpretación de la imagen debe hacerse con cautela, pues las captaciones cerebrales, cardíacas, hepáticas y vesicales suelen ser fisiológicas. Dado el buen pronóstico de esta enfermedad, el paciente probablemente está en remisión completa.
2. Precisar de tratamiento con I131 a dosis altas.
3. Se detectan mutaciones en el oncogén RAS hasta en el 40 % de pacientes. Este hallazgo parece relacionarse con una mayor agresividad y peor evolución.
4. Este tipo de tumor presenta metástasis especialmente por vía hematogena.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En la imagen se objetiva captación anómala en cráneo, costillas, pelvis y pulmón. El paciente presenta enfermedad metastásica que requiere de tratamiento con I131. El cáncer folicular de tiroides es un tumor diferenciado de tiroides, el segundo en frecuencia después del cáncer papilar. Tiene buen pronóstico aunque ligeramente peor que el papilar. Cuando metastatiza lo hace a través de vía

hematogena (recordad que la vía ganglionar es del papilar). El seguimiento de este tipo de tumores se realiza con tiroglobulina, ac antitiroglobulina y diversas pruebas de imagen (ecografía cervical, PET, rastreos con I131, TC...). El principal tratamiento del que disponemos para tumores diferenciados de tiroides es el radioyodo. Cuando existe enfermedad metastásica se administran dosis altas de I131 (150-200 mCi). Cuando los tumores se desdiferencian y dejan de captar yodo su administración es menos eficaz y se deben plantear otras opciones terapéuticas: quimioterapia en tumores avanzados (regulares resultados, especialmente se consigue estabilización de la enfermedad), RT, nuevas terapias como inhibidores de tirosín kinasas... Hasta un 40 % de foliculares presentan mutaciones puntuales en el oncogén RAS que se podría relacionar con un curso más agresivo de la enfermedad. Por técnica MIR y sin saber mucho de tiroides: las opciones 1 y 2 son incompatibles entre sí, así que valdría con arriesgarse al 50% entre ellas.

14. Pregunta vinculada a la imagen nº 14:

El fondo de ojo mostrado en la imagen 14 es de un hombre de 56 años que acude a su consulta de Oftalmología por presentar desde hace unos meses escotomas paracentrales que han progresado. Según el diagnóstico de sospecha, ¿cuál de los siguientes hallazgos NO esperaría encontrar?:

1. Un campo visual con un escotoma arciforme.
2. Presión intraocular de 35 mmHg.
3. Un campo visual con un escalón nasal de Ronne.
4. Hipermetropía.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El paciente presenta un nervio óptico de aspecto glaucomatoso. La excavación es mayor de 0.7 y tiene un color pálido. Y no se asocia a edema de papila. La pérdida de fibras nerviosas produce defectos en el campo visual (primero escotomas paracentrales, seguidos de escalones nasales y posteriormente de defectos arciformes). En un estadio terminal, el campo visual se reduce a un islote central. La presión intraocular elevada es el principal factor de riesgo (PIO mayor de 21 mmHg). El glaucoma crónico de ángulo abierto (no doloroso) es más frecuente en miopes, mientras que el glaucoma agudo (muy doloroso) es más frecuentes en hipermétropes.

15. Pregunta vinculada a la imagen nº 15:

Si una mujer presenta fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna desde hace un mes y presenta esta radiografía de tórax, ¿qué tipo de enfermedad de Hodgkin sospecharía?:

1. Predominio linfocítico nodular.
2. Predominio linfocítico difuso.

3. Esclerosis nodular.
4. Celularidad mixta.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La variedad de linfoma de Hodgkin que con más frecuencia se presenta en mujeres y presentan ensanchamiento mediastínico (lo que se ve en la radiografía) es la variedad de esclerosis nodular.

16. Pregunta vinculada a la imagen nº 16:

Recién nacido prematuro de 3 horas de vida que presenta cianosis persistente, con hipoxemia, que mejoran escasamente con O2 al 100%. La radiografía de tórax se muestra en la imagen 16. Señale la respuesta correcta:

1. El niño presenta una enfermedad de la membrana hialina.
2. Debe instaurarse una terapia intravenosa con prostaglandina E1 para mantener permeable el conducto arterioso.
3. El paciente reúne todos los criterios de insuficiencia cardíaca neonatal.
4. El tratamiento de elección inicial es la ventilación mecánica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La Tetralogía de Fallot incluye: Estenosis de la arteria pulmonar, comunicación interventricular (CIV), acabalgamiento aórtico e hipertrofia del ventrículo derecho. Lo que determina la clínica y pronóstico son la EP y la CIV. El diagnóstico del Fallot suele realizarse en el periodo neonatal, siendo el soplo sistólico rudo precordial (secundario a EP) el signo que con más frecuencia motiva la valoración cardiológica. Ocasionalmente, el cierre del ductus provoca la aparición de cianosis en los primeros días de vida, si la EP es muy severa. Este sería nuestro caso. Recordad que las crisis hipoxémicas características aparecen tras el llanto o maniobras de Valsalva. La cianosis ocurre por el paso de sangre desaturada del VD al VI (y aorta) a través de la CIV, causando cianosis. El paso de sangre desaturada a la circulación sistémica (cianosis) es tanto mayor cuanto más severa sea la EP. El ECG puede mostrar signos de hipertrofia del VD y en la Rx AP de tórax es muy característico el corazón "en zueco o en bota" (por la hipertrofia del VD) y oligohemia pulmonar (pulmón hiperclaro), fundamentalmente por la estenosis pulmonar. El ecocardiograma doppler es el método diagnóstico de elección (objetiva las lesiones anatómicas y su severidad) La mayoría de los Fallots no requieren tratamiento en el periodo neonatal y pueden darse de alta al domicilio con revisiones cardiológicas frecuentes. El uso de prostaglandinas es obligado en aquellos casos con EP severa que presentan cianosis al cerrarse el ductus (como es el caso de nuestro paciente).

17. Pregunta vinculada a la imagen nº 17:

Un niño de 10 años de edad tiene lesiones muy pruriginosas como las que se muestran en la imagen. También las tiene en la flexura de los codos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Un eczema microbiano.
2. Un eczema seborreico.
3. Un prurigo nodular.
4. Una dermatitis atópica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica que se asocia a otras manifestaciones de atopia (asma, rinoconjuntivitis...) y cursa con aumento de IgE. Las lesiones son ecematosas y destacan por la liquenificación. En el lactante aparecen en cara y respetan la zona del pañal, en el niño en flexuras (asociándose queilitis descamativa en labios en ocasiones) y en adultos en flexuras, manos y pies.

18. Pregunta vinculada a la imagen nº 18:

Le llaman de paritorio por un recién nacido de 32 semanas de edad gestacional. A su llegada el paciente se encuentra polipneico a unas 80 respiraciones/minuto, con quejido espiratorio audible sin fonendoscopia, aleteo nasal moderado, tiraje intercostal y cianosis marcada. Decide administrarle oxígeno para mantener saturaciones en torno al 90%. La dificultad respiratoria continua con empeoramiento progresivo. En el pH se objetiva una acidosis mixta con retención de carbónico por lo que finalmente se decide iniciar ventilación asistida. Una vez estabilizado el paciente, se le realiza una radiografía de tórax que se muestra en la imagen. ¿Cuál es la patología que sospecha?:

1. Taquipnea transitoria del recién nacido.
2. Síndrome de aspiración meconial.
3. Enfermedad de membrana hialina.
4. Neumonía neonatal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Tanto la clínica como la radiología son típicas de un Síndrome de distrés respiratorio neonatal o enfermedad de membrana hialina. El antecedente de PREMATURIDAD nos tiene que hacer sospecharla rápidamente (el 30% de RNPT de entre 28 y 34 semanas la padecen y hasta el 80% de RNPT < de 28 semanas!). En la radiografía de tórax es típico hallar infiltrados opacos homogéneos difusos con patrón reticulogranular y broncograma aéreo. En casos graves (como es nuestro caso) se puede encontrar una imagen de pulmón blanco (velamiento difuso de ambos campos pulmonares que borra la silueta cardiopulmonar). Opción 3 correcta. En cuanto a la neumonía: muchas veces es muy difícil distinguirla de una

EMH, pero lo normal es que aparezca a partir de las 6 horas de vida y no desde el primer momento del nacimiento. En el enunciado nos darían algún dato de infección (leucocitosis con neutrofilia y PCR elevada). En la "vida real" no es raro que un paciente con EMH desarrolle una neumonía o que la dificultad para distinguir ambos cuadros nos obliguen a iniciar antibioterapia.

19. Pregunta vinculada a la imagen nº 19:

Acude a su consulta una mujer de 45 años remitida por hallazgo en la mamografía de la imagen que se muestra a continuación. La exploración mamaria es anodina pero en la axila palpa una adenopatía de 2 cm fija a planos profundos. Realiza una PAAF del ganglio que es informada con infiltración del mismo por células metastásicas. ¿Cuál es su actitud diagnóstico-terapéutica?:

1. Realizo mastectomía y linfadenectomía axilar.
2. Realizo BAG de la lesión mamaria.
3. Realizo tumorectomía guiada por ROLL de la lesión mamaria y linfadenectomía axilar.
4. Realizo tumorectomía guiada por arpón de la lesión mamaria y ganglio centinela.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La pregunta plantea una sospecha de cáncer de mama (nódulo espiculado de bordes mal definidos en la mamografía) y una adenopatía axilar con diagnóstico de metástasis. Para confirmar la naturaleza maligna de la lesión mamaria debemos realizar una biopsia. Como la lesión no es palpable (nos dicen que la exploración es anodina) debemos buscar una opción en la que la técnica localice la lesión (opciones 1 y 2 falsas). Por otra parte como ya sabemos que la axila es positiva para metástasis no está indicada la realización de ganglio centinela y por tanto haremos directamente la linfadenectomía (opción 3 correcta).

20. Pregunta vinculada a la imagen nº 20:

¿Qué dato de la imagen le llama la atención y con cuál de las patologías mencionadas la relacionaría?:

1. Linfocitosis – Leucemia linfática crónica.
2. Mielemia – Leucemia mieloide crónica.
3. Dacriocitos – Mielofibrosis.
4. Blastos – Leucemia aguda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se detectan hematíes en lágrima y además en la imagen prácticamente no hay células, podrías sospechar pancitopenia. El resto de las asociaciones son correctas pero no se relacionan con la imagen.

21. Pregunta vinculada a la imagen n° 21:

Varón de 23 años que acude en repetidas ocasiones a su MAP refiriendo molestias urinarias y dolor pélvico que se incrementa con los cambios posturales. Éste le solicita una ecografía abdomino-pélvica ambulatoria en la que no se encuentran alteraciones y una analítica de orina que muestra hematuria microscópica por lo que es derivado al S. de Urología. Revalorado el caso se decide ampliar el estudio de imagen y se solicita una RM abdomino-pélvica. Con respecto a los hallazgos de la RM elige la opción más adecuada:

1. Nos encontramos ante un Sd. de Wilkie o Sd. de la arteria mesentérica superior.
2. Se aprecia una dilatación de la vía excretora izquierda.
3. No se aprecian alteraciones en la RM.
4. Se aprecia una estenosis de la vena renal izquierda o Sd. del cascanueces.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la RM se aprecia una estenosis focal de la vena renal izquierda a su paso entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Hallazgo que en asociación con los síntomas característicos de hematuria y dolor abdominal es denominado Sd. del cascanueces. Al igual que el Sd. de Wilkie o Sd. de la arteria mesentérica superior, ocurre más frecuentemente en pacientes delgados, con poca grasa mesentérica y por lo tanto un ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior por debajo de la normalidad. Sin embargo no debemos confundirnos entre ambos, ya que el Sd. del cascanueces presenta clínica urinaria por compresión de la vena renal izquierda y el Sd. de Wilkie clínica intestinal por compresión duodenal.

22. Pregunta vinculada a la imagen n° 22:

Paciente varón de 27 años en el día +6 de un Alo-TPH como tratamiento de LMA diagnosticada recientemente. Actualmente en neutropenia absoluta. No otras comorbilidades. No incidencias en el acondicionamiento ni en el periodo inmediatamente posterior al trasplante, más allá de que desde hace 4 días se objetiva leve hinchazón a nivel periungueal en el primer dedo del pie derecho que ha ido en aumento. Hace 48h el paciente debuta con pico febril, por lo que se extraen HC, cultivos de catéteres y se inicia cobertura empírica con Meropenem y Vancomicina. Actualmente persiste la fiebre, la región eritematosa a nivel del dedo del pie se ha tornado negruzca y desde el día de ayer el paciente presenta lesiones cutáneas diseminadas que en el día de hoy han progresado hasta adquirir el aspecto que se muestra en la imagen

adjunta. Los cultivos de catéter y HC por el momento son negativos a las 24h. ¿Cuál sería su sospecha clínica y actitud a tomar?:

1. El cuadro es diagnóstico de infección diseminada por *P. aeruginosa* con lesiones de ectima gangrenoso. Probablemente se trate de una cepa resistente. Retiraría Vancomicina y rotaría Meropenem a Ceftazidima.
2. La falta de respuesta a la antibioterapia empírica y las lesiones son sugerentes de toxicodermia secundaria a los tratamientos de soporte. Revisaría los fármacos que tenga prescritos el paciente e intentaría realizar todos los cambios viables sin alterar en lo posible su tratamiento hematológico.
3. Las lesiones cutáneas y la falta de respuesta a antibióticos hacen pensar en una candidiasis diseminada. Seguramente el foco sea el catéter central empleado para el tratamiento de acondicionamiento. Ampliaría cobertura con Fluconazol y obtendría biopsia de las lesiones cutáneas.
4. Las lesiones cutáneas típicas y la falta de respuesta a antibioterapia hacen sospechar una infección fúngica diseminada, posiblemente una fusariosis. Ampliaría cobertura con Anfotericina-B y plantearía la obtención de alguna muestra cutánea biológica adicional.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Explicación: la opción 1 podría encajar con el cuadro descrito, pero aún en caso de plantear dudas el cambio de antibiótico propuesto no es el adecuado; además el cuadro no es "diagnóstico". La opción 2 no es lo primero a descartar en esta situación ni justifica la lesión a nivel del pie. Opción 3: podría ser correcta, pero sigue sin explicar el debut como lesión localizada en el pie y el foco en el catéter es menos probable con cultivo de catéter negativo a las 24h. Opción 4: Cuadro poco frecuente pero típico de fusariosis diseminada en paciente hematológico con neutropenia profunda, clásicamente con foco a nivel de uña del pie. Ante la ausencia de respuesta a antibióticos y el cuadro cutáneo característico hay que sospecharla y asociar Antifúngico de amplio espectro cuanto antes, ya que la evolución es fulminante.

23. Pregunta vinculada a la imagen n° 23:

Recién nacido a término, sin antecedentes familiares de interés. Apgar 8/10 al primer minuto, y 10/10 a los 5 min, o le realiza a edad gestacional. La adecuada a la edad gestacional, de esta enfermedad son debidos a mutaciones de novo buen estado general y peso y talla adecuados a la edad gestacional. En cuanto a la exploración física, únicamente destaca la presencia de unas pequeñas máculas hipocrómicas a nivel del

tronco. Se le realiza, a las 24 horas de nacimiento, un ecocardiograma (ver imagen), para confirmar la existencia de una serie de lesiones observadas en la ecografía del tercer trimestre. Ante los hallazgos observados, y su diagnóstico de presunción, señale la INCORRECTA:

1. Generalmente, las lesiones observadas en la imagen remiten espontáneamente.
2. Se trata, muy probablemente, de mixomas cardíacos múltiples.
3. Un alto porcentaje de pacientes afectados de la patología sospechada desarrollarán epilepsia.
4. Debemos realizar estudios complementarios que descarten como posible etiología una enfermedad hereditaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La presencia de varias tumoraciones cardíacas en un neonato son sugestivas de rabdomiomas, los tumores cardíacos primarios más frecuentes en niños (respuesta 2 es la incorrecta). Estas lesiones suelen remitir espontáneamente (respuesta 1 verdadera); requiriendo tratamiento quirúrgico únicamente aquellos que suponen obstrucción al flujo o alteraciones en la conducción cardíaca. Ante la presencia de probables rabdomiomas cardíacos múltiples en un neonato, es mandatorio descartar esclerosis tuberosa, incluso en ausencia de antecedentes familiares, ya que >60% de casos de esta enfermedad son debidos a mutaciones de novo. Asimismo, la presencia de máculas hipocrómicas orienta también dicho diagnóstico (respuesta 4 verdadera). Cabe recordar que la esclerosis tuberosa se caracteriza por la tríada clásica de Epilepsia, retraso mental y Angiofibromas (EPILOIA) (respuesta 3 verdadera).

24. Pregunta vinculada a la imagen nº 24:

Mujer de 33 años acude a urgencias por un síndrome febril acompañado de cervicalgia y artralgias generalizadas, se objetiva bacteriuria y es dada de alta con tratamiento antibiótico por la infección de orina. A las 48 horas acude de nuevo a urgencias, persiste la fiebre, y allí cursa con deterioro del nivel de conciencia, inapetencia, somnolencia y dos crisis tónico-clónicas generalizadas, es ingresada en la UCI con el diagnóstico de estatus epiléptico. Resto de la exploración física anodina. En la analítica neutropenia y trombopenia; aumento de LDH, CK, GOT y GPT; orina y coagulación normales. Serología negativa para los virus estudiados, en el LCR solo destaca una leve elevación de las proteínas. En LCR: virus (negativo para VHS, VHZ, VEB y CMV), anticuerpos negativos (Ac antifisina, Ac antiGAD, Ac antiYo, Ac antiHu, Ac anitRi, Ac antiCV2/CRMP5, Ac antiMa2/Ta, Ac antiLGI1 y Ac antiGABAr). En el TC craneal no se objetivan hallazgos reseñables, pero presenta

la imagen de RM que se adjunta. ¿Cuáles son el diagnóstico y tratamiento más adecuado de la paciente?:

1. Posible brote de Esclerosis múltiple. Administrar glucocorticoides a dosis de 1 g/día i.v. entre 3-5 días y continuar con pauta descendente.
2. Posible Encefalitis autoinmune. Comenzar con glucocorticoides a dosis de 1 g/día i.v. entre 3-5 días, continuar con inmunoglobulinas, plasmaféresis, y añadir rituximab y ciclofosfamida, según evolución.
3. Posible Meningoencefalitis herpética. Administrar Aciclovir oral 14 días si confirma VHS en estudios posteriores.
4. Posible Ictus hemorrágico. Control tensional, glucémico y de la temperatura corporal. Plantear a neurocirugía la posibilidad de evacuación quirúrgica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La encefalitis es una inflamación del cerebro, que se presenta con alteración del nivel de conciencia y una serie de síntomas y alteraciones en las pruebas neurológicas. Tiene múltiples causas y un complejo diagnóstico diferencial. Una vez descartadas las causas infecciosas hay que tener en cuenta causas autoinmunes, cada vez diagnosticadas con más frecuencia. En el caso de la encefalitis autoinmune, hasta en el 40% de los casos no se detectan los anticuerpos implicados (como en nuestro caso). Por lo tanto, la sospecha diagnóstica debe venir dada por la clínica y en pruebas sugerentes como la RM, la EEG o la punción lumbar. El tratamiento debe ser instaurado precozmente y siguiendo los escalones terapéuticos que se recogen en la respuesta número 2. En la imagen de RM (T2/FLAIR) se observa: aumento de señal bilateral y simétrica en la zona medial de ambos lóbulos temporales, hipocampo y tálamo. Además, descartamos la opción 1 (el cuadro no es el típico de la esclerosis múltiple, y la imagen de RM típica de la EM se observan placas desmielinizantes periventriculares), la opción 3 (aunque la encefalitis herpética sea el principal diagnóstico diferencial, el cuadro sintomático no aporta datos sobre afectación meníngea; además el tratamiento debería ser empírico e intravenoso), la opción 4 (no tiene ni clínica, ni imagen compatible con un ictus hemorrágico, además de la edad joven de la paciente, no se dice nada de hipertensión arterial y en la imagen no vemos malformaciones vasculares).

25. Pregunta vinculada a la imagen nº 25:

Un joven alpinista de 24 años acude a mediados de agosto a urgencias porque desayunando nota que no puede contener líquidos en la boca. En urgencias se objetiva una parálisis facial que afecta a la mitad inferior izquierda de la cara. Se decide hacer una resonancia magnética que se expone en la imagen 1. Permanece ingresado

y a las 3 horas del ingreso la parálisis evoluciona hasta afectar a toda la hemicara izquierda. El paciente no refiere antecedentes médicos de interés. Ante la nueva situación actual y con los resultados de la resonancia, que realizaría a continuación:

1. Realizaría una fibrinólisis sospechando un ictus isquémico.
2. Diagnosticaría una parálisis de Bell y daría el alta con control en consulta de neurología.
3. Realizaría una serología en LCR y suero sospechando una borreliosis.
4. Realizaría una punción lumbar esperando encontrar una disociación albúmino-citológica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un caso de una parálisis facial que, aunque de inicio parece ser de origen central acaba evolucionando a periférica, es común que esta última se presente de forma más lenta y en fases iniciales pueda confundir con un ACV, algo que no corresponde con nuestro paciente ni con una edad tan joven (respuesta 1 falsa). La resonancia puede ser algo difícil de interpretar ya que muestra una imagen hiperintensa en T2 a nivel del VII par izquierdo (n. facial), lo cual indica inflamación. Esto puede ser difícil de observar, pero no se nos puede escapar la asimetría entre el par derecho e izquierdo, por lo que no nos podemos quedar tranquilos con una parálisis de Bell (respuesta 2 falsa). La disociación albúmino-citológica es propia del Guillain-Barré, sin embargo, no tenemos la típica clínica de asimetría ascendente o algún antecedente infeccioso, ni tampoco obtendríamos estos resultados en el debut de la enfermedad (respuesta 4 falsa). Por último, nos queda la enfermedad de Lyme (B. Burdogferi) que es la que ha causado este cuadro. Tenemos que recordar que en el MIR no nos dan datos que no sean necesarios, y el hecho de que nos cuente que es una persona joven, alpinista y en verano tiene que hacernos sospechar de esta posible patología transmitida por garrapatas, frecuentes en zonas montañosas tanto de España como de los Alpes (origen además de la palabra alpinista). Hubiera ayudado que nos hubieran comentado los antecedentes del eritema migratorio, pero como ya indica el manual de infecciosas, el Lyme puede debutar con una parálisis facial periférica sin antecedentes del eritema (20% de los pacientes no lo presentan).

26. Pregunta vinculada a la imagen nº 26:

Varón de 66 años ingresado por un cuadro de dolor latero-cervical izquierdo con irradiación hemicraneal del mismo lado, de meses de evolución. Se ha descartado que sea neurálgico, no presenta cortejo vegetativo ni focalidad neurológica, y se mantiene durante varios minutos. Los episodios han ido aumentando en frecuencia e intensidad. Empeoran con la maniobra de Valsalva e interfieren con el

sueño. Además, tiene antecedentes neurológicos de cefaleas recurrentes desde hace 10 años, compatibles con migrañas. No tiene alergias medicamentosas conocidas ni consume tóxicos. Presenta hipertensión arterial sin tratamiento. Padece celulitis en la extremidad inferior izquierda con linfedema residual. Se ingresa en Neurología y se realiza control de tensión arterial, no observándose mejoría de las cefaleas. Se realiza una RM cerebral en la cual se observa una ventriculomegalia sin otras alteraciones. La angioRM del polígono de Willis es normal. Finalmente se identifica en la RM de columna una lesión tumoral, localizada en el fondo de saco tecal, afectando a los últimos segmentos de la cola de caballo (L5-S1), con unas dimensiones de 5,3cm x 2cm. ¿Cuál de los siguientes supuestos sería MÁS probable encontrar en este paciente?:

1. Se trata de un tumor extradural, dentro de los cuales las más frecuentes son las metástasis.
2. Impresiona de tumor intrarraquídeo, siendo el glioblastoma multiforme el primario más frecuente en esta localización y edad.
3. Debido al buen estado general del paciente, el hallazgo es un tumor benigno que precisará de tratamiento médico conservador y valorar evolución.
4. Podría tratarse de un tumor primario como un ependimoma o meningioma, sin poder descartarse otros procesos como metástasis o tumores hematológicos debido a la edad del paciente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Parrafada de enunciado que simplemente viene diciendo que el paciente aparte de sus dolores de cabeza tiene buen estado general. Podría tratarse de una metástasis de un tumor primario que ha pasado desapercibido, pero la primera impresión es más bien de un tumor no tan agresivo que pueda estar ocasionando sobre todo clínica local compresiva. Aún así no se pueden descartar procesos malignos, desde luego. Es correcta la opción 4 y no la 1 simplemente por ser más completa, la 1 es demasiado categórica. Respecto al resto: 2. El glioblastoma multiforme es el tumor primario más frecuente en esta edad, pero de localización intracraneal, siendo poco frecuente en la médula. En adultos los tumores intramedulares más frecuentes son los ependimomas. La 3 es falsa porque, aunque se tratase de un proceso benigno, está ocasionando sintomatología local, lo cual es indicación de cirugía. Además, también servirá para establecer el diagnóstico anatomopatológico y determinar si es o no maligno. De nuevo, otra respuesta demasiado categórica.

27. Pregunta vinculada a la imagen nº 27:

Estando usted en su primera guardia como residente de su hospital comarcal le llega un

paciente de 57 años de edad a urgencias al que explora minuciosamente (ver imagen adjunta) y al que encuentra aturdido, que refiere llevar unos días con “febrícula” y orinando poco, siendo la última orina de un color “algo más oscuro”. Desde el laboratorio le llegan los resultados de la analítica: Hb 8,7 mg/dl, VCM 100fl, plaquetas 22000/ul y leucocitos 8000/ul con fórmula normal y LDH alta. Ante la ausencia de otros datos clínico-analíticos y su falta de experiencia, usted se alarma con el empeoramiento del estado del paciente y decide instaurar un tratamiento lo antes posible, siendo el más adecuado en este caso:

1. Ciclofosfamida en pulsos de 4 días cada 21 días.
2. Antibioterapia de amplio espectro + diuréticos tiazídicos.
3. Usar corticoides hasta el tratamiento definitivo con plasmaféresis.
4. Transfundir unidad de plaquetas y tratamiento con hierro endovenoso, para mejorar su perfil anémico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ciertamente, estamos ante un caso que aúna conceptos importantes que no debemos olvidar de cara al MIR, tanto de la asignatura de Hematología como de Nefrología y se manifiesta externamente como algo “Dermatológico” al mismo tiempo. Si leemos el caso una primera vez lo mismo se nos vienen encima todo tipo de juicios diagnósticos al mismo tiempo (síndrome nefrítico post-infeccioso, paciente con un trastorno hematológico de base con alteración de la coagulación- ya que nos dan recuento plaquetario pero no coagulación-, tal vez una estemos ante una sepsis o incluso una reacción medicamentosa). Pero si nos detenemos en los pocos datos que tenemos veremos que una trombopenia grave asociada a alteración de la conciencia (“aturdido”) asociada a hematuria y aumento de la LDH junto a un síndrome anémico hemolítico nos darán el diagnóstico de PTT. Así pues, estableceremos sin más dilación el tratamiento con corticoides y plasmaféresis lo antes posible, dejando de lado momentáneamente otras pruebas necesarias (como la determinación de la metaloenzima ADAMTS 13) para el diagnóstico.

28. Pregunta vinculada a la imagen nº 28:

Mujer de 66 años con antecedentes patológicos de obesidad e hipertensión arterial. Sin intervenciones quirúrgicas previas. Presenta desde hace 5 días dolor intenso en hipocondrio derecho. Al tercer día de evolución, el dolor empieza a ser difuso, asociado a vómitos, distensión abdominal y ausencia de emisión de gases y heces. A la exploración física se encuentra hemodinámicamente estable, con

deshidratación moderada y normocoloreada, el abdomen está distendido con un aumento de los ruidos intestinales y dolor difuso. En la analítica destaca una leucocitosis y una ligera elevación de enzimas hepáticas. Se realiza una Rx abdominal y una TC abdominal, que se muestra en la imagen. Marca la CORRECTA respecto al manejo de la patología que presenta la paciente:

1. Debemos realizar laparotomía precoz con enterolitotomía, y una colecistectomía de manera diferida, cuando el paciente este más estable.
2. Realizaremos de manera urgente colecistectomía y cierre de la fistula bilioentérica.
3. El tratamiento consiste en realizar una enterolitotomía junto con una colecistectomía de manera precoz, para disminuir la tasa de complicaciones precoces.
4. Realizaremos en un primer momento una colecistectomía, y de manera diferida una enterolitotomía si aún persiste la litiasis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se presenta un caso de íleo biliar, ya que en la TC se observa aerobilia, una distensión del intestino delgado y una litiasis calcificada impactada a nivel de la válvula ileocecal, sugestivo de íleo biliar junto con el cuadro de obstrucción intestinal (vómitos, distensión abdominal, ausencia de emisión de gases y heces y dolor). El tratamiento consiste en una laparotomía precoz con enterolitotomía, y en un segundo tiempo, cuando el paciente esté más estable, se haría la colecistectomía, ya que asociar ambas técnicas se asocia con una mayor tasa de complicaciones postquirúrgicas.

29. Pregunta vinculada a la imagen nº 29:

Hombre de 57 años, fumador de 25 paquetes-año y bebedor habitual. Como antecedentes personales diabetes mellitus tipo 2. Intervenido hace 1 año de un adenocarcinoma de próstata con prostatectomía radical, con perforación de tabique rectal accidental durante la misma. A seguimiento por urología desde entonces con buen control. No recidivas tumorales. Trabaja como comercial para una industria farmacéutica. Se reincorporó a su trabajo hace 6 meses y acaba de llegar de un viaje desde Europa del Este. Desde hace unas semanas se viene encontrando cada vez peor, con astenia y pérdida de apetito. Ha perdido unos 6 kg en 6 meses, sin embargo ha ido notando que su “barriga no ha parado de crecer”. Acude a urgencias por mareo y síncope en su domicilio. No presenta clínica a otro nivel. Afebril. TA de 100/75 mmHg, Fc 100 l/min. Afebril. Analítica con leucocitosis. A la exploración física llama la atención un abdomen distendido y muy duro

a la palpación. Se realiza paracentesis guiada con ecografía con gran dificultad con salida dificultosa de material fibroso y purulento que acaba obstruyendo el tubo. Se realiza un TC que se muestra en la imagen. ¿Qué diagnóstico se le ocurre para el caso?:

1. Se trata de una siembra metastásica peritoneal por adenocarcinoma de próstata.
2. Se trata de una ascitis por descompensación de hepatopatía subyacente.
3. Se trata de una ascitis tabicada por anaerobios iatrogénica post-intervención de prostatectomía radical.
4. Se trata de una amebiasis peritoneal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con una ascitis tabicada por anaerobios productores de gas, que han llegado ahí a raíz de la intervención de prostatectomía durante la que se perforó accidentalmente el tabique rectal, diseminando las bacterias por el peritoneo.

30. Pregunta vinculada a la imagen nº 30:

Acude el SUMMA a urgencias con una mujer que ha sido encontrada inconsciente esa mañana del 10 de Febrero. Como antecedentes destaca insuficiencia cardíaca derecha y cirrosis alcohólica de 10 años de evolución. Se encuentra en coma arreactivo, se le realiza reanimación, motorización cardíaca (se adjunta imagen) e ingreso en UCI por presentar insuficiencia respiratoria posiblemente por broncoaspiración. FC:40 lpm, FR:15 rpm, Tª:33,5 °C, TA:105/56 mmHg. Señale la opción correcta:

1. En el ECG se puede observar que la paciente a parte de su insuficiencia cardíaca presenta una cardiopatía hereditaria llamada Síndrome de Brugada, aumentando su riesgo de muerte súbita y de episodios como el que ha sufrido hoy.
2. La paciente presenta un coma alcohólico viéndose reflejado en el ECG por las ondas r sobre R', se le debe administrar suero glucosado y posteriormente Tiamina para revertir su intoxicación.
3. La paciente probablemente ha sufrido una intoxicación alcohólica y eso explicaría su estado comatoso. Además en el ECG se pueden observar ondas J de Osborn, típicas de la hipotermia. Habría que administrar tiamina iv, suero glucosado y proceder al recalentamiento lento.
4. Su estado comatoso se debe a una posible intoxicación por opioides y alcohol. Se debe administrar Tiamina, suero glucosado y naloxona iv.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un hallazgo ECG raro pero curioso, son ondas muy características de la hipotermia. Concuerda perfectamente con los antecedentes de alcoholismo de la paciente que han podido propiciar el coma y por tanto el estado de hipotermia. Se debe tratar el coma alcohólico con tiamina y sueros, recalentar a la paciente y mantenerla en observación.

31. Paciente de 23 años sin patología previa que comienza con neumonías de repetición, trombopenia e hipogammaglobulinemia. ¿Qué diagnóstico nos sugiere?:

1. Agammaglobulinemia ligada al cromosoma X.
2. Enfermedad granulomatosa crónica.
3. Síndrome variable común de inmunodeficiencia.
4. Infección por VIH.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre las Inmunodeficiencias primarias. El dato clave es la hipogammaglobulinemia que te orienta a que la inmunidad es humoral, y el comienzo a edad más tardía. Como idea general, la mayoría de las IDF (inmunodeficiencias) primarias son congénitas, y la mayoría de las secundarias son adquiridas, pero existen excepciones. Este es el caso de la IVC (opción 3 verdadera). De la IVC (Inmunodeficiencia Variable Común) hay dos cosas que no se te deben olvidar: 1.- Es una inmunodeficiencia humoral 2.- Es de las pocas inmunodeficiencias, que siendo primaria (intrínseca, sin causas exógenas que la justifiquen), es de tipo adquirido (es decir, que no aparece hasta la infancia o adolescencia). La agammaglobulinemia ligada al X (Bruton) se da desde el primer año de vida (opción 1 falsa). Afinando más, recuerda que, la IVC es la segunda inmunodeficiencia primaria más frecuente, tras el déficit de IgA. En la IVC el número de linfocitos B suele ser normal; sin embargo, la alteración se encuentra en el paso de estos a células plasmáticas, que son las verdaderas productoras de anticuerpos. Por ello hay, lógicamente, hipogammaglobulinemia secundaria, e hiperplasia de los folículos linfoides. Existe en estos pacientes una alta tasa de enfermedades autoinmunes, como la anemia perniciosa y la aclorhidia gástrica; quizás sean éstas motivo de la también alta tasa de carcinomas gástricos. La trombopenia es de causa autoinmune; aunque no es específica de la IVC, los fenómenos autoinmunes, son muy frecuentes en las Inmunodeficiencias primarias. Bien es cierto, que cada vez se relaciona más con el EBV y de ahí la alta tasa de Linfomas que se dan estos pacientes.

32. Supongamos un modelo de regresión lineal simple que relaciona los niveles medios de Proteína C Reactiva (PCR) medida en mmol/L como variable dependiente con el número de articulaciones dolorosas o hipersensibles de un paciente con artritis idiopática (variable

independiente). El modelo ajustado en una muestra de 100 pacientes es el siguiente: $y = 0,47 + 0,08x$ En el modelo. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de 0,08?:

1. Dado que es superior a 0,05, quiere decir que no existe asociación entre las variables dependiente e independiente.
2. Es el cambio obtenido en la media de PCR como consecuencia de pasar a tener una articulación adicional inflamada.
3. Es el valor medio de la PCR para los sujetos con una sola articulación afecta.
4. Su cuadrado se interpreta como el porcentaje de varianza de la variable dependiente explicado por el modelo lineal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la regresión lineal simple se obtiene una ecuación del tipo: $y = a + bx$ En esta ecuación la "x" es la variable independiente, la "y" es la variable dependiente, "a" es el punto de corte entre el eje de ordenadas y la recta, dicho de otro modo, el valor de "y" cuando "x"=0, y "b" es la pendiente de la recta. El coeficiente de 0,08 de esta pregunta se corresponde con la "b" de la ecuación, esto es, equivale a la magnitud del cambio de "y" para cada unidad de cambio de "x" o, como dice la opción 2, "el cambio obtenido en la media de PCR como consecuencia de pasar a tener una articulación adicional inflamada".

33. En el diseño y realización de un ensayo clínico debemos tener en cuenta diversos factores a la hora de determinar los objetivos y variables de evaluación que vamos a establecer. Señale la respuesta correcta:

1. Debemos establecer tantos objetivos y variables principales de evaluación como deseemos evaluar.
2. Si queremos evaluar resultados válidos y significativos desde el punto de vista clínico, la utilización de variables intermedias en un método ideal y carente de sesgos.
3. La utilización de escalas de evaluación multidimensionales (por ejemplo las de calidad de vida) tiene la ventaja de ser clínicamente más relevante pero puede tener problemas de validación y ser de difícil interpretación.
4. A lo largo del desarrollo de un nuevo fármaco (Fases I a IV) la variable principal de evaluación de los diferentes ensayos clínicos realizados debe ser la misma para permitir la consistencia en la evaluación de la eficacia del fármaco.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Según el tipo de observación, las variables utilizadas en los ensayos clínicos pueden ser objetivas (ej. recuento

leucocitario, TAS, índice de Tiffeneau) o subjetivas (ej. cuestionarios). Entre las pruebas de medición subjetivas, las escalas de evaluación multidimensionales (utilizadas en psiquiatría, en evaluación de alteraciones musculoesqueléticas, etc) son útiles por su alta relevancia clínica pero, entre otros, pueden tener problemas de validación, es decir, dificultades para demostrar que son válidas, en el sentido de ser capaces de medir aquellas características que pretenden medir.

34. Paciente de 3 meses con linfopenia, neumonía por *Pneumocystis Carinii* junto con muguet de repetición e incapacidad para ganar peso. El diagnóstico más probable es:

1. Deficiencia en moléculas de adhesión.
2. Inmunodeficiencia combinada grave.
3. Síndrome variable común de inmunodeficiencia.
4. Enfermedad granulomatosa crónica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla sobre las inmunodeficiencias primarias. El dato de que las infecciones comienzan a los 2 meses de vida es clave para diferenciar entre inmunodeficiencias primarias humores (que dan la cara entre los 6 y 12 meses) y las celulares (o combinadas), como la de nuestra paciente, que dan la cara antes, al no estar protegidos por las Ig de la madre. El tipo de microorganismo ya es definitivo, porque los hongos (candidiasis oral o muguet) y las infecciones por parásitos (*Pneumocistis*), orientan por completo a que se trata de una inmunodeficiencia celular. Con este dato ya podemos contestar la pregunta, ya que el resto de las opciones no son inmunodeficiencias celulares como tal. La IVC (opción 3) son inmunodeficiencias humores. La Enfermedad granulomatosa crónica y el déficit de moléculas de adhesión (opciones 1 y 4) pertenecen al grupo de las Inmunodeficiencias por alteración de la fagocitosis; la primera por alteración de la capacidad bactericida de los fagocitos (déficit de NADPH oxidasa) y la segunda por alteración de la quimiotaxis. No olvides, que a efectos prácticos, todas las inmunodeficiencias celulares son combinadas severas, es decir, podemos intercambiar los términos.

35. En relación con el diseño y realización de un ensayo clínico, señale la respuesta INCORRECTA:

1. El denominado "análisis por protocolo" puede incurrir en sesgos debidos a las pérdidas durante el estudio.
2. Los estudios con controles históricos tienden a sobrevalorar la eficacia del fármaco experimental, debido a las cointervenciones.
3. En el análisis de un ensayo clínico se debe hacer el máximo número posible de análisis intermedios de la variable principal porque así se aumenta la probabilidad de obtener un resultado positivo en el ensayo.

4. El ensayo clínico cruzado es muy sensible a las pérdidas de sujetos durante la realización del mismo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

A lo largo de la fase III de un ensayo clínico es conveniente, en ocasiones, realizar una comparación estadística entre los grupos de estudio antes de que se complete el tiempo establecido para dicha fase. El propósito de este análisis intermedio es detectar diferencias importantes entre los grupos que puedan hacer aconsejable detener el estudio y así poder, cuanto antes, solicitar la aprobación para el uso del nuevo fármaco. Pero, si bien esto es cierto, es falso que “en el análisis de un ensayo clínico se debe hacer el máximo número posible de análisis intermedios de la variable principal”, ya que eso acarrearía un problema de validez al aumentar, con tanta comparación estadística, la probabilidad de obtener algún resultado FALSO positivo, es decir, de cometer un error tipo I.

36. Con respecto a la utilización de analgésicos opioides en enfermos con cáncer en situación paliativa. Indique la respuesta INCORRECTA:

1. El estreñimiento es un efecto secundario casi constante por lo que se debería utilizar un laxante para evitar su aparición.
2. Su uso continuado requiere aumentar la dosis administrada para obtener el mismo efecto analgésico debido a fenómenos de tolerancia y sobre todo a la progresión de la enfermedad.
3. La depresión respiratoria es un efecto secundario frecuente dada la disfunción orgánica que presentan estos pacientes.
4. La morfina no tiene techo terapéutico por lo que no existe una dosis máxima que no pueda sobrepasarse si lo requiere el paciente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El objetivo fundamental de los cuidados paliativos es no abandonar y controlar todos los síntomas del enfermo y su familia, ayudando en el proceso de pérdidas continuas y del duelo. Uno de los síntomas más importantes de controlar es el dolor del paciente oncológico. El tratamiento farmacológico debe realizarse en base a la escalera analgésica de la OMS (AINES; opiáceos débiles, opiáceos potentes, con o sin coadyuvantes). La administración de los analgésicos debe hacerse de forma regular (pautada) para evitar que aparezca el dolor y dosis de rescate (a demanda) si aparece. Los opiáceos, a diferencia de los AINES, no tienen techo analgésico por lo que no existe una dosis máxima (RESPUESTA 4 CORRECTA). Además la depresión respiratoria es muy poco probable en el paciente Terminal, siendo el dolor un potente antagonista de la depresión respiratoria (RESPUESTA 3 INCORRECTA). Los opiáceos presentan fenómeno de tolerancia (cada vez hace falta más dosis para el mismo efecto), a lo que hay que

sumar la necesidad de mayor dosis porque la enfermedad va progresando. (RESPUESTA 2 CORRECTA) El estreñimiento es uno de los efectos adversos más frecuentes que aparecen en los pacientes terminales, entre otras cosas, por el uso de opiáceos por lo que se recomienda emprender las medidas profilácticas con el uso de laxantes cuando se usen los opiáceos (RESPUESTA 1 CORRECTA).

37. Una de las siguientes afirmaciones con respecto a la aleatorización es INCORRECTA:

1. El proceso de asignación aleatoria debe estar documentado en todos sus pasos.
2. La aleatorización permite que la asignación de cada paciente incluido en el ensayo clínico sea impredecible.
3. En el caso de un ensayo con aleatorización 1:1, todos los participantes tienen las mismas probabilidades de ser asignados a uno u otro de los grupos en estudio.
4. La aleatorización asegura totalmente la homogeneidad entre los grupos en comparación ya que este es su objetivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El objetivo de la aleatorización es que los distintos grupos de estudio sean iguales en todo excepto en la variable estudiada (por ejemplo: fármaco Vs placebo), dicho de otro modo, que los grupos de estudio sean homogéneos. Pero, aunque eso es lo que se pretende con la asignación aleatoria o randomizada, en ocasiones el azar nos juega una mala pasada y los grupos configurados difieren de forma llamativa en alguna de las características basales, por lo que no podemos afirmar que “la aleatorización asegura totalmente la homogeneidad entre los grupos en comparación”. Además, la existencia de factores de confusión no se evita con la aleatorización. Por ejemplo, si queremos realizar un estudio con un grupo de alcohólicos y otro de no alcohólicos para ver el riesgo de cáncer de orofaringe en ambos, nos encontraremos que en el grupo de alcohólicos hay mayor porcentaje de fumadores, independientemente de que haya aleatorización. Es por esto que la aleatorización minimizará el riesgo de factores de confusión, pero no puede evitarla completamente.

38. Los resultados de los distintos estudios observacionales (cohortes, casos y controles) llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos han sido: fármaco A: OR (IC95%): 4,0 (2,5-7,2) fármaco B: RR (IC95%): 2,1 (0,85-3,9) fármaco C: RR (IC95%): 0,7 (0,4-0,85) fármaco D: OR (IC95%): 3,0 (2,2-9,1) Si asumimos que A, B, C y D tienen la misma eficacia, similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas y similares costes. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?:

1. Fármaco B.
2. Fármaco C.

3. Fármaco A.
4. Fármaco D.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Cuando se realiza un estudio epidemiológico se trabaja con una muestra que intenta ser representativa de la población a la que se quiere extrapolar los resultados del estudio, pero que no deja de ser una pequeña porción de esa población diana a la que queremos aplicar los resultados. Por eso, por el hecho de trabajar con muestras, nuestros resultados han de ser llevados a la población diana mediante intervalos de confianza al realizar estadística inferencial. Un intervalo de confianza del 95% es una horquilla de valores (por ejemplo de 2,5 a 7,2) entre los que, con una alta probabilidad (95 %), se encontrará el parámetro estudiado (en nuestra pregunta la OR o el RR), pero NO en nuestra muestra sino en la población diana. Veámoslo con un ejemplo: En el estudio llevado a cabo con el fármaco B el RR obtenido es de 2,1. Pero, ¿se mantendrá este RR en la población diana, es decir, en todos los sujetos que tomen este fármaco? Para saberlo, basándonos en nuestro resultado (RR=2,1) y en otros parámetros (entre los cuales el más importante es el tamaño muestral), construimos un IC 95%. En nuestro ejemplo: IC 95%= 2,1 (0,85-3,9). Como vemos, si bien en nuestra muestra el RR es mayor que 1, en la población diana no podemos decir si será mayor o menor a 1 (el intervalo de confianza incluye al 1), por lo que no sabremos qué resultados se obtendrán con el uso de este fármaco en la población diana. De los fármacos incluidos en esta pregunta, el único que presenta beneficios en la muestra (RR u OR inferior a 1, dicho de otro modo, que actúa como factor protector) y que mantiene esos beneficios al hacer la extrapolación a la población diana (IC 95% se mantiene por debajo de 1) es el fármaco C, por lo que ése sería el tratamiento de elección.

39. **¿Cuál de los siguientes datos NO forma parte del vigente conjunto mínimo básico de datos, al alta de hospitalización, aprobado por el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo?:**

1. Fecha de Nacimiento.
2. Identificación del Hospital.
3. Tipo de Hospital.
4. Diagnósticos, codificados.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El Conjunto Mínimo Básico de Datos de Hospitalización (CMBDH): un conjunto de variables obtenidas en el momento del alta que recoge datos administrativos, clínicos, demográficos y proporcionan datos sobre el paciente, su entorno, la institución que lo atiende y su proceso asistencial. En Europa en 1.982, se llega a un consenso respecto al menor número de variables a recoger. En España, en Diciembre de 1.987, el Consejo Interterritorial de Salud acuerda establecer un CMBD. Los datos que incluye son: - Identificación del Hospital (RESPUESTA 2 CORRECTA) - Identificación

del paciente - Número de asistencia - Fecha de nacimiento (RESPUESTA 1 CORRECTA) - Sexo - Residencia - Financiación - Fecha de ingreso - Circunstancia del ingreso - Diagnóstico principal y otros codificados (RESPUESTA 4 CORRECTA) - Fecha de intervención quirúrgica - Fecha de alta - Circunstancia del alta - Identificación del centro de traslado - Identificación del servicio responsable del alta.

40. **Se compara la utilidad de dos fármacos activos, A y B, en un ensayo clínico cuya variable principal es la reducción de la mortalidad asociada al infarto agudo de miocardio. Los resultados no muestran diferencias estadísticamente significativas en la reducción de la mortalidad, pero el análisis de 10 variables secundarias muestra que en una de ellas (la reducción de la estancia media hospitalaria postinfarto), el fármaco A es superior al B. ¿Qué actitud tomaría ante estos resultados?:**

1. Formular una nueva hipótesis basada en los resultados observados en las variables secundarias significativas y planificar un nuevo ensayo clínico.
2. Ajustar los resultados de mortalidad por las diferencias observadas en la estancia media hospitalaria.
3. Añadir la indicación de disminución de la estancia media hospitalaria en la ficha técnica del fármaco A.
4. Realizar un análisis por subgrupos de pacientes para determinar si la mortalidad está disminuida en alguno de ellos.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Del análisis de un ensayo clínico sólo se pueden extraer conclusiones estadísticas acerca del parámetro que haya sido considerado variable principal del estudio (en este caso la mortalidad por infarto agudo de miocardio), ya que dicho estudio ha sido diseñado para tratar de demostrar diferencias respecto a esa variable y el tamaño muestral ha sido calculado en base a ella. El análisis estadístico de variables secundarias no aporta ningún dato definitivo y, a lo sumo, puede servir para sugerir alguna asociación que, en todo caso, habrá de ser estudiada mediante la formulación de una nueva hipótesis y planificación de un nuevo ensayo clínico. En general cuando se realizan múltiples comparaciones se deberá realizar una penalización estadística, ya prefijada en el diseño.

41. **En los déficits de la inmunidad humoral (anticuerpos). ¿Qué agente de los señalados es más probable que cause infección oportunista?:**

1. Histoplasma capsulatum.
2. Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch).
3. Virus de la varicela – zoster.
4. Streptococcus pneumoniae (neumococo).

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta básica sobre las inmunodeficiencias que no puedes fallar. Recuerda que las Inmunodeficiencias humores, suelen estar causadas típicamente por gérmenes encapsulados (meningococo, neumococo, y *S. aureus*); por *Giardia lamblia*; por virus, típicamente el ECHO virus (encefalitis) (opción 4 verdadera). El resto de las opciones son gérmenes típicos de las Inmunodeficiencias celulares o Inmunodeficiencias Combinadas severas. Recuerda que en éstas son frecuentes los virus (HSV 1, CMV, VVZ...), micobacterias, hongos (*Candida*, *Aspergillus*, *Cryptococcus*...), parásitos (*Toxoplasma*, *Pneumocistis*...).

42. Mujer de 70 años, fumadora de larga evolución, consulta por tos, astenia y anorexia desde hace un año. Se realiza una radiografía de tórax objetivándose una masa pulmonar en lóbulo superior derecho. Se completa el estudio con un TAC torácico en el cual se objetiva una masa de 5,2 cm dependiente bronquio lobar superior derecho con infiltración del esófago. Se visualizan adenopatías mediastínicas izquierdas, sin objetivarse lesiones sugerentes de metastasis en los cortes aportados de hígado y suprarrenales. La actitud más adecuada para nuestra paciente sería :

1. Debemos realizar una mediastinoscopia para confirmar la malignidad de las adenopatías mediastínicas y para comprobar si existen adenopatías a otros niveles.
2. Iniciar tratamiento con quimiorradioterapia, añadiendo posteriormente durvalumab si no existe progresión tumoral.
3. Al tratarse de un cáncer de pulmón avanzado debemos iniciar tratamiento sistémico dirigido a mutaciones diana.
4. La primera opción es realizar una resección tumoral con intención curativa.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sobre cáncer de pulmón. Lo primero es realizar una estadificación TNM correcta. Nos hablan de un tumor de 5,2 cm, el cual por tamaño sería un T3, pero nos dicen que invade el esófago, por tanto, automáticamente pasa a ser un T4. Nos describen adenopatías mediastínicas contralaterales (el tumor se encuentra en el lóbulo superior derecho, y nos colocan adenopatías mediastínicas izquierdas), por tanto, estamos ante un N3. Nos comentan que no presenta metastasis, por tanto: T4 N3 MO siendo este un estadio IIIC. El tratamiento de elección de los estadios IIIB y IIIC es quimiorradioterapia, ya que son estadios no reseables. Si tras la administración de quimiorradioterapia no se objetiva progresión tumoral, las guías de práctica clínica de cáncer de pulmón recomiendan dejar tratamiento de mantenimiento con durvalumab, un anti PDL-1 (respuesta 2 correcta).

Respecto a la 1, al ser un estadio tumoral no candidato a cirugía, ya que se trata de un tumor con infiltración esofágica, no tendría sentido exponer al paciente a una técnica invasiva. La opción 4 también es incorrecta ya que la cirugía sobre tumores que infiltran el esófago se realiza con intención paliativa, no curativa. El cáncer de pulmón avanzado es aquel en estadio IV (metastásico), en el cual, la primera opción de tratamiento consistirá en fármacos contra mutaciones diana (opción 4 incorrecta).

43. Un ensayo clínico sobre 3000 pacientes compara un nuevo fármaco antihipertensivo con placebo (1500 pacientes por rama de tratamiento). Para cada grupo, se obtiene un valor medio de tensión arterial. Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas, se debe realizar la siguiente prueba:

1. La ji-cuadrado de Pearson.
2. La t de Student.
3. La F de Snedecor.
4. La U de Mann-Whitney.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Para estudiar si la administración de un fármaco es eficaz en la reducción de la tensión arterial podemos manejar la variable respuesta de dos maneras: a) Cualitativamente: disminuye o no disminuye la tensión arterial. b) Cuantitativamente: descenso en mm de Hg de la tensión arterial. En este caso se dice que “se obtiene un valor medio de tensión arterial” (variable respuesta cuantitativa), por lo que, al tratarse de dos grupos (variable dicotómica) el test más adecuado es: T de Student para datos independientes. Si en vez de registrar el descenso de la TA, se hubiese registrado sólo si este parámetro mejoraba o no (variable respuesta cualitativa), el test más adecuado hubiese sido la ji-cuadrado.

44. Las mutaciones del gen GJB1 situado en la región cromosómica Xq13.1 son causa de una neuropatía hereditaria denominada CharcotMarieTooth tipo CMT1X. Un paciente de 25 años diagnosticado de CMT1X (caso índice) y al que le hemos hallado una mutación validada clínicamente acude a la consulta de consejo genético con sus dos hijos por el momento clínicamente sanos: un niño de 1 año y una niña de 3. ¿Cuáles familiares directos deben ser portadores obligados de la enfermedad y en los que indicaremos pruebas genéticas para estudiar su transmisión a la descendencia?:

1. La niña de 3 años y la madre del caso índice.
2. El hijo de 1 año.
3. La niña de 3 años.
4. La esposa del caso índice.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Lo más importante es observar que el caso índice es un varón y que la enfermedad se localiza en el cromosoma X, por lo que se trata de una enfermedad de HERENCIA LIGADA AL SEXO. Hay que tener en cuenta que las hembras poseen dos alelos para cada gen, pudiendo ser homocigota o heterocigota mientras que los varones sólo poseen uno, por lo que son hemicigotos. Por lo tanto, nuestro caso índice al ser XY, presentará mutación en la única copia X que posee, de tal forma que los varones afectados (hemisigotos) transmitirán el cromosoma X afecto al 100% de sus hijas y a ninguno de sus hijos. De igual forma no nos podemos olvidar que nuestro caso índice ha recibido el cromosoma X afecto de su madre, que será portadora obligada también, por lo que los portadores obligatorios son la madre del paciente y su hija de 3 años.

45. El resultado de un electrocardiograma de esfuerzo, para la predicción de una enfermedad coronaria, cambia si se varían los milímetros de depresión del segmento ST que definen el resultado anormal. Si se considera como resultado anormal a partir de los 2 mm de depresión del segmento ST en lugar de a partir de 0,5 mm. Señala la respuesta correcta:

1. La sensibilidad aumenta.
2. Es necesario representar los falsos negativos frente a los verdaderos negativos en una curva ROC.
3. La especificidad aumenta.
4. Los falsos positivos aumentan.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Si se considera como resultado anormal una depresión del segmento ST mayor a 2 mm en lugar de mayor de 0,5 mm, lo que haremos será aumentar la probabilidad de que las personas consideradas como positivas en el test tengan la enfermedad, es decir, aumentaremos la capacidad para detectar los sanos, aumentando la especificidad. Con esta medida reduciremos los falsos positivos (pocas personas sanas darán positivo), pero en contrapartida aumentarán los falsos negativos (enfermos que con la modificación del umbral diagnóstico ahora darán negativo en el test).

46. Una de las siguientes afirmaciones sobre las cuatro fases del desarrollo clínico de un medicamento es FALSA, señálela:

1. Las fases son consecutivas en el tiempo pero pueden superponerse.
2. Los primeros estudios que se realizan en humanos para demostrar la eficacia de un medicamento se engloban dentro de la fase I.
3. Uno de los objetivos de la fase II es establecer la relación dosis-respuesta del medicamento.
4. La utilidad en la práctica clínica se pone de manifiesto en la fase III, en la que se incluye a un número mayor de pacientes que en la fase II.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los estudios fase I son los primeros que se realizan en humanos, generalmente en voluntarios sanos y sin grupo control (por lo que no son ensayos clínicos), pero no sirven para estudiar la eficacia del fármaco, sino para el estudio de la farmacocinética y la farmacodinamia, así como para evaluar la toxicidad del mismo. En la fase II se establece la dosis terapéutica del medicamento (especialmente en la fase IIB donde se comparan diferentes dosis), y es en la fase III donde se determina su eficacia ya más similar a la efectividad al comparar los resultados del fármaco con placebo o con otro tratamiento previo, en gran número de pacientes.

47. La organela celular más implicada en la patogénesis de la apoptosis a través de la vía intrínseca es:

1. Núcleo.
2. Mitocondria.
3. Retículo endoplásmico.
4. Lisosoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La muerte celular programada o apoptosis es un modo de muerte activo y fisiológico en el que una célula diseña y ejecuta el programa de su propia muerte. El mecanismo de apoptosis se produce por la activación de una cascada de proteasas intracelulares (caspasas) que se activan sucesivamente y liberación de moléculas desde la MITOCONDRIA. Existen dos tipos generales de vías de señalización que permiten el inicio de la activación de caspasas iniciadoras de la muerte celular programada. La primera de ellas depende de la participación de la mitocondria (VÍA INTRÍNSECA) y la segunda implica a los receptores de muerte como son el receptor 1 de TNF (TNFR-1) y Fas (CD95). (VÍA EXTRÍNSECA O DE RECEPTORES DE LA MUERTE). La vía de los receptores de muerte y la vía mitocondrial convergen a nivel de la activación de la caspasa-3. Los principales rasgos morfológicos de la apoptosis son: -. constricción celular -. condensación de la cromatina y fragmentación del núcleo. -. formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos que contienen las organelas íntegras -. fagocitosis de los cuerpos apoptóticos -. ausencia de inflamación acompañante (diferencia más destacada con la necrosis) la necrosis se caracteriza por ser una muerte celular no programada que se caracteriza por hinchazón celular con fragmentación organelas, el núcleo permanece intacto y la destrucción final es por enzimas lisosómicos que producen gran reacción inflamatoria.

48. En relación a los estudios de bioequivalencia, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Para que se autorice la comercialización de un medicamento genérico suele ser necesario realizar un estudio de bioequivalencia en voluntarios sanos.

2. El objetivo de los estudios de bioequivalencia es demostrar que dos formulaciones del mismo principio activo tienen la misma eficacia clínica.
3. Las dos formulaciones a comparar deben de tener la misma composición cualitativa y cuantitativa en cuanto a principio activo, para que el producto pueda comercializarse.
4. Se suele emplear un diseño cruzado, de manera que un grupo de sujetos recibe primero la formulación de referencia y luego la del producto genérico, y el otro grupo la secuencia inversa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En los estudios de bioequivalencia para la autorización de fármacos genéricos, no es necesario demostrar la eficacia y la relación beneficio/riesgo del producto, siendo en la mayoría de las ocasiones suficiente con demostrar que los parámetros farmacocinéticos (T-max, C-max, AUC, vida media etc) conseguidos con el genérico no son significativamente distintos a los del producto original, es decir, un estudio de bioequivalencia persigue encontrar una diferencia que no exceda de un determinado valor establecido por el investigador, por lo que en el análisis estadístico de este tipo de estudios la Hipótesis Nula es que las dos formulaciones son diferentes. Para esto, habitualmente los parámetros farmacocinéticos deben ser como mucho $\pm 20\%$ (en un rango 80-120%) de los del producto original (aunque este rango de bioequivalencia puede variar según la entidad aprobadora. Por ejemplo, para la FDA debe ser en el rango 90-110%). La demostración de bioequivalencia permite suponer que, ante similar indicación y con la misma pauta posológica, esos productos presentarán la misma eficacia clínica.

49. Los opioides son fármacos de uso sistemático durante la anestesia. En referencia a dichos fármacos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. Reducen la concentración alveolar mínima (CAM) de los anestésicos inhalatorios.
2. Producen analgesia profunda y mínima depresión cardíaca.
3. Sólo son eficaces por vía intravenosa.
4. Pueden producir bradipnea y depresión respiratoria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los opioides son fármacos de uso sistemático durante la anestesia por sus propiedades analgésicas, sedantes y amnésicas. Otras de sus acciones más importantes a nivel CENTRAL son: bradipnea y depresión respiratoria, miosis, náuseas y vómitos, y con menor frecuencia bradicardia e hipotensión. A nivel PERIFÉRICO cabe destacar el estreñimiento y retención urinaria. La utilidad de los opiáceos se ha ampliado desde que se emplean nuevas vías

para administrarlos. La más importante es la administración medular. Los opiáceos se pueden inyectar a través de un catéter colocado a nivel intratecal o epidural. También pueden administrarse por vía intranasal (butorfanol), rectal y transdérmica (fentanilo). El parche transdérmico de fentanilo ofrece la ventaja de producir niveles plasmáticos bastante estables.

50. En un contraste de hipótesis estadístico, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara:

1. Se comete un error de tipo II.
2. Se toma una decisión correcta.
3. La potencia aumenta.
4. Se comete un error de tipo I.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El objetivo de un estudio estadístico es determinar si los resultados obtenidos son compatibles o no con la Hipótesis Nula, es decir, con la hipótesis de que los distintos grupos estudiados son en realidad iguales. Cuando los resultados obtenidos se alejan mucho de lo esperable (si la Hipótesis Nula fuese cierta) entonces se dice que hemos obtenido la suficiente evidencia como para rechazar la Hipótesis Nula. Pero siempre que rechazamos la Hipótesis Nula, estamos asumiendo una posibilidad de equivocarnos, de que ese resultado, aunque raro, viniese de grupos de estudio que son iguales. Si tratamos con dos fármacos distintos a dos grupos de enfermos, es muy raro que si la eficacia es la misma en un grupo mejoren el 25 % y en el otro el 75 %, ¿verdad? Claro, por eso “rechazamos” la Hipótesis Nula. Pero aunque ese resultado (esa diferencia) es raro, podría excepcionalmente darse aunque los dos grupos de estudio fuesen iguales (el mismo fármaco) y en ese caso (cuando rechazamos la Hipótesis Nula, pero era cierta) se dice que hemos cometido un error tipo I o alfa.

51. Si en un estudio de casos y controles se usa la odds ratio para medir la asociación entre la exposición de interés y la característica estudiada y el error que se comete en la clasificación de los sujetos en expuestos o no expuestos es igual en el grupo de los casos que en el de los controles. ¿Cuál es el efecto sobre el valor estimado de la fuerza de la asociación?:

1. Se produce un sesgo en el sentido de aumentar erróneamente la fuerza de la asociación medida.
2. Se produce un sesgo en el sentido de disminuir erróneamente la fuerza de la asociación medida.
3. Se produce un sesgo unas veces aumentando y otras disminuyendo erróneamente la fuerza de la asociación medida.
4. Una estimación válida de la fuerza de la asociación, pero con un aumento de la magnitud de su intervalo de confianza.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el Error de Clasificación no diferencial, la mala clasificación afecta por igual a los dos grupos de estudio y, a diferencia del Sesgo de Clasificación incorrecta diferencial (en el que la asociación encontrada puede ser mayor o menor a la real), aquí el resultado es siempre que se infraestima el efecto de la exposición, es decir, “se produce un sesgo en el sentido de disminuir erróneamente la fuerza de la asociación medida”. Un Sesgo de Clasificación incorrecta diferencial puede hacer, por ejemplo, que la fuerza de asociación encontrada entre HTA e ictus sea mínima, pero puede incluso motivar que la HTA aparezca, en un estudio, como factor protector de ictus. En el Error de Clasificación no diferencial el resultado será que la asociación encontrada es mínima o que no podemos demostrar que la HTA es factor de riesgo de ACV, pero nunca se desprenderá de nuestro estudio que la HTA es un factor protector de ACV. Dicho de otro modo, el Error de Clasificación no diferencial puede diluir la asociación entre factor de riesgo y enfermedad e impedir que los resultados sean estadísticamente significativos, pero nunca invertirá el sentido real de la asociación.

52. En un ensayo clínico para comparar dos fármacos, se incluyen 75 pacientes en cada rama, la variable de interés es tiempo hasta que desaparecen los síntomas y el período de seguimiento es de 30 días. Al final de ese período hay pacientes a los que no les han desaparecido los síntomas. El análisis de los datos:

1. Se puede hacer con la prueba t de Student.
2. Se debe hacer con la prueba ji-cuadrado.
3. Se debe hacer con las técnicas de análisis de supervivencia.
4. Se debe hacer con la U de Mann-Whitney.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El análisis de supervivencia se utiliza cuando en un estudio epidemiológico la variable respuesta es el tiempo que transcurre hasta que sucede un evento de interés. Éste puede ser la muerte, pero no exclusivamente, también se puede llevar a cabo un análisis de supervivencia evaluando el tiempo que dura la eficacia de una intervención, el tiempo hasta la aparición de una recurrencia de la enfermedad, el tiempo hasta que el paciente recibe el alta hospitalaria, el tiempo hasta la desaparición de la sintomatología, etc. ya que la variable empleada sería de naturaleza mixta (componente cualitativo -sufrir o no el evento-, y componente cuantitativo -tiempo hasta que aparece el evento-).

53. ¿Cuál de los siguientes criterios que se utilizan para establecer la relación de causalidad entre un fármaco y una supuesta reacción adversa, es el único que resulta imprescindible para al menos poder mantener la sospecha de que estamos ante una reacción adversa a medicamentos?:

1. Que la respuesta al fármaco sea conocida (plausibilidad biológica).

2. Mejoría de la reacción al retirar el fármaco.
3. Secuencia temporal razonable entre la exposición al fármaco y la aparición de la reacción adversa.
4. Reaparición de la reacción al reintroducir el fármaco.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La relación causa-efecto entre la administración del medicamento y la reacción adversa se cataloga desde definida hasta improbable sobre la base de los criterios recogidos en el algoritmo de Karch y Lasagna, siendo estos criterios de más importante a menos: -. Secuencia temporal razonable (único imprescindible) (RESPUESTA 3 CORRECTA) -. Respuesta al fármaco conocida (plausibilidad biológica) -. Mejoría de la reacción al retirar el fármaco. -. Reaparición de la reacción al reintroducir el fármaco. -. Ausencia de una explicación alternativa para la reacción.

54. Al contrario que los estudios de eficacia, que se realizan en condiciones experimentales ideales, los ensayos clínicos de efectividad pretenden evaluar el valor de un nuevo tratamiento en condiciones lo más parecidas a las que tienen lugar en la práctica clínica habitual. Este tipo de ensayos clínicos para la evaluación de la efectividad se denominan:

1. Ensayos clínicos multicéntricos.
2. Ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego y paralelos.
3. Ensayos clínicos postcomercialización.
4. Ensayos clínicos pragmáticos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La evaluación de la efectividad, es decir, del uso y los resultados de los medicamentos en las condiciones de la práctica clínica (estudios naturalísticos) puede llevarse a cabo -además de con estudios observacionales-, mediante ensayos clínicos aleatorizados. El diseño preferido en estos casos es el de los ensayos clínicos pragmáticos, ya que al tener criterios de inclusión laxos, se incrementa la validez externa y la capacidad de generalización de los resultados.

55. Señale el fármaco que debe ajustarse su dosis en el paciente con deterioro de la función renal:

1. Teofilina.
2. Carbamazepina.
3. Digoxina.
4. Propanolol.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La insuficiencia renal produce cambios farmacocinéticos sobre aquellos fármacos cuya vía de excreción es preferentemente renal, por lo que en estos casos será necesario ajustar la dosis, principalmente en aquellos fármacos con

rango terapéutico estrecho (digoxina, aminoglucósidos...). La insuficiencia renal produce cambios farmacocinéticos por distintos mecanismos: -Absorción y biodisponibilidad: por alteración del equilibrio hidroelectrolítico y permeabilidad de membranas. -Distribución/ unión a proteínas: por disminución de la albúmina plasmática, competición con metabolitos endógenos, aumento de α_1 -glicoproteína o disminución de la unión a proteína tisular (e.g. digoxina). -Metabolismo: la actividad de algunas enzimas microsomales es menor en la insuficiencia renal. -Eliminación y excreción renal: por alteración de los mecanismos de filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular.

56. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas constituye actualmente el tratamiento de elección en las inmunodeficiencias combinadas severas (SCID)?:

1. Terapia sustitutiva con inmunoglobulina intravenosa (IVIG).
2. IL2 en perfusión intravenosa continua.
3. Transplante de progenitores hematopoyéticos (TMO).
4. Administración de IFN β .

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Hay tres aspectos muy importantes que no debes olvidar, en las Inmunodeficiencias combinadas severas: que debe evitarse la vacunación con gérmenes vivos; que debe irradiarse la sangre previamente a cualquier transfusión que necesiten (esto último para evitar la enfermedad injerto contra huésped). Y por último, que el TPH puede ser curativo (opción 3 verdadera). Las Igs i.v. sirven como tratamiento de soporte (no curativo) en algunas inmunodeficiencias humores (opción 1 falsa); La IL-2 está indicada, aunque actualmente en desuso, en el tratamiento del cáncer de células renales o del melanoma maligno metastásico (opción 2 falsa); el IFN- β sirve para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple (opción 4 falsa).

57. Uno de los siguientes síntomas característicos del síndrome esquizofrénico no puede considerarse un síntoma negativo:

1. Anhedonia.
2. Alogia.
3. Frialidad emocional.
4. Paralogia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Bleuler definió los síntomas negativos como los propios de la esquizofrenia: las 4 A, apatía, ambivalencia, afecto aplanado y autismo. Hoy en día también hablamos de las A de los síntomas negativos: apatía, anhedonia, alogia, aplanamiento afectivo y retraimiento social. Pregunta importante que no se debe fallar.

58. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA sobre las ventajas de los estudios de casos y controles?:

1. Útiles para abordar enfermedades infrecuentes.
2. Alternativa eficiente para el estudio de enfermedades con periodos de latencia prolongados.
3. Facilidad de constituir un grupo adecuado de comparación.
4. Permiten valorar diferentes factores etiológicos simultáneamente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ventajas de los estudios de casos y controles: - Sirven para generar nuevas hipótesis etiológicas. - Son útiles para enfermedades raras, crónicas o con largo periodo de latencia. - Son rápidos y económicos (no tenemos que esperar a que aparezca la enfermedad y la muestra requerida es menor que para los estudios de cohortes, ya que no son sensibles a pérdidas). - Permiten estudiar varios factores de riesgo para una enfermedad (multicausalidad). El inconveniente de este tipo de estudios es que se comenten muchos sesgos, debido, sobre todo, a la dificultad para conformar un grupo de comparación adecuado. También puede haber un sesgo de memoria, al ser el seguimiento retrospectivo virtual en la memoria del paciente, que puede no recordar bien los factores de exposición del pasado.

59. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico de elección para una lesión cutánea en región deltoidea con Anatomía Patológica de Melanoma Maligno Clarck IV y Breslow de 1,92 mm:

1. Ampliación de márgenes de 1 cm.
2. Ampliación de márgenes de 2 cm si la Ecografía axilar es negativa.
3. Ampliación de márgenes de 2 cm y detección del ganglio centinela.
4. Ampliación de márgenes de 2 cm y vaciamiento axilar.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El tratamiento quirúrgico del melanoma tiene varios pasos. Después de la extirpación se debe realizar una ampliación cuyo tamaño es variable dependiendo del nivel Breslow o espesor en mm. del tumor. Cuando el melanoma es in situ, la ampliación debe ser de 0.5 cm. Cuando el Breslow es menor de 1 mm la ampliación debe ser de 1 cm, y cuando el espesor es mayor de 1mm (caso de nuestro paciente ya que tiene un Breslow de 1.92mm), la ampliación debe ser de 2 cm. Si el Breslow es mayor de 1mm, además de la ampliación al paciente hay que realizarle una detección de ganglio centinela, como a nuestro paciente, ya que presenta un espesor de Breslow de 1.92mm.

60. Hombre de 29 años de edad que es traído a urgencias de un Centro de Salud por unos vecinos al habérselo encontrado inconsciente en la calle. A la exploración destaca: pulso a 54 latidos por minuto, bradipnea con paradas respiratorias cada vez más frecuentes y prolongadas, hipotermia, cianosis central y pupilas mióticas. ¿Cuál de las siguientes actitudes terapéuticas iniciales es la más correcta?:

1. Asegurar la vía aérea, oxígeno y suero glucosado 10%.
2. Asegurar la vía aérea, calentamiento corporal y observación.
3. Asegurar la vía aérea, administrar naltrexona y observación.
4. Asegurar la vía aérea, administrar naloxona intravenosa y observación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una intoxicación por opiáceos, que cursa con la característica clínica de miosis, depresión respiratoria y alteración del nivel de conciencia. El tratamiento se hará con medidas de soporte y naloxona iv. Recuerda que la intoxicación por opiáceos se trata con NALOXONA.

61. La Uveítis por reconstitución inmune es una entidad:

1. Asociada al HLAB27.
2. Descrita en pacientes VIH.
3. Muy frecuente en pacientes con lupus eritematoso sistémico.
4. Aparece en algunos pacientes con sífilis ocular tras la administración de penicilina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad alta. Típica pregunta que se debe intentar acertar aunque no esté en el manual y se salga del temario típico del manual. Ya que la única opción que habla de una enfermedad en la que el sistema inmune pueda tener una recuperación es la 2. El Síndrome de Reconstitución Inmune (SRI) constituye una variedad de condiciones que ocurren cuando los pacientes (usualmente con conteos celulares CD4 muy bajos), inician TARGA. El síndrome conduce a una recrudescencia de infecciones que ya se encontraban presentes en el huésped y que se ven exacerbados por la restauración del sistema inmune. Entre las características clínicas de este síndrome está la instalación de una nueva o empeoramiento de uveítis/vitreítis post resolución de una retinitis por CMV.

62. Ante un paciente fumador de 45 años que presenta disfonía y mediante exploración se observa una lesión vegetante rugosa en el borde libre de la cuerda vocal derecha ¿cuál es la conducta a seguir?:

1. Reposo vocal.
2. Conducta expectante.
3. Derivación para biopsia.
4. Supresión del tabaco.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante todo paciente con factores de riesgo (fumador en este caso), disfonía de más de 2 semanas de evolución y una lesión en cuerda vocal deberemos hacer una biopsia para confirmar el origen tumoral o no de la misma. Una vez se tengan los resultados de la biopsia se tomará la decisión terapéutica adecuada, pero no se debe instaurar tratamiento o tener una conducta expectante sin haber biopsiado la lesión.

63. Paciente de 4 años que acude a urgencias con una historia de secreción nasal purulenta y de mal olor unilateral desde hace 4 días. El diagnóstico más frecuente es:

1. Fibrosarcoma del cornete nasal.
2. Atresia de coanas unilateral.
3. Rinitis crónica por Rinovirus.
4. Cuerpo extraño intranasal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En un niño ante la clínica de rinorrea purulenta y fétida unilateral y obstrucción nasal hay que pensar siempre en un cuerpo extraño intranasal. Sin embargo en un adulto, ante la clínica de obstrucción nasal unilateral, rinorrea crónica unilateral serosanguinolenta y fétida debemos pensar en un carcinoma rinosinusal. El más frecuente en los adultos es el carcinoma epidermoide y la localización el seno maxilar.

64. ¿Cuál de los siguientes enunciados respecto a la depresión mayor o episodio depresivo mayor es INCORRECTO?:

1. A lo largo de la vida, aproximadamente un 15% de la población sufre un episodio depresivo mayor.
2. Cerca de un 8% de los pacientes que atiende un médico de Atención Primaria podría recibir un diagnóstico de depresión mayor.
3. Hasta un 15% de los casos de depresión mayor son secundarios a una enfermedad médica somática o al abuso de sustancias.
4. Cuando se sospecha que un paciente sufre un episodio depresivo mayor, debe evitarse hacer preguntas directas al paciente sobre ideas o proyectos suicidas, porque tal pregunta aumenta el riesgo de suicidio un 35%.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil a pesar de los múltiples datos numéricos. El 75% de los suicidas habla previamente de estas ideas, con lo cual, preguntar por ellas y detectarlas, puede ser útil

para evitar el suicidio. Recuerda que preguntar por ideas de suicidio no aumenta el riesgo. Hay que preguntar y explorar las ideas suicidas con el fin de detectarlas y poder establecer medidas de protección.

65. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO supone una indicación primaria de la ecografía obstétrica durante el primer trimestre de gestación?:

1. Definir la causa de un sangrado vaginal.
2. Confirmar la edad gestacional.
3. Valorar una sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional.
4. Diagnosticar un embarazo en mujer con amenorrea.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La clave para acertar esta pregunta está en detectar que la opción 4 es engañosa. Ya que el objetivo de la ecografía del primer trimestre no es diagnosticar el embarazo, sino confirmar que sea intrauterino. Otros objetivos relevantes de esta ecografía son: determinar la edad gestacional (opción 2), valorar translucencia nuchal, diagnosticar patología ovular (mola) (opción 3) y estimar el flujo sanguíneo en el ductus de Arancio. Recuerda que ante discrepancias en la edad gestacional entre la eco y la fecha de la última regla, se considera correcto el dato ecográfico.

66. ¿Qué actitud tomaría ante una mamografía informada como BI- RADS 3?:

1. Solicito una ecografía mamaria.
2. Control según screening habitual.
3. Control en un periodo breve de tiempo.
4. Recomendando biopsia mamaria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El sistema BI-RADS (Breast Imaging Report and Database System) se desarrolló para informar de forma homogénea por todos los profesionales los resultados de las mamografías. Existen 7 categorías: - BIRADS 0: Mamografía insuficiente para un diagnóstico, necesita una evaluación adicional con otro estudio (ecografía o RM) y no es posible determinar alguna patología. - BIRADS 1: Mamografía negativa para malignidad, sin ganglios o calcificaciones. - BIRADS 2: Mamografía negativa a malignidad, pero con hallazgos benignos. - BIRADS 3: Resultado con probable benignidad, pero que requiere control a los 6 meses. (opción 3 correcta) - BIRADS 4: Resultado dudoso de malignidad. Requiere una confirmación histopatológica. - BIRADS 5: Alta sospecha de malignidad. Requiere biopsia para confirmar diagnóstico. - BIRADS 6: Imagen mamográfica con malignidad comprobada mediante biopsia.

67. Un señor de 60 años, empleado de comercio, acude a urgencias acompañado de su familia; éstos cuentan que el día anterior, de forma

bastante brusca, comenzó a decir cosas raras, a no responder a lo que le preguntaban y a mostrarse confuso incluso respecto de su propio nombre. Efectivamente en la exploración parece no entender lo que se le pregunta, no recuerda nada de lo que le ha pasado y no sabe ni el día, ni el lugar en el que está. El diagnóstico sería:

1. Psicosis breve.
2. Delirium.
3. Alzheimer.
4. Esquizofrenia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los mas característico del síndrome confusional agudo es la fluctuación del nivel de conciencia con un comienzo brusco. El paciente del caso presentado está desorientado y confuso. Habrá que buscar y tratar la causa orgánica que lo ha producido.

68. Mujer de 47 años sin antecedentes psiquiátricos que es hospitalizada para estudio de metrorragias y a los 5 días de su ingreso es informada del diagnóstico de neoplasia uterina con metástasis. Se consulta a Psiquiatría porque 24 horas después muestra tristeza y llanto frecuente, refiere ideas de muerte y presenta insomnio. En la evaluación psiquiátrica no se recoge ningún antecedente psiquiátrico y la exploración detecta elevada ansiedad y desesperanza en relación con las consecuencias de su enfermedad neoplásica. El diagnóstico más probable es:

1. Reacción normal frente al estrés.
2. Distimia.
3. Trastorno de ansiedad generalizada.
4. Trastorno por estrés postraumático.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una reacción normal frente al estrés, en concreto frente a un agravio plausible. Lo normal es aceptar esta noticia con tristeza, pena de la condición humana, y no con frialdad. Si la sintomatología depresiva se prolongara o aparecieran síntomas somáticos tendríamos que intervenir. Si entre las opciones estuviera trastorno adaptativo, también podríamos marcarla. Sabemos que el trastorno adaptativo es la patología psiquiátrica más frecuente en los pacientes oncológicos, ya sea con sintomatología depresiva, ansiosa o mixta.

69. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación a los efectos adversos de las sales de litio en el tratamiento del trastorno bipolar:

1. El litio puede ocasionar alteraciones de la función renal.

2. El litio puede causar alteraciones de la electrofisiología cardíaca.
3. El litio puede producir hipotiroidismo.
4. El litio puede provocar insuficiencia respiratoria.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los efectos adversos del litio incluyen empeoramiento de la psoriasis, temblor esencial, hipotiroidismo, alteraciones renales y alteraciones en la conducción cardíaca, pero no insuficiencia respiratoria.

70. Mujer de 60 años de edad diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante multicéntrico de mama subsidiaria de mastectomía más vaciamiento axilar y quimioterapia postoperatoria. ¿Cuándo estaría indicado realizar la reconstrucción de la mama?:

1. Sistemáticamente diferida al cabo de 5 años libre de enfermedad postmastectomía.
2. El momento (inmediato / diferido) vendrá indicado por el número de ganglios positivos.
3. La quimioterapia postoperatoria es una contraindicación para realizar la reconstrucción inmediata.
4. De forma inmediata, pues la reconstrucción de la mama no interfiere en la historia natural de la enfermedad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Si se ha realizado una cirugía oncológicamente correcta (márgenes libres) la reconstrucción mamaria inmediata no interfiere con la quimioterapia o radioterapia postoperatoria, por lo que no está contraindicada. Esta técnica se realiza en varios tiempos, en un primero se realiza la mastectomía radical junto con la colocación de un expansor. En sucesivas consultas se va aumentando de forma percutánea el volumen del expansor y en un segunda cirugía se cambia el expansor por un prótesis definitiva.

71. Un paciente de 48 años, acude a urgencias aquejando un intenso dolor en el ojo izquierdo que le sobrevino de forma brusca mientras veía televisión. A la exploración se evidencia que ese ojo izquierdo está enrojecido, con discreto edema corneal y la pupila se encuentra en midriasis media, con pobre respuesta a la luz. Ante el cuadro clínico descrito, ¿qué opción le parece MENOS probable de las siguientes propuestas?:

1. El cuadro clínico expuesto suele ser más frecuente en personas con hipermetropía.
2. En esta situación se espera que la presión intraocular de ese ojo esté elevada.
3. Se trata de un cuadro más frecuente en pacientes sin cristalino, (afáquicos).

4. Probablemente este paciente tendrá una cámara anterior estrecha.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. Esta pregunta forma parte del diagnóstico diferencial del OJO ROJO. El paciente presenta: ojo rojo, DOLOR y pupila en midriasis arreactiva, esto nos hace sospechar un glaucoma agudo por cierre angular. Es más frecuente en hipermetropes, ya que la cámara anterior es más estrecha y esto facilita el bloqueo del ángulo irido-corneal. (opción 1). Entonces aumenta la presión intraocular al no evacuar el humor acuoso por el trabeculum. (opción 2). También aumenta el riesgo en paciente con cristalino aumentado de tamaño, como por ejemplo, con catarata. (opción 3 falsa) Además de luces, la agudeza visual disminuye por el edema corneal.

72. En relación con la patología del nervio óptico y los nervios oculomotores, es cierto:

1. Un infarto de la corteza occipital produce una hemianopsia homónima ipsilateral.
2. En las lesiones compresivas del III par (motor ocular común) hay característicamente un respeto de la función pupilar.
3. En la neuritis óptica las pupilas son isocóricas y puede encontrarse un defecto pupilar aferente.
4. La pérdida de agudeza visual en el edema de papila es muy grave.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Si uno no recuerda que en las papilitis (o neuritis ópticas) puede haber un defecto pupilar AFERENTE, porque no se transmite por el nervio óptico el impulso sensitivo desde la retina; debe intentar acertar la pregunta por descarte. La opción 1 es falsa porque la isquemia en la corteza estriada produce una hemianopsia homónima CONTRALATERAL congruente y con respeto macular. Opción 4: el papiledema no produce disminución de la agudeza visual, al menos en estadios precoces. Opción 2: las fibras pupilares son más superficiales en el tercer par que las fibras motoras. Por lo que si se comprime habrá alteraciones pupilares.

73. Un paciente bebedor habitual de alcohol es llevado a urgencias con un cuadro de desorientación, dificultad para recordar hechos de los días anteriores, errores en los razonamientos, marcha torpe y una desviación en los ojos divergente que antes no tenía. Según parece, ha estado bebiendo alcohol hasta unas horas antes de llevarlo a urgencias. Probablemente se trate de un caso de:

1. Síndrome de abstinencia complicado.
2. Enfermedad de Korsakoff.
3. Encefalopatía de Wernicke.
4. Alucinosis alcohólica.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Se trata de un Wernike con ataxia, oftalmoplejía y síndrome confusional.

74. Lactante de 3 meses de edad que acude a la consulta por presentar desde los 15 días de vida, regurgitaciones postprandiales en casi todas las tomas y de forma esporádica, vómitos en mayor cantidad. Heces de características normales. Lactancia artificial con fórmula de inicio y presenta un adecuado desarrollo ponderoestatural, sin pérdida de peso. ¿Cuál entre los siguientes, es el diagnóstico más probable?:

1. Alergia a proteína de leche de vaca.
2. Estenosis pilórica.
3. Intolerancia a proteínas de leche de vaca.
4. Reflujo gastroesofágico madurativo.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Esta pregunta es importante, y puede ser sencilla si se lee con detenimiento. Vamos a ir descartando: Opción 1: Para que nos digan una alergia a proteínas de leche de vaca nos tienen que contar una clínica de rash en la piel y/o síntomas digestivos y/o broncoespasmo en relación con la toma del alimento. Opción 3. En las intolerancia a proteínas de leche de vaca los síntomas son más sutiles, generalmente solo digestivos como diarrea con hebras de sangre. Opción 2. El problema está entre RGE y estenosis pilórica. La clínica puede ser la misma, pero en este caso NO SERÁ una estenosis de píloro, porque nos tendrían que decir que el niño tiene unos 15 días-1 mes, hace vómitos en escopetazo tras las tomas, quedando hambriento, haciendo alcalosis metabólica hipoclorémica por pérdida de ácido clorhídrico. La respuesta verdadera es por tanto, un reflujo gastro-esofágico madurativo, fisiológico o regurgitaciones del lactante (opción 4), que también te debe sugerir ausencia de organicidad que tenga un adecuado desarrollo ponderoestatural.

75. La hipoacusia característica de la enfermedad de Menière es:

1. Hipoacusia de transmisión.
2. Hipoacusia neurosensorial sin reclutamiento.
3. Hipoacusia neurosensorial fluctuante.
4. Hipoacusia mixta, de transmisión y neurosensorial.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La enfermedad de Meniere es debida al excesivo acúmulo de endolinfa y se caracteriza por la triada de acúfenos, hipoacusia y vértigo paroxístico. La hipoacusia se caracteriza por ser una hipoacusia neurosensorial fluctuante con reclutamiento mayor en sonidos graves (RESPUESTA 3 CORRECTA).

76. De las siguientes situaciones clínicas indique en cuál podría estar más justificado el empleo de un estudio clínico con control histórico para evaluar la eficacia:

1. Hipertensión arterial.
2. Infección de vías respiratorias altas.
3. Cáncer de páncreas en estadio avanzado.
4. Carcinoma basocelular cutáneo.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El uso de controles históricos en ensayos clínicos (cuando los datos del grupo control no son concurrentes con los del grupo experimental, es decir, pertenecen a pacientes tratados previamente a la realización del actual estudio) está bastante restringido ya que tienden a sobrevalorar la eficacia del fármaco experimental. No obstante, su empleo puede estar justificado cuando sea difícil reclutar un número adecuado de sujetos para llevar a cabo el estudio (enfermedad rara o terminal), siempre que como variable resultado del estudio se utilice una variable “dura” (variable con pocas posibilidades de ser interpretada de manera distinta por distintos observadores; por ejemplo, la muerte). De entre las opciones incluidas en esta pregunta, el cáncer de páncreas en estadio avanzado es aquella en la que podría estar más justificado el empleo de controles históricos, si bien es conveniente recordar que, para evitar sesgos, siempre que sea posible es preferible el uso de un grupo de control concurrente.

77. ¿Cuál es el principal inconveniente de las evaluaciones económicas realizadas dentro de los ensayos clínicos?:

1. La necesidad de utilizar suposiciones.
2. La baja validez interna.
3. La baja validez externa.
4. La baja calidad de los datos de eficacia.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Los ensayos clínicos, habitualmente durante la fase III, además de para establecer la eficacia de un fármaco, también pueden ser utilizados para realizar evaluaciones económicas de medicamentos. Debido al rigor científico derivado del propio método que este tipo de estudio emplea, la validez interna de los resultados será alta, si bien el principal inconveniente del uso de un ensayo clínico como herramienta de evaluación económica es su escasa validez externa, ya que tanto los efectos farmacológicos como los costes que se registran pueden ser muy diferentes a las que se obtendrán en la práctica clínica diaria.

78. ¿Cuál de las siguientes serologías es más recomendable hacer a todas las embarazadas?:

1. La del citomegalovirus.
2. La del parvovirus.

3. La de la hepatitis C.
4. La del VIH.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El screening infeccioso que se realiza de forma universal a todas las embarazadas incluye 6 serologías: sífilis, toxoplasma, rubeola, VHB, VHC y VIH. El CMV es la infección congénita más frecuente pero dado que no tiene tratamiento no se realiza screening. Recuerda que la infección por *S. agalactiae* es la causa más frecuente de sepsis neonatal y su cribado se realiza mediante exudado vagino-rectal entre las semanas 35 y 37.

79. Las vacunas del papilomavirus frente al carcinoma cervical han demostrado su eficacia mediante:

1. La demostración de que no aparece cáncer cervical en los vacunados.
2. La demostración de que se producen anticuerpos tras la vacunación.
3. La demostración de protección frente a la aparición de lesiones preneoplásicas (CIN 2/3) asociadas a los virus incluidos en la vacuna.
4. La demostración de la remisión del cáncer cervical en las mujeres vacunadas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los principales estudios en los que se sustenta la aprobación de la vacuna del papilomavirus frente al carcinoma cervical han empleado como variables primarias de eficacia la incidencia de displasia intraepitelial cervical grado alto (CIN 2/3) en relación con los tipos de VPH incluidos en la vacuna (6, 11, 16 y 18). El análisis de los resultados mostró que la eficacia de la vacuna en la prevención de neoplasias intraepiteliales cervicales de cualquier nivel e inducida por VPH de los tipos 6, 11, 16 y 18, era del 95,2%. Si se consideraban sólo los casos con displasia intraepitelial cervical grado 3 la eficacia ascendía al 100%.

80. ¿Cuál es el tratamiento correcto para una pareja estéril por una obstrucción bilateral de las trompas?:

1. La fecundación in vitro.
2. La inseminación artificial con semen del marido.
3. La inseminación artificial con semen de donante.
4. Inducir la ovulación con gonadotropinas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La inseminación artificial requiere, ya sea de donante o de la pareja, que las trompas estén permeables. (opciones 2 y 3 incorrectas) La inducción de la ovulación requiere que las trompas también estén permeables y el semen sea normal (opción 4 incorrecta). Como en la fecundación in vitro los ovocitos se extraen mediante una punción transvaginal y tras ser fecundados son transferidos directamente a la cavidad

endometrial, es la técnica de elección en la obstrucción bilateral de las trompas (opción 1 correcta). Recuerda que no aumenta el riesgo de malformaciones, pero sí de abortos o gestaciones ectópicas.

81. Se encuentra ante un recién nacido a cuya madre se le descubrió una seroconversión a Toxoplasmosis durante la gestación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. El estudio de la placenta puede resultar de utilidad en el diagnóstico.
2. Los recién nacidos infectados pero no enfermos no precisan tratamiento.
3. El cuadro clínico neonatal puede ser indistinguible de otras infecciones congénitas.
4. El recién nacido puede encontrarse asintomático.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La toxoplasmosis congénita sigue siendo hoy en día un problema en las unidades de neonatología. El estudio de la placenta puede ayudar pues si está infectada indica colonización por toxoplasma y probable transmisión al feto (opción 1 correcta). Se debe realizar estudio serológico al recién nacido cuanto antes, pues nos permite saber si está afectado o no, e iniciar tratamiento lo antes posible. (Recuerda que si tiene IgG frente a toxoplasma al nacimiento, éstos serán anticuerpos pasados por su madre; mientras que será diagnóstico que el neonato tenga IgM al nacimiento o mantenimiento o aumento de IgG al cabo de los meses). El cuadro clínico de casi todas las infecciones congénitas es muy parecido (Opción 3 correcta). Pensar en infección TORCH si hay afectación multisistémica sobre todo de SNC, ojo, oído o a nivel hematológico. El recién nacido en un alto porcentaje puede estar asintomático, pues la clínica suele ser muy sutil e iniciarse al cabo de los meses (Opción 4 correcta). Todos los recién nacidos infectados deben ser tratados lo antes posible para erradicar al toxoplasma y evitar las posteriores complicaciones asociadas al mismo (respuesta 2 FALSA).

82. ¿Cuál de estos procesos puede producir simultáneamente afectación ocular y cutánea?:

1. Dermatomiositis.
2. Lupus eritematoso discoide.
3. Dermatitis herpetiforme.
4. Rosácea.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ya han preguntado en ocasiones anteriores esta relación entre la rosacea y la blefaritis y conjuntivitis! Recuerda que esta patología es una dermatosis acneiforme que frecuentemente afecta a mujeres entre los 30 y 40 años. Parece que entre sus factores etiopatogénicos está la labilidad vasomotora. En la exploración física es característico la presencia de pápulo-pústulas sin comedones.

83. Mujer de 65 años, hipertensa y diagnosticada de diabetes no insulino dependiente, con buen control metabólico, acude a consulta por pérdida importante de agudeza visual en su ojo derecho de 4 días de evolución. En la exploración del fondo de ojo destaca la presencia de venas dilatadas y tortuosas, hemorragias en llama, edema retiniano difuso y algunas manchas algodinosas; no se observan alteraciones significativas en cabeza de nervio óptico (papila). Con los datos indicados, señale el diagnóstico más probable:

1. Oclusión de la arteria central de la retina.
2. Obstrucción de la vena central de la retina.
3. Hemorragia vítrea.
4. Retinopatía hipertensiva grado IV de KeithWegener.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Este enunciado puede ser engañoso, ya que los antecedentes personales pueden hacernos creer que la DM es la causante de la clínica. Pero al decir que tiene buen control de sus glucemias, el autor quiere que la descartemos como causa. (opción 3 falsa) Recuerda que la hemorragia vítrea (o hemovítreo), se caracteriza en el MIR por disminución brusca de la agudeza visual, Indolora en pacientes diabéticos. Pero no se puede ver el fondo de ojo por la turbidez vítrea. La retinopatía hipertensiva no produce disminución brusca, sino se caracteriza por signos de esclerosis vascular. En la oclusión de la arteria central de la retina, la disminución de la agudeza visual es brusca, la retina está pálida y edematosa en el área isquémica. No habrá hemorragias, sino una mancha rojo cereza. Por lo tanto la opción correcta es la oclusión de la vena central, que se caracteriza por: disminución brusca de la agudeza visual, Indolora, hemorragias en llamarada, dilatación de venas, edema de retina y exudados algodinosos.

84. ¿Qué lesión de la mucosa oral debe ser considerada como precancerosa?:

1. Leucoplasia.
2. Pénfigo.
3. Enfermedad de Behçet.
4. Estomatitis aftosa recidivante.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Una lesión precancerosa es un tejido morfológicamente alterado en el que el cáncer oral puede aparecer más fácilmente que en tejido equivalente de apariencia normal. Las lesiones precancerosas orales son: Leucoplasia (RESPUESTA 1 CORRECTA), eritroplasia, fibrosis oral submucosa, queratosis actínica, liquen plano, enfermedad de plummer-Vinson, nevus melanocítico y disqueratosis congénita. Las principales por frecuencia o alta malignización son: leucoplasia, eritroplasia y liquen plano.

85. A una gestante a término que ingresa en trabajo de parto se le detectan unas pequeñas vesículas vulvares de herpes simple recidivante. Años antes de la gestación tuvo una primoinfección de herpes genital y varios brotes de herpes recidivante. ¿Cuál es la conducta a seguir?:

1. Hacer una cesárea.
2. Permitir el parto vaginal y tratar con aciclovir al recién nacido.
3. No es necesario una conducta especial ya que el herpes recidivante no tiene riesgo para el recién nacido.
4. Permitir el parto vaginal y aislar al recién nacido de la madre.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las indicaciones de cesáreas electiva es un tema muy preguntado en el MIR. Por ello es muy importante dominarlo antes del examen. Las indicaciones más importantes son: dos o más cesáreas previas, cirugía uterina con apertura de cavidad endometrial, placenta previa oclusiva total, situación transversa, o cefálicas en actitud de frente o de cara menotposterior, presentación pelviana (en general) e infección activa por VHS antes del parto.(opción 1 correcta). Recuerda que en el embarazo gemelar si el primer feto no está en cefálica o hay más de dos fetos o es una gestación monoamniótica, también es de elección la cesárea.

86. Con relación a las manifestaciones clínicas del liquen plano, todas las respuestas son correctas, EXCEPTO:

1. Distribución simétrica, en zonas flexurales.
2. Prurito en la mayoría de los pacientes.
3. La variante anular se localiza con preferencia en el pene.
4. La variante hipertrófica se localiza preferentemente en el cuero cabelludo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta bastante rebuscada! El liquen plano es una enfermedad inflamatoria caracterizada por presentar "la clínica de las 5P": pápulas, planas, pruriginosas, purpúricas y poligonales. La afectación es, generalmente cutánea y/o mucosa (tanto oral como genital, siendo una variante el liquen plano anular de pene), aunque también pueden verse afectadas las uñas y el cuero cabelludo. Existe una variante, llamada liquen plano hipertrófico, que se diferencia del clásico al presentarse en forma de placas engrosadas, y suele presentarse en las piernas (resp. 4 incorrecta).

87. Al analizar los resultados de un ensayo clínico, se concluye que existen diferencias entre los parámetros evaluados para cada una de las ramas de tratamiento, con una p de 0,034. Esto significa:

1. Que si se repite el estudio, en un 3,4% de ocasiones no se encontrarían diferencias.
2. Que en un 3,4% de sujetos de ambas ramas, no se encontraron diferencias.
3. Que hay una probabilidad de 3,4% de que la diferencia obtenida se deba al azar.
4. Que la magnitud de la diferencia entre tratamientos es mayor que si $p = 0,05$.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En contraste de hipótesis, el grado de significación (p) es la probabilidad de que, en caso de que todos los grupos de estudio fuesen iguales (es decir, en caso de que la Hipótesis Nula fuese cierta), se obtuviesen nuestros resultados. Dicho de otro modo es la probabilidad de que la diferencia obtenida se deba al azar. Cuando la probabilidad de que la diferencia obtenida se deba al azar es muy pequeña (menor al 5 %), habremos reunido suficiente evidencia como para rechazar la Hipótesis Nula. No aseguraremos que la Hipótesis Nula es falsa (siempre existe esa pequeña probabilidad de que sea cierta), pero diremos que nuestro resultado es extremadamente raro en caso de que la Hipótesis Nula sea cierta.

88. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad bien conocida de la mujer en edad fértil y su diagnóstico se basa en los datos que aporta:

1. Historia clínica familiar pormenorizada ya que lo más importante son los antecedentes familiares.
2. Realización de una Resonancia Magnética de la hipófisis para descartar un adenoma.
3. Un escáner para estudiar de forma resolutive los ovarios y estudio hormonal completo.
4. Valoración clínica, estudio hormonal y ecografía ginecológica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Podemos deducir la respuesta si se conoce las características más importantes de la enfermedad. Etiopatogenia: alteraciones hormonales (un aumento de la LH provoca una hiperplasia de la teca interna que tiene como consecuencia un aumento de andrógenos además de existir un estado basal de insulino-resistencia) Clínica: esterilidad, alteraciones menstruales (oligomenorrea y metrorragia) e hirsutismo/acné. El diagnóstico se realiza a través de la clínica, niveles hormonales (andrógenos) y ecografía. El diagnóstico de certeza solo lo da la anatomía patológica. Recuerda: el cociente LH/FSH será mayor de 2.5 aunque no se considera criterio diagnóstico. En la ecografía vemos unos ovarios agrandados con numerosos folículos de pequeño tamaño distribuidos en corona en la periferia del ovario como podemos observar en la imagen adjunta.

89. ¿Cuál de los siguientes estudios se corresponde con el diseño de un estudio de casos y controles?:

1. Seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados de agranulocitosis y un grupo control de pacientes del mismo hospital con otras enfermedades hematológicas. Comparamos a los dos años en ambos grupos la proporción de pacientes que sobreviven.
2. Seleccionamos un hospital en el que han ocurrido una serie de casos de legionelosis y como control otro hospital sin ningún caso. Comparamos la temperatura del agua en los depósitos de agua caliente de cada hospital.
3. Seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados de infarto agudo de miocardio y un grupo seleccionado de forma aleatoria procedente de la misma colectividad, sin infarto. Comparamos en ambos grupos la proporción de pacientes previamente expuestos a determinado antiinflamatorio no esteroideo.
4. Seleccionamos una muestra de sujetos que han tenido un resultado positivo en un control de alcoholemia mientras conducían. Calculamos en este grupo la prevalencia de cardiopatía isquémica sintomática.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los estudios de casos y controles son estudios observacionales (el investigador no asigna el factor de estudio) en los que el grupo de estudio lo constituyen los sujetos enfermos (ejemplo IAM) y el grupo de comparación lo forman los sujetos sin la enfermedad de estudio (controles sanos o enfermos de una patología no relacionada con IAM). Son estudios longitudinales (el factor de riesgo y la enfermedad deben estar separados en el tiempo) retrospectivos (al comienzo del estudio los participantes están enfermos o sanos e investigamos si EN EL PASADO estuvieron o no expuestos al factor de riesgo estudiado, por ejemplo consumo de AINEs) que utilizan la Odds Ratio como medida fundamental de la fuerza de asociación. Este esquema encaja a la perfección con lo descrito en la opción 3.

90. Entre otras manifestaciones, la talla baja está presente en múltiples síndromes genéticos y polimalformativos, como los que se exponen a continuación, EXCEPTO en uno. ¿Cuál de ellos NO suele cursar con talla baja?:

1. Síndrome de Turner.
2. Síndrome de Down.
3. Síndrome de Klinefelter.
4. Síndrome de Seckel.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el síndrome de Klinefelter, los hombres tienen al menos un cromosoma X extra. Esto generalmente ocurre como resultado de un cromosoma X adicional (escrito como XXY). El síntoma más común es la infertilidad. Otros síntomas pueden abarcar: *Estatura ALTA * Pene pequeño * Testículos pequeños y firmes * Vello púbico, axilar y facial escaso * Problemas sexuales * Agrandamiento de las mamas (ginecomastia) * Proporciones corporales anormales (piernas largas, tronco corto).

91. El principal germen responsable de la otitis externa difusa es:

1. Pseudomona Aeruginosa.
2. Staphylococcus Aureus.
3. Candida Albicans.
4. Hemophilus Influenzae.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La otitis externa se caracteriza por otalgia que aumenta al traccionar del pabellón, del trago o con la masticación, prurito e hipoacusia de transmisión. Debemos diferenciar entre: -. Otitis externa circunscrita: causada por S. aureus. tratamiento cloxacilina vía oral. -. Otitis externa difusa (otitis del nadador): Pseudomona aeruginosa y S. aureus por ese orden. -. Otitis externa maligna o necrotizante: Pseudomonas en diabéticos e inmunodeprimidos.

92. Paciente de 51 años que en mamografía de cribado se detecta nódulo espiculado de 8 mm en cuadrante superoexterno de la mama izquierda. Biopsia con agua gruesa: carcinoma ductal infiltrante. Receptores hormonales positivos. Ki 67 8%, HER 2/neu negativo. Exploración clínica: nódulo no palpable, axila libre. Ecografía axilar: No ganglios sospechosos. ¿Cuál es el tratamiento primario de elección?:

1. Hormonoterapia primaria.
2. Trastuzumab.
3. Mastectomía y linfadenectomía axilar.
4. Tumorectomía y ganglio centinela.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tratamiento del carcinoma de mama ha sido preguntado en muchas de las convocatorias MIR. Por lo que se debe dominar al completo y no fallar ninguna pregunta similar. La paciente presenta un carcinoma SIN factores de mal pronóstico: el tamaño es menor de dos centímetros, los receptores estrogénicos son positivos, no tiene sobreexpresión del oncogen Her 2/neu la concentración de Ki 67 o PCNA es baja y las pruebas complementarias nos orientan a la ausencia de adenopatías. Por lo tanto, la cirugía indicada es la tumorectomía. Para conocer con seguridad la afectación ganglionar se realizará la técnica del ganglio centinela que irá seguida de quimioterapia si resulta

positiva. Recuerda que la opción 4 sería aún más correcta si añadiese radioterapia.

93. Hombre de 66 años que acude a consulta por dolorimiento y enrojecimiento del ojo derecho de 2 días de evolución. La exploración efectuada en ese ojo nos revela los siguientes datos: discreta disminución de la agudeza visual, presión intraocular de 18 mmHg, pupila en miosis, presencia de células en humor acuoso, opacidad cristalina moderada y presencia de una sinequia iridocristalina. ¿Cuál sería la actitud inmediata más correcta de las que se enumeran a continuación?:

1. Cirugía de la catarata de ese ojo, responsable del cuadro clínico.
2. Tratamiento tópico (colirios) con midriáticos y corticoides.
3. Cirugía del glaucoma (trabeculectomía clásica o esclerectomía profunda no perforante).
4. Manitol intravenoso asociado a tratamiento miótico y corticoides tópicos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El ojo rojo, con miosis, dolor y células en cámara anterior (Tyndall) debe orientarnos al diagnóstico de Uveitis. Se produce una inflamación intraocular que debe ser controlada con corticoides. Y para evitar sinequias posteriores (iris-cristalino) se emplean midriáticos. No se dan datos sobre una causa infecciosa, por lo que los antibióticos no serán necesarios.

94. Una mujer de 45 años, madre de un niño celiaco y sin síntomas ni signos de patología digestiva, es evaluada por anemia ferropénica detectada en analítica rutinaria. ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto respecto a este caso?:

1. El riesgo de esta mujer de padecer enfermedad celíaca es similar al de la población general.
2. La ausencia de diarrea hace que se pueda excluir la enfermedad celíaca como causa de la anemia de esta paciente.
3. La determinación del alelo HLA-DQ2, de resultar positiva, establecería el diagnóstico de enfermedad celíaca.
4. La evaluación inicial de esta paciente debería incluir la determinación de anticuerpos antiendomiosio y/o anticuerpos antitransglutaminasa tisular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil. Se trata de una paciente que presenta anemia ferropénica y un hijo enfermo de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad con un componente genético por lo que la paciente presenta un riesgo mayor

que el de la población general de sufrir la enfermedad al tener un hijo afecto (opción 1 falsa). La enfermedad celiaca aparece característicamente en niños con síntomas digestivos pero en la actualidad es conocido que existen formas oligosintomáticas en adolescentes y adultos (opción 2 falsa). El diagnóstico en adultos se realiza siempre con una biopsia, pero antes se realiza una determinación de anticuerpos (opción 4 CORRECTA). La enfermedad celiaca se asocia con el HLA-DQ2/DQ8 pero su presencia no es diagnóstico, sólo indica una mayor probabilidad de que el paciente sufra la enfermedad (opción 3 falsa).

95. La diferencia fundamental entre “rasgo de personalidad” y “trastorno de personalidad” es la siguiente:

1. No existen diferencias entre ambos conceptos. Se utilizan de modo equivalente.
2. El rasgo de personalidad es un patrón persistente de funcionamiento cognitivo, afectivo y relacional inflexible, desadaptativo y causa malestar.
3. El trastorno de la personalidad es un patrón persistente de funcionamiento cognitivo, afectivo y relacional inflexible, desadaptativo y causa malestar.
4. El rasgo de personalidad es por definición patológico y como tal debe de tratarse.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los trastornos de la personalidad se caracterizan porque son patrones permanentes e inflexibles de comportamiento y de experiencia intensa que aparecen en la adolescencia, son estables a los largo del tiempo y conllevan malestar o perjuicio para el sujeto. Los rasgos de la personalidad son variantes de la normalidad pero cuando se convierten en disfuncionales podemos hablar también de trastorno de la personalidad. Opcion 3 correcta.

96. Señalar el trastorno de la personalidad en el que es más frecuente la presencia de autolesiones:

1. Trastorno narcisista de la personalidad.
2. Trastorno obsesivo de la personalidad.
3. Trastorno antisocial de la personalidad.
4. Trastorno límite de la personalidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil, el trastorno limite de la personalidad es el que va a cursar con una mayor impulsividad e inestabilidad emocional, que le lleva a cometer actos autolesivos de manera frecuente. Generalmente son gestos parasuicidas que buscan un beneficio secundario o bien como formas de liberar la angustia o ansiedad. Recuerda que los trastornos de la personalidad con mayor suicidabilidad son el limite y el antisocial.

97. ¿Qué es un metaanálisis?:

1. Un sistema de análisis estadístico que agrupa las variables secundarias para aumentar la potencia estadística de un estudio determinado.
2. Una revisión sistemática de la literatura sobre un determinado tema realizada con criterios explícitos en fuentes bibliográficas.
3. Un sistema de análisis para agrupar y resumir conjuntamente los resultados de diferentes ensayos clínicos sobre una misma materia.
4. Un sistema de asignación aleatoria de pacientes dentro de un ensayo clínico cuyo objetivo es garantizar la ausencia de sesgos de selección.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un metaanálisis consiste en la agrupación y análisis estadístico conjunto de los datos recabados de diferentes estudios habitualmente del mismo tipo (casos y control, cohortes, ensayos clínicos) sobre una misma materia (por ejemplo asociación entre fisura palatina y consumo de benzodiacepinas durante el embarazo), con criterios de inclusión de los estudios, por lo que es una revisión sistemática. El resultado es la obtención de mayor precisión y potencia, ya que la “n” del metaanálisis es la suma de los tamaños muestrales de los diferentes estudios incluidos. Un metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados es el estudio que mayor evidencia científica aporta.

98. ¿Cuál de los siguientes fármacos debe de utilizarse con precaución en un paciente tratado con un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina por el riesgo de provocar un cuadro de hiperactividad serotoninérgica?:

1. Linezolid.
2. Vancomicina.
3. Caspofungina.
4. Meropenem.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Linezolid es un inhibidor reversible no selectivo de la monoamino oxidasa (IMAO). La administración conjunta de IMAOs e ISRS puede producir el llamado “síndrome serotoninérgico”: Se produce por hiperestimulación de los receptores de 5-HT 1a del tronco del encéfalo y se caracteriza por agitación, mioclonía, hiperpirexia, cólicos abdominales, hipertensión e incluso el coma. Por ellos deben dejarse al menos 5 semanas entre el uso de ISRS e IMAO. Linezolid es un antibiótico de tipo oxazolidinona activo exclusivamente frente a microorganismos gram-positivos, indicado en el tratamiento de neumonía nosocomial, neumonía adquirida en la comunidad e infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos, cuando se conoce o se sospecha que están causadas por bacterias gram-positivas.

99. La transformación de testosterona a dihidrotestosterona lo cataliza la siguiente enzima:

1. CYP19 Aromatasa.
2. 5 alfa Reductasa.
3. 17,20 Liasa.
4. 17 alfa Hidroxilasa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La dihidrotestosterona (DHT), metabolito de la testosterona, se sintetiza en la propia próstata a partir de la testosterona circulante por acción de la 5-alfa reductasa. Esta enzima se encuentra principalmente en las células del estroma, y es en ellas donde se sintetiza. Después la DHT actúa de forma autocrina sobre las células del estroma, o de forma paracrina, tras difundirse en las células epiteliales próximas, donde se une a los receptores nucleares de los andrógenos.

100. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecocardiográficos es un criterio mayor en el diagnóstico de la endocarditis Infecciosa?:

1. Derrame pericárdico.
2. Prolapso de una valva de la válvula mitral.
3. Insuficiencia mitral moderada.
4. Absceso periaórtico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta que puede ser respondida desde el sentido común. Si no nos dicen que el paciente tiene un cuadro clínico compatible con endocarditis infecciosa, las lesiones valvulares descritas pueden tener etiología reumática, degenerativa. el derrame pericárdico es un hallazgo frecuentísimo en infinidad de patologías entre las que no se encuentra la EI. En cambio el absceso paravalvular es una complicación propia de la EI (sobre todo las protésicas).

101. ¿Qué actitud tomaría ante un hombre de 25 años con un nódulo tiroideo indoloro, de 4 cm. de tamaño, de reciente aparición, frío en la gammagrafía, con estudio hormonal normal, y con abundantes células foliculares en la punción aspiradora con aguja fina?:

1. Levotiroxina a dosis sustitutivas y reevaluar a los 6 meses.
2. Levotiroxina a dosis supresoras y reevaluar a los 3 meses.
3. Tiroidectomía total.
4. Administrar Yodo131.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el estudio de los nódulos fríos del tiroides la PAAF es la prueba más importante. Los resultados pueden ser

concluyentes o no concluyentes. Si obtenemos como en el caso células foliculares sin otra información, la PAAF es concluyente, pero no diagnóstica, pues puede tratarse de un adenoma o de un carcinoma. En este caso, está indicada la gammagrafía, que modifica la actuación subsiguiente. Si el nódulo fuera caliente es un adenoma tóxico y se trata con cirugía o radioyodo. Si resultase un nódulo frío, hay que hacer hemitiroidectomía para biopsia; si invadiera cápsula es un carcinoma folicular y habría que completar la tiroidectomía (no precisa linfadenectomía pues sus metástasis son hematógenas), y si no invade es un adenoma, y ya está tratado con la hemitiroidectomía. Este es un caso en el que nos salimos del algoritmo diagnóstico: PAAF folicular, con gammagrafía fría, la indicación sería biopsia mediante hemitiroidectomía. No nos dan esa opción. Como norma general, cuando en un algoritmo no nos den la siguiente opción diagnóstica, escoge la vía del peor resultado posible y síguela; en este caso, además se trata de un nódulo de alto riesgo para malignidad (varón joven aunque sin cumplir el criterio de edad, nódulo frío, crecimiento rápido, grande, indoloro), lo que nos reafirma en, ante la ausencia de opción diagnóstica correcta con hemitiroidectomía, actuar como si fuera la peor opción posible y realizar tiroidectomía completa, que en el peor de los casos requerirá tratamiento oncológico adyuvante, mientras que en el mejor de los casos requerirá tan solo tratamiento tiroideo sustitutivo.

102. En un paciente que presenta un cuadro agudo de cuadro confusional, oftalmoparesia por afectación del sexto par bilateral y ataxia de la marcha pensaría en:

1. Encefalopatía hiperglucémica.
2. Encefalopatía de Korsakoff.
3. Infarto cerebeloso.
4. Administrarle inmediatamente tiamina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Triada típica de la encefalopatía de Wernicke. Ojo, no de Korsakoff que se trata de un cuadro crónico de afectación de la memoria que puede aparecer una vez que ha desaparecido la encefalopatía de Wernicke o sin que aparezca ésta. En ambos la etiología es déficit de tiamina, respuesta correcta la 4. Recordad que ante la sospecha de Wernicke hay que administrar tiamina i.v. antes que sueros glucosados.

103. La gastroscopia es una prueba diagnóstica fundamental para el estudio del paciente con hemorragia digestiva, y la urgencia en la realización de la misma dependerá de la magnitud de la hemorragia digestiva. ¿Podría señalar cuál de las siguientes situaciones NO expresa una mayor magnitud y por tanto gravedad de la hemorragia?:

1. Hipotensión y taquicardia.
2. Disminución del hematocrito y hemoglobina.

3. Repetidos y frecuentes episodios de hematemesis con sangre roja asociada a rectorragia.
4. Afectación del nivel de consciencia del paciente.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las constantes vitales así como el estado general del paciente son los dos indicadores de gravedad más importantes en la valoración inicial de un paciente hipovolémico por sangrado (opciones 1 y 4 ciertas). En hemorragias digestivas altas de gran flujo con tránsito intestinal rápido, la HDA puede manifestarse como una rectorragia. Asimismo, la hematemesis es normalmente signo de mayor gravedad que las melenas (Opción 3 cierta). El hematocrito y la Hb hasta pasadas unas horas del sangrado pueden no reflejar inicialmente de forma adecuada la gravedad del sangrado. Este concepto ya ha sido preguntado en el MIR.

104. Ante los siguientes hallazgos analíticos: Hemoglobina 8,5 gr/dL, VCM 85 fl, Bilirrubina normal, hierro sérico 10 microg/dL, capacidad de fijación total de hierro 200 microg/dL, índice de saturación de la transferrina 15% y ferritina 150 microg/dL. ¿Qué tipo de anemia pensaría que tiene el paciente?:

1. Anemia por déficit de vitamina B12.
2. Anemia inflamatoria (de proceso crónico).
3. Anemia ferropénica.
4. Anemia por déficit de ácido fólico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Vamos a analizar los valores alterados de esta analítica: - Hemoglobina disminuida (normal entre 13-18) - VCM en el límite bajo de la normalidad (normal entre 80 -100) (respuestas 1 y 4 incorrectas) - Bilirrubina normal - Hierro sérico disminuido (normal entre 40 - 170) - Capacidad total de fijación de hierro disminuida (normal entre 250 -450) (respuesta 3 incorrecta) - IST disminuido (normal entre 20-50%) - Ferritina aumentada (respuesta 3 incorrecta) Con estos valores la única respuesta posible es la anemia de trastornos crónicos en la que se produce un bloqueo del paso de hierro almacenado a los eritroblastos, eritropoyesis disminuida y acortamiento de la vida media del hematíe.

105. ¿Cuál de las siguientes lesiones vasculares cerebrales conlleva un menor riesgo de sangrado intracraneal?:

1. Angioma venoso.
2. Malformación arteriovenosa.
3. Cavernoma.
4. Aneurisma micótico de la arteria cerebral media.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los angiomas venosos son malformaciones vasculares con un bajísimo riesgo de sangrado, a diferencia del resto de opciones, que entran dentro del diagnóstico diferencial de la hemorragia intraparenquimatosa y subaracnoidea.

106. Hombre de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril que consulta por presentar de forma brusca afasia y hemiparesia derecha que desaparece en doce horas. EcoDoppler de troncos supraaórticos: ateromatosis carotídea bilateral con estenosis del 55% en la carótida izquierda, y del 30% en la derecha. Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 90 lpm. TAC craneal: normal. Para la prevención de nuevos episodios su tratamiento inicial sería:

1. Acenocumarol, ajustándolo a la dosis que consiga un INR de 2.5.
2. Ácido acetil salicílico: 300 mg al día.
3. Clopidogrel: 75 mg al día.
4. Angioplastia transluminal percutánea carotídea izquierda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un paciente que sufre un AIT y que en la evaluación etiológica se objetiva una fibrilación auricular y una estenosis carotídea menor del 70%. El diagnóstico sería de ictus hemisférico izquierdo por doble causa (aterotrombótica y cardioembólica). En este caso no habría que realizar endarterectomía ni angioplastia ya que la estenosis no es superior al 70% y habría que anticoagular al paciente con acenocumarol por la presencia de fibrilación auricular (AIT de etiología cardioembólica). Recordad que en Neurología se intenta evitar la anticoagulación y la antiagregación (si hay que elegir, preferimos siempre proteger de la FA).

107. Trabajando como médico rural recibimos, en la urgencia de un centro de salud situado a 100 Km del hospital, una fractura abierta de tobillo por caída en la montaña, presentando una contaminación grave por restos vegetales y tierra. Nuestra actitud terapéutica debe ser:

1. Nula, evacuación inmediata solicitando transporte aéreo.
2. Antibioterapia, profilaxis antitetánica, retirada de contaminación grosera, lavado inicial, cobertura y estabilización provisional para traslado inmediato.
3. Antibioterapia, profilaxis antitetánica, retirada de contaminación grosera, sutura de aproximación para cierre de la herida, inmovilización provisional y traslado inmediato.

4. Antibioterapia, profilaxis antitetánica y traslado inmediato.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja en la que lo más importante es el sentido común y no confundirnos al señalar las opciones, puesto que todas son parecidas pero no iguales. Lo esencial de esta pregunta es comprender que debemos realizar la primera atención de la fractura abierta y trasladar lo más rápido posible al paciente al hospital de referencia. Las opciones primera cuarta y quinta las podemos descartar por sentido común ya que son medidas claramente insuficientes. Las dudas pueden surgir entre la segunda y la tercera. Fijaos que la única diferencia entre ambas es el tipo de cobertura que utiliza. En la tercera propone una "sutura de aproximación para cierre de la herida" que está claramente contraindicado puesto que es una fractura abierta contaminada con materia orgánica. Lo más importante es retirar la contaminación grosera, lavado con Suero Salino (unos 2-3 L inicialmente) cobertura de la herida con gasas o compresas, estabilización inicial mediante una férula de escayola, vacunación antitetánica e inicio de antibioterapia intravenosa, sueroterapia, analgesia, dieta absoluta y traslado del paciente.

- 108. Los remanentes de quilomicrón son retirados de la circulación por el hígado mediante un proceso que requiere la siguiente apoproteína:**

1. Apo B100.
2. Apo E.
3. Apo CII.
4. Apo AI.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los lípidos son insolubles en suero, por lo que forman estructuras llamadas lipoproteínas que permiten su transporte. Para ello, se unen a distintos tipos de apoproteínas, que aparte de conformar un armazón para la lipoproteína intervienen en su metabolismo. Los triglicéridos se transportan unidos a ApoB-48 y Apo B-100. La B-48 es producida en los enterocitos para formar los quilomicrones que transportan los triglicéridos de la dieta. También hay Apo B-48 en los quilomicrones residuales, que resultan de la hidrólisis de quilomicrones en tejidos periféricos por la enzima lipoproteinlipasa, presente en el endotelio. Recuerda que la Apo B-100 es una apolipoproteína de origen hepático y por ello aparece en las lipoproteínas de origen hepático (VLDL y sus derivadas IDL, y LDL). Por otro lado sabemos que la Apo-E actúa como llave que permite la captación hepatocitaria de lipoproteínas, por lo que está presente en las que se dirigen o retornan al hígado, es decir, quilomicrones desde el intestino, e IDL y VLDL de la sangre y HDL de los tejidos (opción 2 correcta). Parte de las LDL se retiran de sangre por el receptor LDL hepático, parte persisten en la circulación, se oxidan, y son captadas por los macrófagos, favoreciendo la aterogénesis. Las Apo

A1 y A2 son componentes estructurales de las HDL. Las HDL se encargan de retirar colesterol del torrente sanguíneo y degradarlo por vía hepática. Como resumen general, las Apo-B transportan colesterol hacia tejidos, favoreciendo la aterogénesis, mientras que las Apo-A retiran colesterol del plasma y son antiaterogénicas. El cociente ApoB/A elevado se ha revelado en algunos estudios como un factor predictor independiente de riesgo aterogénico.

- 109. Paciente de 40 años con febrícula y síndrome constitucional (astenia, anorexia, pérdida de peso), que presenta epistaxis recurrente con dolor en tabique nasal. Se realiza una radiografía de tórax en la que se aprecian infiltrados pulmonares cavitados bilaterales. Se practica una analítica con estos resultados: 12.000 leucos/mm³ con 68% neutrófilos (7.800 por mm³), 23% linfocitos (2760 por mm³), 5% monocitos (600 por mm³) y 1% eosinófilos (120 por mm³), creatinina normal, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo con patrón citoplasmático positivos. ¿Qué entidad sospecharía en este paciente?:**

1. Poliarteritis Nodosa clásica.
2. Granulomatosis alérgica de Churg Strauss.
3. Granulomatosis con poliangeítis.
4. Arteritis de Takayasu.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos están describiendo una granulomatosis con poliangeítis o enfermedad de Wegener de la que no debes olvidar los siguientes datos guía para el MIR: Sinusitis ("Todo lo que pueda ver un otorrino, es territorio Wegener" pero ¡jojo!, la sinusitis también puede estar presente en casos de Churg-Strauss), datos de vasculitis, infiltrados pulmonares cavitados no migratorios y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo con patrón citoplasmático (c-ANCA). Algunos datos útiles para descartar las otras opciones: la PAN clásica no tiene afectación pulmonar y no se detectan ANCA. La arteritis de Takayasu es una entidad rara que cursa con estenosis de ramas vasculares, fundamentalmente de la aorta, con síntomas derivados de hipoperfusión en zonas distales.

- 110. En relación al aumento de la prevalencia de la obesidad y la inactividad física en la población, se ha incrementado la frecuencia de un trastorno denominado síndrome metabólico. Señale cual de las siguientes características NO forma parte del síndrome metabólico:**

1. Aumento de la concentración plasmática de colesterol LDL.
2. Hipertensión arterial.
3. Hiperglucemia en ayunas.
4. Aumento del perímetro de la cintura abdominal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El concepto de síndrome metabólico, o síndrome X, o síndrome de resistencia insulínica, se acuñó para definir la situación de pacientes, obesos o no, con aumento del perímetro abdominal y resistencia insulínica, que asocian numerosos factores de riesgo vascular. Los criterios más aceptados para el diagnóstico son los propuestos por la ATP III en 2005, debiendo cumplirse tres o más entre los siguientes: 1. Aumento del perímetro abdominal (más de 102 cm en varones y 88 en mujeres); 2. Triglicéridos superiores a 149 mg/dL (o tratamiento hipolipemiente); 3. HDL menor de 40 mg/dL en varones o 50 mg/dL en mujeres; 4. Tensión arterial mayor de 130/85 mmHg (o tratamiento antihipertensivo); 5. Alteración de glucosa en ayunas (mayor a 99 mg/dL) o diagnóstico previo de DM-2. Fíjate que el colesterol LDL, importante factor de riesgo cardiovascular, NO ES UN CRITERIO de síndrome metabólico, y que no es necesaria obesidad demostrada con IMC patológico, basta un aumento del perímetro abdominal.

111. Un paciente de 46 años de edad acude por vómitos en posos de café y melenas. El hematocrito de entrada es del 33%, su presión arterial es de 110/70 mmHg y su frecuencia cardiaca de 87 latidos por minuto. Un estudio endoscópico practicado 5 horas después de su ingreso revela alguna erosión superficial limpia en el tercio distal del esófago y varias erosiones superficiales en la zona antral prepilórica, una de ellas con un punto de hematina en su base. No quedan restos hemáticos en la cavidad gástrica. El paciente se había medicado con diclofenaco 150 mg/día los últimos 8 días por una cialgia. ¿Cuál sería la actitud más recomendable?:

1. Tratamiento con inhibidores de la bomba de protones por vía oral y alta hospitalaria para seguimiento posterior en consulta.
2. Tratamiento erradicador de *Helicobacter pylori* de forma empírica y alta hospitalaria.
3. Tratamiento hemostático con sonda de calor de la erosión con hematina en su base y perfusión endovenosa de inhibidores de la bomba de protones durante tres días.
4. Ayuno total y tratamiento con perfusión endovenosa de inhibidores de la bomba de protones durante 48 horas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un paciente joven que sufre un episodio de HDA mientras está en tratamiento con un AINE. El paciente al llegar a la urgencia se encuentra hemodinámicamente estable. Carece de sentido erradicar el HP de forma empírica porque la causa más probable de la HDA es el consumo de AINES (opción 2 falsa). Por último debemos decidir el tratamiento del paciente; dado que son úlceras Forrest III (fibrina- no tiene hemorragia activa) sólo precisa IBP vo y no requiere tratamiento endoscópico. Además, como es un paciente

joven, sin comorbilidades y que está hemodinámicamente estable puede ser dado de alta con tratamiento con IBPs (opción 1 correcta) sin necesidad de tratamiento parenteral ni ingreso hospitalario (opción 4 falsa).

112. Una chica de 27 años, asintomática, le consulta porque en una revisión de la empresa le han detectado alteraciones analíticas. Aporta los siguientes resultados: hematíes $4.9 \times 10^{12}/L$, hemoglobina 9 g/dL, VCM 75 fl, leucocitos $6.2 \times 10^9/L$, plaquetas $220 \times 10^9/L$, bilirrubina total 12 micromol/l (normal: 5 – 17), LDH 2.8 microkat/l (normal: 1.7 – 3.2), sideremia 20 micromol/l (normal: 9 – 27) y ferritina 180 microg/l (normal: 10 – 200). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Anemia ferropénica.
2. Anemia hemolítica.
3. Anemia sideroblástica.
4. Beta talasemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Lo primero de todo ante una pregunta con muchos datos analíticos es analizar cuales son normales y cuales no, en este caso podemos resumirlo en: -Hematíes algo aumentados en número (típico de las talasemias por un intento de compensar la falta de hemoglobina) - Anemia con VCM muy disminuido (las talasemias son las anemias con VCM más bajo) -Leucocitos y plaquetas normales -Bilirrubina y LDH normal (en la anemia hemolítica estarían elevados) -Sideremia y ferritina normal (en la anemia ferropénica y sideroblástica estarían alterados) Así con estos datos la única respuesta que parece coincidir es la beta talasemia.

113. Una mujer de 24 años acude a urgencias remitida por su médico de Atención Primaria porque al realizarle una analítica por astenia, artralgias febrícula y aparición de edemas maleolares, objetiva anemia normocítica normocrómica (hemoglobina de 9 gs/dL), creatinina sérica de 2 mgs/dL, sedimento con microhematuria y proteinuria en tira reactiva de 500 mgs/dL. ¿Cuál o cuáles serían las exploraciones complementarias que usted solicitaría en primer lugar dado el diagnóstico de presunción?:

1. Biopsia renal.
2. Tomografía axial computarizada renal.
3. Test de Coombs, haptoglobina, ferrocinetica.
4. C3, C4, ANA, AntiDNA.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La paciente presenta clínica general sugerente de proceso sistémico (astenia, artralgias, febrícula, anemia normocítica-normocrómica) y síndrome nefrítico (FRA, hematuria y proteinuria). Por ello, lo más razonable es realizar un despistaje de enfermedad autoinmune sistémica

mediante perfil de autoinmunidad (con ANA y antiDNA de doble cadena) y complemento (C3 y C4) (respuesta 4 CORRECTA). Otros estudios complementarios (serologías, crioglobulinas, etc) se plantearían posteriormente. La biopsia renal se realizaría más tarde en el proceso diagnóstico para filiación histológica final, en función de los hallazgos de pruebas previas. La TC (valorar lesiones macroscópicas estructurales) y el estudio de anemia hemolítica autoinmune (Coombs, haptoglobina, ferrocínica) no aportan nada al diagnóstico actual.

114. Un paciente de 80 años con antecedentes de insuficiencia renal crónica y diabetes tipo 2, presenta desde hace 3 días tos con expectoración purulenta, fiebre alta, dificultad respiratoria y dolor costal derecho. En la exploración presenta una presión arterial de 120/60 mmHg, frecuencia cardíaca de 80 lpm, y respiratoria de 20 rpm. La temperatura es de 38°C; se encuentra algo confuso y parcialmente desorientado. Presenta crepitantes localizados en la base pulmonar derecha y la Rx de tórax muestra un infiltrado de pequeño tamaño en esa localización. ¿Cuál de las siguientes es la opción de tratamiento antibiótico más adecuada?:

1. Azitromicina más Cefuroxima oral, en domicilio.
2. Amoxicilina-clavulánico IV más Gentamicina IV, hospitalizado.
3. Ceftriaxona IV más azitromicina VO, hospitalizado.
4. Ciprofloxacino IV, hospitalizado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con neumonía adquirida en la comunidad que presenta como factores de riesgo sus comorbilidades (DM e IRC), la edad y el síndrome confusional, por lo que tiene criterio de ingreso. Debe tratarse cubriendo bien tanto neumococo como atípicas, siendo las opciones más frecuentes: Betalactámico + Macrólido o Quinolona respiratoria, por tanto la opción 3.

115. ¿En qué gen deben buscarse mutaciones en un paciente joven afecto de un carcinoma medular de tiroides para determinar si existe un riesgo familiar a padecer una neoplasia endocrina múltiple (MEN)?:

1. RET.
2. APC.
3. MSH2.
4. cKIT.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El síndrome de neoplasias endocrinas múltiples (MEN 2) se caracteriza por carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma

y tumores de paratiroides (hiperparatiroidismo) - MEN 2A: con fenotipo normal - MEN 2B: con ganglioneuromas y hábito marfanoide. El defecto genético se localiza en el cromosoma 10 por alteraciones del protooncogen RET (screening mediante identificación del protooncogen RET en sangre periférica). Respecto al resto de opciones: - APC: alterado en la poliposis colónica familiar (5q21). - MSH2: síndrome de Lynch I (cáncer de colon familiar no polipóide). - cKIT: tumores del estroma gastrointestinal (GIST).

116. ¿Cuál de los siguientes fármacos cree que tiene más posibilidades de inducir un parkinsonismo atrópico?:

1. Quetiapina.
2. Cisapride.
3. Risperidona.
4. Clozapina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta algo complicada. Dentro de los neurolepticos, los atípicos (opciones 1, 3 y 4) producen menos parkinsonismo que los típicos (haloperidol, tiapride.), pero también lo producen. Dentro de los atípicos, el que mayor poder parkinsonizante tiene es la risperidona (opción 3), que es la respuesta correcta. Nos puede surgir la duda con la cisapride, que es una ortopramida que se usa como procinético, pero a diferencia de otras de su familia (cleboprida, metoclopramida), ésta no tiene efecto antidopaminérgico y por lo tanto no produce parkinsonismo.

117. Ante un paciente, con antecedentes de haber recibido hace 5 años radioterapia sobre hipófisis, que llega a Urgencias estupefacto, con presión arterial sistólica de 70 mm Hg, fiebre de 39 °C y con sudoración fría, lo primero que debe hacerse es:

1. Practicar cultivos (hemocultivos, urocultivos) para localizar el foco infeccioso.
2. Administrar hidrocortisona y tiroxina.
3. Colocar una vía con cloruro sódico al 0,9% e hidrocortisona.
4. Colocar una vía con cloruro sódico al 0,9%, glucosa al 10% e hidrocortisona.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nuestro paciente fue radiado de un tumor hipofisario, por lo que debemos considerarlo como una potencial insuficiencia suprarrenal secundaria. Un paciente con insuficiencia suprarrenal debe llevar claramente una identificación con él (brazalete, colgante), para que en caso de accidente, coma... se piense en administrarle corticoides. En este caso, llega hipotenso, sudoroso, con fiebre muy elevada, lo que sugiere una crisis suprarrenal, obliga a un tratamiento enérgico con fluidoterapia y glucocorticoides (que no se debe retrasar a la espera de la realización ni de resultados del test de ACTH),

y a descartar la presencia de infección como desencadenante de la situación. El manejo práctico de este paciente debe pasar por la fluidoterapia y la administración urgente de corticoides a altas dosis. Para prevenir esta situación, los pacientes deben conocer que ante situaciones de estrés metabólico (infección, cirugía) deben doblar la dosis habitual de corticoide. La fluidoterapia para mantener vivo al paciente debe realizarse con suero salino isotónico, y en ocasiones coloides. Pero debes recordar que la insuficiencia suprarrenal cursa con hipoglucemia, por lo que estos pacientes deben manejarse con sueros glucosados, para prevenir o tratar la aparición de hipoglucemia.

118. La criptosporidiosis, que está causada por *Cryptosporidium parvum*, cursa como una enteritis benigna en personas previamente sanas, pero en personas con inmunodepresión causa una enfermedad grave. En estas formas graves su diagnóstico convencional se efectúa por:

1. Serología.
2. Hemocultivo.
3. Examen microscópico de las heces (Tinción de Ziehl-Neelsen modificada).
4. Coprocultivo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Exámen de heces, como casi todas las parasitosis del tubo digestivo.

119. Varón de 80 años que consulta por síncope de esfuerzo. Refiere además ángor de esfuerzo de un año de evolución, por el que no había consultado. A la exploración física llama la atención un soplo sistólico eyectivo en foco aórtico que se escucha también en las carótidas. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la patología que padece este paciente:

1. Suele requerir tratamiento quirúrgico en personas mayores, la edad no suele ser una contraindicación para el recambio valvular.
2. En la actualidad existe una alternativa vía percutánea o transapical para pacientes añosos seleccionados.
3. La muerte súbita es una complicación poco común de los pacientes con estenosis aórtica sintomática.
4. Cuando la estenosis aórtica se hace sintomática está indicada la sustitución valvular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La estenosis aórtica es la valvulopatía más preguntada en el examen y hay que dominarla. La EAo más frecuente globalmente es la degenerativa o senil. Recuerda que es una valvulopatía que se tolera muy bien y pasa asintomática muchos años. Mientras es asintomática el riesgo de muerte

súbita es muy bajo (salvo en niños y adolescentes), pero cuando los síntomas aparecen (angor, síncope o disnea, habitualmente en este orden de aparición) el riesgo de muerte súbita se dispara y el pronóstico se ensombrece, por lo que es preciso realizar el recambio valvular. Es importante que recuerdes que, actualmente, la edad sin más no contraindica la cirugía cardíaca (piensa que los pacientes con EAO en general tiene >75 años). De hecho, con la aparición de las válvulas protésicas aórticas transcáteter (TAVI), las indicaciones se han ampliado, puesto que estas prótesis de reciente aparición pueden implantarse a mayores de 80 años con alto o medio riesgo quirúrgico.

120. Tras un accidente de coche llega al Servicio de Urgencias una paciente de 34 años inconsciente, hipotensa, disneica y con fracturas abiertas en ambas extremidades inferiores. En la valoración inicial o revisión primaria rápida y resucitación, usted debe realizar el llamado protocolo ABCDE de la atención al paciente politraumatizado. Este incluye los siguientes pasos, EXCEPTO uno, indique este último:

1. Mantenimiento vía aérea con control de la columna cervical.
2. Análisis del déficit neurológico.
3. Tratamiento de las fracturas abiertas.
4. Desvestir completamente a la paciente y prevenir la hipotermia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla en la que lo único que tenemos que recordar para elegir la opción correcta es conocer el significado del acrónimo ABCDE e ir descartando las diferentes opciones. - En primer lugar ante todo politraumatizado se ha de asegurar la vía aérea (Airway). Opción 1 falsa. - En segundo lugar se comprueba la respiración del paciente (Breathing) y se aplican las medidas necesarias para asegurar una correcta ventilación y oxigenación. - En tercer lugar se analiza el estado de la circulación (Circulation). El objetivo es conseguir la estabilidad hemodinámica. Opción 3 falsa. - En cuarto lugar se analizan los déficits neurológicos que pueda haber sufrido el politraumatizado (Disability) - En quinto lugar se desviste al paciente y se buscan las posibles lesiones externas que pueda haber sufrido (Exposition). Opción 4 falsa. - Lo que no es prioritario es el tratamiento de las fracturas abiertas. Opción 3 correcta. Una de las escasas indicaciones de tratamiento de una fractura en el manejo inicial de un politraumatizado es una fractura de pelvis inestable que condicione un shock hipovolémico por sangrado retroperitoneal, por lo que está indicada la colocación de un fijador externo. Si lo pensamos, estaría indicado porque estaríamos tratando la C.

121. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en un paciente de 33 años con antecedentes familiares de muerte súbita que acude por dolor torácico intenso, de inicio brusco

y en reposo y que en la exploración presenta un soplo diastólico precoz y ausencia del pulso radial izquierdo?:

1. Embolia de pulmón.
2. Derrame pericárdico severo.
3. Neumotórax espontáneo.
4. Disección aórtica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La disección de aorta es un tema clásico y muy preguntado en el MIR. Siempre que en el MIR te pongan un caso clínico de un paciente con dolor torácico debes hacer el diagnóstico diferencial entre un síndrome coronario agudo y una disección aórtica, pues les encanta (a parte de otras patologías, pero su diagnóstico es más sencillo). Hay que fijarse en las características del dolor (inicio, intensidad, irradiación) y los síntomas acompañantes: - Dolor: en los SCA es progresivo (la isquemia se establece de manera progresiva) y en la disección es brusco. El isquémico característicamente es opresivo, intenso, irradiado a zona del nudo de la corbata, brazos (principalmente el izquierdo) y muñecas, aunque es frecuente que irradie a espalda. El de la disección puede ser opresivo, pero muchas veces es como una puñalada, máximo en intensidad, desgarrador y muy característicamente irradia a espalda y puede migrar a lo largo de la espalda según avanza la disección. En ambos casos existe cortejo vegetativo e incluso sensación de muerte inminente, pero estos datos son mucho más llamativos en la disección. - Acompañantes: piensa en la disección cuando te remarquen en el caso clínico los antecedentes de HTA o si presenta una emergencia hipertensiva (la disección aórtica produce una descarga adrenérgica brutal) y cuando haya datos de afectación de algún territorio vascular por progresión de la disección (datos neurológicos, asimetría de pulsos o de TA en ambos brazos) o aparición de un soplo de insuficiencia aórtica (indica que la disección afecta la raíz aórtica). Recuerda una cosa: la disección puede afectar la coronaria derecha y provocar signos electrocardiográficos idénticos a un IAM inferior, pero debes fijarte en el resto de la clínica. Así, el caso clínico lo debes orientar hacia una disección de aorta: dolor brusco, asimetría de pulsos e insuficiencia aórtica. Lo curioso del caso clínico es que nos ponen un paciente más joven de lo habitual y que además tiene antecedentes familiares de muerte súbita. Es lógico pensar que debe tener alguna patología hereditaria que predispone a la disección y, aunque no nos lo digan, hay que pensar que tiene una enfermedad de Marfan. No olvides que el tratamiento médico indicado en la disección aórtica es un control exquisito de la TA y de la FC (cuanta más frecuencia cardíaca y más TA, más avanza la disección). Para ello se usan: Betabloqueantes intravenosos: el que permite un mejor control es el esmolol, por su vida media corta, pero también es útil el labetalol, atenolol. Nitroprusiato sódico: suele administrarse junto a betabloqueantes, para el control de la TA. La prueba diagnóstica de elección es el ecocardiograma transesofágico, pero también se emplea la TAC torácica.

122. Señale la correcta en relación con la circuncisión y la prevención de la transmisión de la infección por VIH:

1. En África se ha mostrado eficaz en la prevención de la transmisión de la mujer al hombre.
2. Reduce la transmisión tras relaciones homosexuales entre hombres.
3. Incrementa la transmisión del VIH del hombre a la mujer.
4. El balance costebeneficio es desfavorable en países subdesarrollados.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta absolutamente CRIMINAL, una de las joyitas que ya forman parte de la historia de los exámenes MIR. La opción correcta, la uno, se fundamenta en un metaanálisis que demostró dicha premisa. El fundamento es la presencia de una alta concentración de células de Langerhans en la cara interna del prepucio que actúan como células presentadoras de antígenos.

123. Una joven de 13 años sin antecedentes personales de interés, presenta bruscamente mientras pasea con sus padres por un centro comercial, cuadro vertiginoso asociado a vómitos. Inmediatamente después, refiere parestesias en hemicuerpo derecho y disartria, que remiten en pocos minutos, y a continuación cefalea, que mantiene a su llegada al centro de salud. Señale la respuesta correcta:

1. El diagnóstico más probable es el de síncope vasovagal.
2. Si la exploración física es normal no se requieren más estudios.
3. Se debe evaluar la existencia de estímulos desencadenantes.
4. El empleo de analgésicos y antieméticos no son aconsejables en este supuesto.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos exponen un caso de migraña con aura basilar (síntomas vertebrobasilares seguidos de cefalea que posteriormente se autolimita), más típica de niños y adolescentes. Se pueden usar analgésicos y antieméticos para tratar los síntomas. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con AIT vertebrobasilares, que son muy improbables en niños y no van seguidos de cefalea. Es recomendable realizar análisis, ECG y prueba de imagen para descartar otras causas. La opción 3 es correcta, hay que buscar desencadenantes.

124. En la cirugía del cáncer de esófago es importante conocer bien la anatomía esofágica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. El esófago tiene capa mucosa, capa muscular y capa serosa.
2. El esófago abdominal es más largo que el cervical.
3. El epitelio esofágico normal es cilíndrico.
4. El esófago torácico pasa por detrás del cayado aórtico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El esófago es un órgano que se caracteriza por no tener capa serosa (opción 1 incorrecta) por lo que es más fácil que se produzca una perforación que en órganos con esta capa. El esófago mide unos 25 centímetros, la porción más larga es la torácica seguida del esófago cervical que es más largo que el abdominal que sólo mide dos centímetros (opción 2 incorrecta). El diámetro normal del esófago es de 2-3 centímetros y se sitúa por detrás del cayado aórtico (opción 4 correcta). El epitelio normal del esófago es un epitelio plano poliestratificado (opción 3 incorrecta) que soporta bien las agresiones mecánicas producidas por el paso del bolo alimenticio pero mal la agresión del ácido en la ERGE por lo que en estos casos sufre una metaplasia a epitelio intestinal cilíndrico (Esófago de Barret). Pregunta poco rentable por ser poco probable de volver a ser preguntada.

125. Las siguientes afirmaciones referidas a los virus de la hepatitis C (VHC) y al virus de la hepatitis D (VHD), EXCEPTO una, son correctas. Señala la respuesta INCORRECTA:

1. El VHC fue una importante causa de hepatitis postransfusional, especialmente en los años 70 y 80.
2. El VHD es un virus defectivo con un genoma de RNA y una cápside que contiene el antígeno de superficie del VHB.
3. El VHD se transmite fundamentalmente por vía fecal-oral.
4. El genotipo más frecuente del VHC en España es el 1.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El VHA y E (los de las vocales) son los virus que se transmiten por vía fecal-oral mientras que las VHB, C y D presentan transmisión sanguínea/sexual (opción 3 incorrecta, opción 1 correcta). El VHD se caracteriza por ser un virus defectivo que es incapaz de transmitirse por sí solo ya que necesita la cubierta del VHB para formar los viriones (Opción 2 correcta). El VHC se caracteriza porque hasta en un 80% de los casos se cronifica, un 20% de ellos desarrollan una cirrosis y un porcentaje no despreciable termina padeciendo una hepatocarcinoma. El genotipo más frecuente en nuestro medio es el 1 (opción 4 correcta).

126. Paciente de 62 años, fumador importante, que presenta masa en lóbulo inferior derecho con diagnóstico de carcinoma no microcítico de

pulmón que infiltra la grasa mediastínica y rodea al esófago, desplazándolo. No hay evidencia de adenopatías mediastínicas afectadas por tumor. El paciente es operable. ¿Cuál de estas actitudes le parece más adecuada llegado este momento?:

1. El paciente presenta un carcinoma broncogénico no microcítico estadio IV (T4N0M0), por lo que no es resecable. Se debe tratar con quimioterapia y radioterapia.
2. El paciente presenta un carcinoma broncogénico no microcítico estadio clínico IIIa (T4N0M0). La realización de una ecoendoscopia esofágica que determine el grado de afectación de la pared del esófago sería útil para plantear una posible extirpación, aunque se debe empezar con quimioterapia y radioterapia.
3. El paciente presenta un carcinoma broncogénico no microcítico estadio clínico IIIa (T4N0M0), por lo que en ningún caso es resecable. Se debe administrar tratamiento paliativo con quimioterapia.
4. El paciente presenta un carcinoma broncogénico no microcítico estadio clínico IIb (T4N0M0). La realización de una ecoendoscopia esofágica que determine el grado de afectación de la pared del esófago sería útil para plantear una posible extirpación, aunque se debe empezar con quimioterapia y radioterapia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un carcinoma no microcítico, IIIa, T4 N0 M0. Podemos descartar de entrada la 1 y la 4 por estadificación incorrecta. Como generalidad, los tumores en estadio T4 son irresecables (es decir, el acto quirúrgico no es potencialmente curativo) porque invaden estructuras vitales, y por tanto el tratamiento es exclusivamente paliativo, con QT (que aumenta la supervivencia) y RT paliativa (para manejo de las complicaciones). Sin embargo, hay que distinguir tres situaciones. Por una parte, hay T4 por el gran tamaño tumoral sin infiltración de estructuras vecinas (T4 por nodulos múltiples o por diámetro >7cm); en estos casos SI que hay opción de curación, y el tratamiento es Cirugía sucedida de quimioterapia, con o sin radioterapia según márgenes de resección (MIR 2018). Cuando el T4 se debe a invasión de estructuras, es incurable con cirugía y se plantea tratamiento con quimio-radioterapia paliativa. De los T4 por infiltración de estructuras, hay dos casos en que se plantea añadir cirugía paliativa. Son tan solo dos casos: T4 por invasión cardíaca limitada a la aurícula izqda y T4 por afectación esofágica limitada a la capa muscular. En ambos, el tumor es incurable pero puede provocar graves secuelas, luego se puede plantear cirugía paliativa añadida al tratamiento habitual (QT-RT) En este caso concreto, tenemos un T4-N0-M0, por tanto IIIa, teóricamente incurable pero capaz de provocar una clínica invalidante por disfagia. Dado que el paciente es operable, si la invasión es limitada a la capa muscular se plantea una cirugía con exéresis tumoral y esofágica, para prevenir la

mas que posible disfagia obstructiva, y con posibilidad de prolongar la supervivencia, aunque la intención no es curativa; si la invasión llega hasta la mucosa no existe tal opción. Por ello es necesario realizar una ecoendoscopia esofágica a este paciente. TECNICA MIR: La opción 3 es demasiado tajante “NINGUN CASO es resecable”; acabamos de ver que hay excepciones. Probablemente en un sentido “etimológico” estricto sea cierto (el concepto de resecabilidad hace referencia a la posibilidad de curación en un único acto quirúrgico, y la intención de esta cirugía no es curativa), pero esa no es la interpretación que se suele hacer del concepto de resecabilidad. La opción 2 es más abierta, te deja la opción de operar o no, y además no entra en el matiz de si es curativa o no, por lo que es mucho más adecuada.

127. Respecto a la enfermedad de Crohn. ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto?:

1. El proceso inflamatorio está limitado a la mucosa y a la submucosa superficial, y las capas más profundas permanecen respetadas.
2. Para establecer el diagnóstico de enfermedad de Crohn se precisa la presencia de granulomas no caseificantes.
3. No todos los pacientes con fistulas perianales presentan signos endoscópicos de inflamación en el colon.
4. El tabaco es un factor protector para la enfermedad de Crohn.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La enfermedad de Crohn es una enfermedad de etiología desconocida que se caracteriza por la afectación transmural (opción 1 incorrecta) de todo el tubo digestivo de forma parcheada, pudiendo estar afecto el ano sin que el colon presente afectación alguna (opción 3 correcta). En la anatomía patológica es raro encontrar granulomas no caseificantes, que son patognomónicos, pero no son necesarios para el diagnóstico (opción 2 incorrecta). Esta enfermedad se presenta en personas jóvenes (18-35 años) pero existe un segundo pico de incidencia entre los 50-70 años. El tabaco empeora la enfermedad y es factor de riesgo para padecerla (opción 4 incorrecta). La colitis ulcerosa es una enfermedad que comienza en el recto y que se extiende de forma continua hacia partes más proximales del colon, provocando una alteración de la mucosa únicamente. El tabaco es factor protector de la Colitis Ulcerosa.

128. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones que reflejan las características clínicas de la artritis reumatoide es correcta?:

1. La afectación de la columna lumbar suele aparecer en forma de sacroilitis y es más frecuente que la cervical.
2. La artritis reumatoide se asocia con un aumento de la frecuencia de uveítis.

3. En áreas rurales, la artritis reumatoide es más frecuente en los hombres.
4. El tabaco predispone a la enfermedad y empeora la respuesta a los fármacos biológicos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La artritis reumatoide es una enfermedad que compromete a las articulaciones de forma crónica. Su evolución se ve condicionada por factores genéticos y ambientales, como el tabaquismo. Así, el tabaco hace más probable la aparición de una artritis reumatoide (por citrulinización de aminoácidos en el pulmón) y empeora la respuesta a los fármacos biológicos (respuesta 4 cierta). Con respecto a las opciones falsas: 1.- La afectación axial es rara, pero de producirse, el segmento de la columna más afectado es el cervical, con afectación atlantoaxoidea (única articulación sinovial). 2.- La afectación ocular que debes recordar como asociada a AR es la escleritis y episcleritis (no la uveítis). Es frecuente la asociación con el síndrome de Sjogren 3.- La AR es más frecuente en mujeres 3:1, independiente de la localización o el medio estudiados.

129. Ante la presencia de una masa hepática asintomática descubierta de forma casual, es FALSO:

1. La biopsia hepática de la lesión será de utilidad para instaurar una terapia no quirúrgica.
2. Se debe establecer el diagnóstico diferencial entre hiperplasia nodular focal y el adenoma hepático.
3. El hemangioma cavernoso se diagnostica por resonancia con contraste de gadolinio al ser muy intenso en T2.
4. El tratamiento de elección de la hiperplasia nodular focal es quirúrgico por la posibilidad de malignidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante una masa hepática asintomática descubierta de forma casual, lo primero es realizar una ecografía que nos permite distinguir entre sólida y líquida y dar una aproximación diagnóstica. Posteriormente se suele realizar un TAC o RM que nos define la lesión dándonos un diagnóstico de sospecha que en muchas ocasiones puede ser suficiente. Sin embargo, en caso de dudas siempre debemos realizar una biopsia hepática que es la prueba que nos dará el diagnóstico definitivo. Esto es especialmente importante si no vamos a reseca la lesión, ya que tenemos que estar seguros de que ésta es benigna (opción 1 correcta). Las opciones 2 y 3 son ciertas, la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepático y el hemangioma son tres de las lesiones benignas más frecuentes que requieren hacer diagnóstico diferencial; caracterizándose el hemangioma por captar gadolinio en la secuencia T2. Por último, debemos recordar que la hiperplasia nodular focal no requiere tratamiento quirúrgico.

pues es benigna y no suele acarrear ninguna complicación. La lesión benigna que puede degenerar es el Adenoma hepático.

130. Consulta una paciente de 72 años por cefalea, dolorimiento del cuero cabelludo, dolor mandibular con la masticación, febrícula, hiporexia, pérdida de peso y dolor en las cinturas escapular o pelviana. ¿Qué alteración de laboratorio de entre los siguientes no esperaría encontrar en la vasculitis que usted sospecha?:

1. Anemia normocítica-normocrómica.
2. Leucopenia.
3. Aumento de fibrinógeno.
4. Elevación de enzimas de colestasis (GGT y FA).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos cuenta el caso de una arteritis de células gigantes. En esta vasculitis es muy característica la elevación de la VSG y el aumento de reactantes de fase aguda (como el fibrinógeno). Es común además la anemia por bloqueo medular y la trombocitosis. También es posible ver elevación de enzimas de colestasis por fenómenos de granulomatosis hepática asociada. La serie blanca, sin embargo, no suele alterarse.

131. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas, el pulso paradójico (disminución de la presión arterial de más de 10 mmHg durante la inspiración), no está presente en la exploración física?:

1. Estenosis aórtica.
2. Taponamiento cardíaco.
3. Pericarditis constrictiva.
4. Embolia pulmonar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El pulso paradójico es un tema que ha sido preguntado en numerosas ocasiones y lo convierte en el pulso arterial más preguntado. La definición que te dice la pregunta es la correcta y es la exageración de un fenómeno que nos ocurre a todos de manera fisiológica: Al inspirar, aumentamos el retorno venoso a las cavidades derechas y se sobrecarga el VD. Para adaptarse, se expande hacia afuera y también hacia adentro, empujando el tabique interventricular e impidiendo el llenado completo del VI. Con esto, disminuye la precarga del VI y, por la ley de Starling disminuye la fuerza de contracción y puede caer ligeramente la tensión arterial sistólica de manera fisiológica. El pulso paradójico es típico del taponamiento cardíaco: el pericardio lleno de líquido impide que el VI se expanda hacia afuera con lo que desplaza mucho el tabique y se impide de manera muy marcada el llenado del VI. De este modo, con la inspiración cae la TAS >10mmHg. Pero piensa que, cualquier situación que impida la correcta expansión del VD hacia afuera

(pericarditis constrictiva, las bullas pulmonares en un paciente enfisematoso.) o una gran sobrecarga de volumen al VD por un gran retorno venoso en la inspiración (en el TEP, en un EPOC reagudizado o en un asmático severo realizan un gran trabajo respiratorio con inspiraciones muy profundas que generan mucha presión negativa en el tórax y mucho retorno venoso), pueden hacer que se desplace mucho el tabique interventricular y dar lugar a pulso paradójico. Fíjate que tienen que ser patologías que afecten de manera predominante al VD. Por ello, la estenosis aórtica no tiene pulso paradójico.

132. Un paciente de 25 años inició hace 6 semanas un cuadro de diarrea con sangre y fiebre por lo que fue tratado con amoxicilina/clavulánico durante 7 días sin mejoría. Ante la persistencia de los síntomas se practica una colonoscopia que demuestra un recto normal y la presencia de aftas en sigma y úlceras longitudinales en colon transversal. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha más probable?:

1. Colitis por Clostridium Difficile.
2. Colitis ulcerosa.
3. Colitis amebiana.
4. Enfermedad de Crohn.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La presentación clínica, el tiempo de evolución y la edad del paciente nos indican que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y dada la colonoscopia, más concretamente una Enfermedad de Crohn (Opción 4 correcta). Se trata de un paciente joven con un cuadro de diarrea crónica sanguinolenta que no responde al tratamiento antibiótico (el cuadro no comienza después de tomar el antibiótico por lo que no puede ser una colitis por Clostridium difficile y la opción 1 es incorrecta). Ahora nos queda diferenciar si se trata de una E. de Crohn o una Colitis Ulcerosa. El hecho de que la afectación sea parcheada y no continua y las úlceras longitudinales nos indica que no se trata de una colitis ulcerosa (opción 2 incorrecta). La colitis amebiana se da en pacientes con riesgo por haber ingerido agua en mal estado, la clínica puede ser similar a la enfermedad de Crohn pero la colonoscopia nos hubiera orientado en ese sentido (opción 3 incorrecta) y nos hablarían además posiblemente de abscesos hepáticos (Amebiasis = colitis + abscesos hepáticos + viaje a zonas templadas).

133. Un paciente de 63 años, con insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva, en situación estable (en clase funcional I según grado de disnea), presenta en el ecocardiograma disfunción sistólica severa (Fracción de Eyección < 30). ¿Qué grupo de fármacos estaría más indicado como tratamiento inicial?:

1. Digitálicos.
2. Inhibidores de la ECA.

3. Antagonistas de Calcio.
4. Espironolactona.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla si tienes los conceptos claros: Se trata de un paciente con ICC por disfunción sistólica asintomático. En esta situación, los primeros fármacos indicados son los IECAs. Por supuesto que los B-bloqueantes también están indicados, pero fíjate que la pregunta nos pide el que estaría más indicado como tratamiento inicial. En esta situación son los IECAs. Los diuréticos se añaden para mejorar los síntomas de congestión, la digoxina cuando a pesar del tratamiento médico óptimo y diuréticos el paciente está en un grado funcional II-III y sobre todo si está en FA y los antagonistas del calcio tipo verapamil o diltiazem están contraindicados, mientras que podemos usar los dihidropiridínicos para el control de la TA.

134. ¿Cuál de las siguientes contraindica la nutrición parenteral?:

1. Pancreatitis aguda grave.
2. Fístula yeyunal.
3. Resección subtotal de intestino delgado.
4. Expectativa de ayuno de menos de 5 días.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La nutrición parenteral es la administración de soluciones de elementos nutritivos directamente en el torrente sanguíneo. Puede ser parcial -cuando el aporte i.v. suplementa al aporte enteral- o total -cuando la totalidad de las necesidades nutritivas se aportan por esta vía-. Según la vía de acceso puede ser periférica (vena cefálica o basilica) o central (vena subclavia o yugular interna). Las vías periféricas se utilizan en períodos cortos porque en tiempos prolongados se producen flebitis. La nutrición parenteral está indicada cuando existe imposibilidad para satisfacer las necesidades nutricionales de pacientes con procesos médicos o quirúrgicos más allá de 7 días, por vía digestiva. Algunas de las situaciones que pueden requerirla son: fístulas intestinales de alto débito, pancreatitis agudas graves (también puede utilizarse la nutrición enteral administrada post-píloro por sonda nasoyeyunal), peritonitis con íleo intestinal, síndrome del intestino corto, obstrucción intestinal, intolerancia a nutrición enteral, enteritis por radio o quimioterapia. Obviamente, esta contraindicada la nutrición parenteral, por ausencia de indicación, en la opción 4 (menos de 5 días de ayuno).

135. ¿En cuál de estas posibles causas desencadenantes de Insuficiencia Cardíaca NO existe incremento del gasto cardíaco?:

1. Tirotoxicosis.
2. Taquiarritmia.
3. Anemia.
4. Fiebre.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla, que se responde sin dificultad si recuerdas las causas de ICC de alto gasto y que son: Enf. Paget ósea Beri-beri (déficit tiamina) Fístulas A-V Hipertiroidismo Anemia Embarazo Anafilaxia En resumen, son situaciones en las que aunque el aporte de O₂ por parte del miocardio es incluso superior a lo normal, es insuficiente para los requerimientos, porque se hallan muy elevados. En una taquicardia, lo primero que se afecta es la diástole. A mayor FC menor diástole, menor llenado ventricular y, a menor precarga menor fuerza de contracción y menor gasto, por la Ley de Starling. Así, las taquiarritmias son causa de ICC por bajo gasto.

136. Un hombre de 72 años de edad con sólo antecedentes de hipercolesterolemia bien controlada, leve depresión y enfermedad por reflujo gastroesofágico controlada con omeprazol, acude al Servicio de Urgencias por presentar desde hace 12 horas dolor intenso en fosa iliaca izquierda y aumento del número de deposiciones (hasta 4/día), líquidas pero sin productos patológicos. A la exploración se observa dolor a la palpación superficial y profunda en fosa iliaca izquierda, ruidos presentes y no signos de irritación peritoneal. La analítica urgente es normal salvo leucocitosis (16,3 103/microL) con desviación izquierda. Se le realiza un TAC abdominal urgente en el que se describe imágenes sugerentes de diverticulosis con signos de diverticulitis aguda sin datos de perforación o absceso asociado. ¿Qué actitud terapéutica considera más correcta?:

1. Realización de colonoscopia urgente.
2. Colocación urgente de un drenaje percutáneo, dirigido por TAC, en área inflamada.
3. Observación hospitalaria con dieta absoluta y administración de ciprofloxacino y metronidazol por vía i.v.
4. Intervención quirúrgica urgente para extirpar zona del colon inflamada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla. Pregunta larga de la que sólo nos interesan las últimas líneas. En el comienzo de la pregunta nos cuentan una diverticulitis clásica (dolor en fosa iliaca izquierda, alteraciones del ritmo intestinal y leucocitosis con desviación) que luego nos confirman con un TAC al final del todo. A este respecto debemos recordar que aunque la mejor prueba para diagnosticar los divertículos es la colonoscopia, esta está totalmente contraindicada en paciente con diverticulitis aguda ante el riesgo de que se produzca una perforación del divertículo inflamado. Lo mismo sucede con el enema opaco. Una vez con el diagnóstico sólo nos queda recordar que el tratamiento de elección de la diverticulitis aguda es el tratamiento de mantenimiento

con antibioterapia adecuada (opción 3), salvo que exista algún tipo de complicación como un absceso que requiera drenaje o una perforación libre que requiera una cirugía para resección del colon afecto.

137. Una mujer de 70 años consulta por astenia y anemia ferropénica que no presentaba en análisis del año anterior. En el estudio se demuestra un cáncer intestinal. ¿En qué lugar estará más frecuentemente localizado?:

1. Duodeno.
2. Yeyuno.
3. Ciego.
4. Sigma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Para contestar debemos darnos cuenta de que no nos preguntan la localización más frecuente de un cáncer de colon sino en esta paciente, es decir, que debuta con anemia ferropénica. Teniendo esto en cuenta la respuesta correcta es el colon derecho/ciego (opción 3 correcta) ya que los tumores del colon izquierdo no suelen producir sangrados sin otra sintomatología, sino que es más frecuente que se presenten con alteraciones del ritmo intestinal (opción 4 incorrecta) y la neoplasia del intestino delgado es muy poco frecuente (opción 1 y 2 incorrecta).

138. Existen anomalías anatómicas, pero habitualmente la arteria gastroepiploica izquierda es una rama directa de una de las siguientes arterias:

1. Mesentérica inferior.
2. Mesentérica superior.
3. Esplénica.
4. Gástrica derecha.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad alta que obliga a conocer bien el tronco celiaco. El tronco celiaco es una arteria que sale de la aorta. Posteriormente se divide en tres ramas. La primera es la arteria esplénica que irriga el bazo pero antes de llegar a este órgano da una rama colateral que es la gastroepiploica izquierda (opción 3 correcta) que irriga la parte superior de la curvatura mayor del estómago. La segunda rama es la coronaria estomáquica o coronaria izquierda que irriga la porción proximal de la curvatura menor. Por último está la arteria hepática común que da la arteria hepática propia que se dirige al hígado, gástrica derecha que irriga la curvatura menor distal y se anastomosa con la coronaria estomáquica y la gastroduodenal que más tarde se divide en gastroepiploica derecha que se anastomosa con la izquierda e irriga la porción distal de la curvatura mayor y la pancreatoduodenal proximal que se une con la distal, rama de la mesentérica.

139. Lo abajo mencionado respecto a la Resistencia a la insulina es cierto, EXCEPTO:

1. Su incidencia continúa decreciendo en países occidentales.
2. Esta relacionada con la obesidad.
3. Se relaciona con niveles plasmáticos bajos de adiponectina.
4. Hay hiperinsulinismo e hiperglucemia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pese a su apariencia, la pregunta es fácil porque todos sabemos que la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la insulinoresistencia van en aumento en los países desarrollados. La resistencia a la insulina es un trastorno de prevalencia creciente en la sociedad occidental, debido al estilo de vida sedentario y al aumento de la obesidad. Se relaciona directamente con la obesidad abdominal, que también se empieza a denominar “adiposidad” para indicar que es un trastorno del tejido adiposo, un tejido que clásicamente se consideraba inerte pero hoy día se sabe tiene un importante papel endocrino. El aumento del perímetro abdominal se correlaciona con descenso de los niveles de adiponectina sérica, y con un aumento de la resistencia a la insulina (medida como índices que correlacionan la glucemia y la insulinemia, como el índice HOMA). Hay otros síndromes que cursan con resistencia insulínica, como el síndrome de ovario poliquístico o la acantosis nigricans, y que obligan a screening de diabetes.

140. Una de las siguientes patologías NO es un factor predisponente para el desarrollo de un colangiocarcinoma:

1. Litiasis intrahepática.
2. Parasitosis por Clonorchis Sinensis.
3. Colangitis esclerosante primaria.
4. Hemocromatosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Esta pregunta es sencilla si leemos bien el enunciado. Nos piden que busquemos la enfermedad que no se relaciona con el COLANGIOCARCINOMA. Si echamos una mirada rápida a las respuestas vemos que todas las opciones se relacionan con tumores hepáticos pero la dificultad estriba en darse cuenta de que la HEMOCROMATOSIS se relaciona con el HEPATOCARCINOMA y no con el Colangiocarcinoma (Opción 4 falsa). El resto de opciones (litiasis intrahepática, Clonorchis Sinensis Y colangitis esclerosante primaria) si que se relacionan con el colangiocarcinoma. De todas ellas la que no podéis olvidar es la Colangitis Esclerosante Primaria. Hasta un 20% de estos pacientes acaban desarrollando un Colangiocarcinoma debido a la inflamación crónica de la vía biliar que tienen, que acaba desembocando en displasia.

141. La alteración más frecuente de las pruebas de función pulmonar en los supervivientes del Síndrome de Destrés Respiratorio del Adulto es:

1. Disminución de la complianza pulmonar.
2. Disminución de la capacidad de difusión.
3. Aumento de resistencia de la vía aérea.
4. Hipertensión pulmonar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta tramposa y de escasa relevancia de cara al MIR. En el SDRA, la alteración funcional más precoz y que es necesaria para el diagnóstico es la alteración de la distensibilidad pulmonar. Para diagnosticar distress es preciso reunir clínica y radiología compatibles con la exclusión de EAP cardiogénico (presión de enclavamiento normal), con descenso de la distensibilidad (menor de 60 ml/cmH₂O) y alteración grave del intercambio gaseoso (cociente Pa/Fi menor de 200). Ello no implica que la alteración de la distensibilidad sea la alteración funcional más prevalente a largo plazo en los pacientes con distress (y que sobreviven). Hay una discreta discrepancia en la literatura. En una serie corta de 8 pacientes, la alteración más frecuente, encontrada en 4/8, fue una alteración restrictiva, encontrándose alterada la DLCO en tan solo 2/8 pacientes. Sin embargo, en el resto de series publicadas el hallazgo más constante es la alteración de la DLCO, en torno al 75% de los pacientes supervivientes. Considerados todos los pacientes reportados, la alteración más prevalente es el descenso de la DLCO. En cualquier caso, esta pregunta no debe alterar tu enfoque del estudio del distress respiratorio. Debes conocer las causas (inflamación sistémica, inflamación pulmonar), la clínica y manifestaciones, el diagnóstico (recuerda el cociente Pa/Fi menor de 200) y el tratamiento (etiológico y soporte vital, incluyendo ventilación mecánica con PEEP).

142. Señale cuál de las siguientes medidas NO es adecuada para evitar la progresión de la nefropatía diabética:

1. Restricción de proteínas en la dieta.
2. Control glucémico estricto en los diabéticos tipo 1.
3. Control glucémico estricto en los diabéticos tipo 2.
4. Incremento de la presión de perfusión glomerular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal en el mundo occidental, y cursa en 5 estadios clínicos consecutivos que debes conocer (hiperfiltración, microalbuminuria intermitente, microalbuminuria persistente, nefropatía clínica y nefropatía terminal). La nefropatía diabética se maneja de una forma global: - Inicio de IECA/ARA-II desde la aparición de microalbuminuria persistente en adelante (estadios III y IV), para evitar la hiperpresión glomerular y la hiperfiltración (respuesta 4 falsa, por tanto CORRECTA). - Control tensional en los hipertensos (es el tratamiento más efectivo para reducir la progresión) - Control glucémico es necesario, y reduce la progresión cuando aun no hay nefropatía establecida (estadios I a III). - Control más

estricto de la hipercolesterolemia (objetivos LDL < 70 mg/dl a partir de estadio III). - Restricción proteica moderada, aún sin alto grado de evidencia, para evitar la sobrecarga proteica y por tanto reducir la proteinuria; esta recomendación no está basada en estudios sino opinión de expertos.

143. En un enfermo con una clínica de pérdida de fuerza progresiva de 48 horas de evolución que se inició a nivel distal, y ha ido ascendiendo progresivamente, una de las siguientes afirmaciones es FALSA:

1. Los hallazgos neurofisiológicos aparecen antes de que sea evidente la clínica.
2. Vigilaría la aparición de complicaciones por neuropatía autónoma.
3. Esperaría encontrar disociación albúminocitológica a partir de los 10 días desde el inicio del cuadro.
4. Indicaría tratamiento con Inmunoglobulinas intravenosas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las respuestas 2, 3 y 4 son correctas. Recordad la afectación autonómica en el Guillain-Barré (arritmias, hiper/hipotensión), la disociación albúminocitológica (que generalmente tarda unos días en aparecer) y el tratamiento con inmunoglobulinas o plasmáferesis. Los hallazgos electrofisiológicos aparecen (paradójicamente) tarde, generalmente de 2 a 3 semanas tras el inicio de la clínica.

144. Las pautas cortas (3 días) de tratamiento antibiótico de la infección urinaria, NO se aconsejan en el caso de:

1. Infección por Proteus Mirabilis.
2. Género masculino.
3. Presencia de más de 105 unidades formadoras de colonias por microlitro de cualquier bacteria.
4. Infecciones por Staphylococcus Saprophyticus.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las pautas cortas de antibiótico no se recomiendan en infecciones complicadas, como son las del varón, anciano, inmunodeprimido, diabético, embarazada, portador de catéteres. El germen no lo condiciona, solo su multiresistencia sería criterio de complicación.

145. La sinovitis de la artritis reumatoide asocia las alteraciones siguientes, SALVO una. ¿Cuál?:

1. Hipertrfia vellosa de la sinovial.
2. Focos de necrosis caseiforme.
3. Hiperplasia del lecho que bordea los sinoviocitos.
4. Infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, macrófagos y fibroblastos activados.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Las alteraciones que se deben recordar en la Artritis Reumatoide a nivel microscópico se pueden resumir de la siguiente manera: Hipertrofia vellosa e hiperplasia de sinoviocitos, vasodilatación y edema, infiltración de linfocitos y células plasmáticas y focos de necrosis fibrinoide en superficie y en profundidad. Cuando la lesión está muy evolucionada forma una masa que se proyecta en la cavidad articular y da lugar al pannus, que destruye el cartilago articular y los ligamientos, erosionando el hueso subcondral. La necrosis caseiforme es típica de la tuberculosis o algunos tipos de enfermedad infecciosas, como la tularemia o la histoplasmosis. (OPCIÓN 2 CORRECTA).

146. En un periodo de 3 meses, un hombre de 42 años ha presentado cuatro episodios de desconexión de su entorno, asociados con postura distónica de la mano derecha y movimientos de masticación, de un minuto de duración, quedando a continuación confuso y con dificultad para la expresión verbal durante 10 minutos. Después se recupera con normalidad pero no recuerda lo que le ha ocurrido. ¿Cuál es la actitud más correcta?:

1. Iniciar tratamiento con clobazam oral y realizar un electroencefalograma (EEG).
2. Iniciar tratamiento con carbamacepina y realizar una resonancia magnética (RM) y un EEG.
3. Realizar un EEG y una RM de forma ambulatoria y esperar los resultados antes de iniciar el tratamiento.
4. Ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos e iniciar tratamiento con fenitoína intravenosa.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Ha presentado 4 episodios de crisis parciales complejas. Estaría indicado iniciar tratamiento puesto que normalmente a partir de la segunda crisis se suele iniciar tratamiento. Además, en todo estudio de epilepsia hay que realizar neuroimagen (preferiblemente RMN) y EEG.

147. El mecanismo principal de acción de la tenecteplasa (TNK) en los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST es:

1. Estimular el complejo protrombinasa y la formación de trombina.
2. Estimular la conversión de plasminógeno en plasmina.
3. Bloquear el receptor GP IIb/IIIa de las plaquetas.
4. Inhibir la formación de trombina y plasminógeno.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sólo formulada en el MIR 2008, pero que no es difícil. El TNK o tenecteplase es un derivado del rt-PA, que es el activador tisular del plasminógeno. Debes recordar algún concepto básico de la coagulación: las dos vías (intrínseca y extrínseca) lo que pretenden es la activación de la trombina (de protrombina a trombina) que transforma el fibrinógeno en fibrina, que genera el tapón hemostático (el coágulo). Por su parte, existen los mecanismos de degradación de la fibrina (los fibrinolíticos), para romper el coágulo, y que fundamentalmente lo compone la plasmina (que se activa desde plasminógeno a plasmina) y que degrada la fibrina. Por lo tanto, el TNK degrada la fibrina al activar el plasminógeno en plasmina, al igual que el rt-PA.

148. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al tratamiento de la hepatitis crónica viral es FALSA?:

1. Una respuesta viral sostenida (negativización del ARN en dos determinaciones separadas 12 semanas) en la hepatitis crónica C se considera curación de la infección viral.
2. Una respuesta viral mantenida (negativización del ADN) en la hepatitis crónica B se considera curación de la infección viral.
3. En la actualidad el tratamiento de la hepatitis crónica C tiene una gran efectividad y muy escasos efectos secundarios.
4. La duración del tratamiento antiviral en la hepatitis crónica C es de unos pocos meses, a diferencia del VHB que requiere tratamiento crónico mantenido.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

El concepto de RVS significa curación en el VHC y se consigue en un muy alto porcentaje de pacientes gracias a los antivirales de acción directa (opciones 1 y 3 ciertas). En el VHB, sin embargo, lo que se consigue con los antivirales (Entecavir, Tenofovir, Lamivudina) es suprimir la replicación viral y el paciente tiene que tomarlos de forma crónica (opción 4 cierta). La curación del VHB ("Hepatitis B pasada") se define como la negativización del HBsAg (opción 2 falsa).

149. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker?:

1. No existe tratamiento endoscópico para esta patología, teniendo que abordarse por cirugía cervical abierta.
2. Suele diagnosticarse en pacientes jóvenes.
3. El tratamiento incluye la miotomía del músculo cricofaríngeo.
4. La pirosis es su síntoma principal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El divertículo de Zenker es una patología que se presenta característicamente en personas de edad avanzada (opción 2 falsa) por una falta de relajación del Esfínter Esofágico Superior (EES) durante la deglución. Esto provoca una protusión de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular, es decir, un divertículo por pulsión; en la cara posterior de la hipofaringe. La clínica característica de esta enfermedad es la presencia de regurgitaciones de alimentos almacenados en el divertículo y la disfagia por la barrera que supone el EES a la deglución (opción 4 falsa) además de halitosis. El tratamiento consiste en la realización de una miotomía del músculo cricofaríngeo (opción 3 verdadera) que actualmente puede hacerse vía endoscópica de forma menos invasiva (opción 1 falsa); este músculo es el que forma el EES y al realizar la miotomía se evita esta obstrucción al paso del bolo alimenticio.

150. Paciente de 18 años que acude a urgencias por presentar sangrado pulsátil a nivel de muñeca derecha después de corte accidental con un cristal. A su llegada a urgencias se coloca manguito de presión en brazo derecho a una presión de 120 mmHg con disminución y desaparición del sangrado. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. El sangrado es probable que sea debido a la sección de la arteria cubital localizada en el margen lateral de la muñeca.
2. El sangrado es secundario a la sección accidental de la arteria humeral.
3. Posiblemente la sección de la arteria radial es la causante del sangrado pulsátil.
4. La vena cefálica, medial al tendón del músculo palmar mayor debe ser la causante del sangrado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta una serie de datos: -. El sangrado es pulsátil por lo que se trata de un sangrado arterial. -. La arteria braquial o arteria humeral es la arteria del brazo. Sigue su trayectoria hacia abajo y hacia adentro y se coloca medial al bíceps llegando hasta el canal bicipital interno, donde se divide en sus dos ramas terminales: la arteria radial y la arteria cubital o ulnar. -. La arteria radial es una rama de la arteria humeral. comienza aproximadamente un centímetro por debajo de la flexura del codo, y discurre por la cara lateral del antebrazo hacia la muñeca, donde es fácilmente palpable en el espacio comprendido entre el tendón del palmar mayor y la porción inferior saliente del borde anterior del radio. (RESPUESTA 3 CORRECTA) -. La arteria cubital es la rama interna de la bifurcación de la arteria humeral y va desde el centro del pliegue del codo por el borde MEDIAL del brazo hasta el lado interno de la región palmar. Si no fuera por el dato falso "lateral", también podría ser correcta.

151. Un hombre de 43 años, ingeniero de profesión, ha permanecido durante 7 meses en la RD del Congo. A los 8 días de su regreso, comienza con un cuadro de fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, náuseas y dolor abdominal. A la exploración: esplenomegalia y discreta hepatomegalia. En la analítica sanguínea destaca: Hb 9,8 gr/dl; Leucocitos 3465 mm³, plaquetas 97.000, AST 121, ALT 119 y Na 129. Es FALSO sobre esta patología que:

1. Para su diagnóstico es útil un frotis y una gota gruesa.
2. Se habría evitado con una profilaxis adecuada.
3. Es una enfermedad potencialmente mortal.
4. Las medidas de barrera son fundamentales en la prevención.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Es una MALARIA, que es lo primero a sospechar siempre ante una fiebre del viajero que proviene de África. Aunque existe la profilaxis para los viajeros a zonas de riesgo solo se indica para aquellas personas que van a estar un período corto en zonas de riesgo, pero no para aquellos que van a permanecer en un área de riesgo durante más de 2 meses, en estos casos se recomienda tratamiento precoz. Todas las demás opciones son ciertas.

152. El hallazgo más frecuente en la radiografía de tórax en un paciente con asma es:

1. Hiperinsuflación pulmonar.
2. Condensaciones alveolares bilaterales y difusas.
3. Radiografía de tórax normal.
4. Engrosamiento de paredes bronquiales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La radiografía de tórax de un paciente asmático en intercrisis (que es su situación habitual) es normal. En una crisis asmática aparecen datos de hiperinsuflación: aplanamiento de diafragmas, horizontalización de costillas, aumento de los espacios claros retroesternal y retrocardíaco. A diferencia de en el EPOC tipo enfisema, no suele haber cambios crónicos (como bullas). Como complicación de la crisis puede aparecer neumotorax o neumomediastino.

153. ¿Cuál de las siguientes sustancias forma parte de la secreción biliar?:

1. Carboxipeptidasa.
2. Tripsina.
3. Elastasa.
4. Lecitina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil y con poca importancia tanto de cara al MIR como a la medicina clínica. La lecitina (opción 4 correcta) es un fosfolípido presente en la secreción biliar que sirve para solubilizar los ácidos biliares. El resto de opciones son enzimas presentes en la secreción pancreática.

154. Paciente de 40 años que acude al Servicio de Urgencias tras sufrir un traumatismo directo sobre el brazo izquierdo al caer de la motocicleta. La exploración clínica es la siguiente: dolor, movilidad anormal e impotencia funcional en la zona media del brazo, pulsos distales humeral y radial presentes, imposibilidad para realizar la extensión activa de la muñeca y dedos, e hipoestesia en la zona dorsal del primer dedo y del primer espacio interdigital. Las radiografías muestran una fractura conminuta del tercio medio del húmero. ¿Cuál es la lesión asociada más probable que presenta?:

1. Lesión arteria humeral y nervio mediano.
2. Lesión nervio cubital.
3. Lesión nervio radial.
4. Lesión nervio mediano.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad baja dado que ha sido motivo de pregunta MIR en sucesivas ocasiones. El paciente presenta "imposibilidad para realizar la extensión activa de la muñeca y dedos, e hipoestesia en la zona dorsal del primer dedo y del primer espacio interdigital". Sabiendo que el Nervio Radial es el encargado de inervar a la musculatura extensora podemos marcar la tercera opción como correcta. La mayoría de las lesiones del nervio radial en fracturas de húmero se producen en tercio medio y tercio distal, y suelen ser neurapraxias o axonotmesis que recuperan progresivamente la función tras unos 3 ó 4 meses. - Recordad la importancia de la exploración neurovascular distal ante cualquier fractura o luxación tanto a la llegada del paciente al servicio de Urgencias como después de reducir la fractura.

155. Mujer de 30 años que consulta porque en una revisión de empresa le han detectado un hemograma normal, con leucocitos $35 \times 10^9/L$ (60% segmentados, 12% cayados, 16% mielocitos, 4% metamielocitos, 7% linfocitos, 1% monocitos), hemoglobina 12.7 g/L, VCM 89 fL, HCM 28 pg, reticulocitos $46 \times 10^9/L$ y plaquetas $389 \times 10^9/L$. La morfología eritrocitaria es normal. En el resto de análisis destaca un ácido úrico de 8 mg/dL y una LDH de 650 UI/L. Su estado general está conservado, sin ningún otro síntoma que una ligera sensación de astenia desde hace 23 meses. No ha perdido peso, no tiene fiebre ni ningún síntoma de infección ni de dolor. La exploración física muestra la presencia de una esplenomegalia de 12 traveses

de dedo por debajo del reborde costal como único hallazgo. La paciente no es fumadora y no tiene antecedentes de interés excepto que hace seis meses se le practicó otro hemograma que mostró una cifra leucocitaria de $14 \times 10^9/L$, que se atribuyó a una infección respiratoria que resolvió sin problemas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso?:

1. Leucocitosis reactiva.
2. Leucemia mieloide crónica (LMC).
3. Mielofibrosis en etapa incipiente.
4. Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante una leucocitosis de predominio mielocítico y sin hiato leucémico (presencia de leucocitos en distintos estadios madurativos, presencia de formas maduras pero con los precursores de la serie mieloide inmadura presentes) asociado a esplenomegalia y a elevación ácido úrico y LDH, debemos pensar en un síndrome mieloproliferativo crónico. La leucocitosis reactiva no cursaría con esplenomegalia y en un periodo de 6 meses lo más normal sería que remitiera, no que aumentara (respuesta 1 incorrecta). La mielofibrosis daría lugar a un cuadro leucoeritroblástico en sangre periférica y suele cursar con anemia (respuesta 3 incorrecta). La LMMC es un síndrome mielodisplásico que cursaría con citopenias periféricas y dismielopoiesis y no tendría esplenomegalia (respuesta 4 incorrecta). Los síndromes mielodisplásicos cursan sin esplenomegalia y sin leucocitosis. Así la respuesta correcta es LMC que suele diagnosticarse como hallazgo casual en una analítica rutinaria (asintomático en 50% de pacientes) o tener manifestaciones clínicas por el hipermetabolismo (astenia, disnea) o hepatoesplenomegalia.

156. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta en relación con la aplasia medular:

1. Cursa con pancitopenia.
2. Se trata con trasplante de médula ósea.
3. Puede responder al suero antitímocítico (ATG).
4. Cursa con eritroblastos en sangre periférica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La aplasia medular es una insuficiencia medular cuantitativa, es decir, cursa con disminución o desaparición de los precursores hematopoyéticos, con la consiguiente pancitopenia: anemia hiporegenerativa (reticulocitos disminuidos), granulocitopenia y trombocitopenia, sin evidencia de infiltración neoplásica ni síndrome mieloproliferativo. Para su tratamiento existen varias líneas en función de la edad del paciente, gravedad de la aplasia y presencia o ausencia de donantes HLA compatibles. Entre estos tratamientos cabe destacar: - Inmunosupresores: globulina antilinfocítica y antitímocítica (ALG/ ATG), corticoides, ciclosporina, andrógenos. - Trasplante alogénico

de médula ósea -Tratamiento de soporte: transfusiones , G-CSF.. Al ser la médula ósea hipocelular o acelular no se evidencian eritroblastos en sangre periférica (respuesta 4 incorrecta), como si ocurriría en las anemias mieloptísicas secundarias a ocupación de la médula ósea por procesos patológicos.

157. Señalar la respuesta correcta en relación con la osteomielitis vertebral:

1. La forma más común de afectación vertebral es la diseminación por contigüidad de un foco parameningeo.
2. El agente causal más frecuente es *Escherichia coli*.
3. La resonancia magnética es el procedimiento diagnóstico de elección.
4. La evolución sólo con tratamiento médico es generalmente desfavorable.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La RMN es la prueba diagnóstica de elección. El microorganismo más frecuente es *S. aureus* y la forma más común de afectación es la diseminación hematógena. La mayoría de los casos responden al tratamiento antibiótico.

158. Un paciente VIH positivo presenta una gran masa abdominal, adenopatías a nivel supra e infradiafragmático, sudoración nocturna y fiebre. La biopsia ganglionar muestra una proliferación difusa de células de mediano tamaño no hendidas, con un citoplasma intensamente basófilo con vacuolas, CD19 y CD20 positivas, y reordenamiento del protooncogén C-MYC. De entre las siguientes entidades cuál es el diagnóstico más probable:

1. Linfoma folicular.
2. Enfermedad de Hodgkin.
3. Linfoma de Burkitt.
4. Linfoma de células del manto.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Este es un caso típico de linfoma de Burkitt variedad epidémica (asociada a SIDA). La variedad occidental y la epidémica del linfoma de Burkitt suelen presentarse como masa abdominal en un 70% de casos. Los datos clave para poder responder esta pregunta son las células características de la biopsia (pequeño tamaño no hendidas, citoplasma basófilo con vacuolas) y la traslocación (8;14) que implica al protooncogen C-MYC. Es importante saberse las traslocaciones típicas de cada linfoma porque ya han aparecido en exámenes MIR de otros años.

159. Un hombre de 30 años presentó un tumor intracerebral frontal derecho que no captaba contraste con los métodos de imagen. Se le

realizó una lobectomía frontal. Se le aplicó radioterapia asociada a temozolomida. Al cabo de 8 años se produce una recidiva del tumor, que ahora muestra con los métodos de imagen captación de contraste y áreas de necrosis. El estudio histológico estableció el diagnóstico de:

1. Gangliocitoma.
2. Astrocitoma Pilocítico.
3. Glioblastoma.
4. Meduloblastoma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos dan varias pistas para contestar esta pregunta. En el rango de edad del paciente los tumores primarios más frecuentes son los gliomas. El tratamiento (cirugía mas RT más TEMOZOLAMIDA) es el de los gliomas, y la evolución nos sugiere que el paciente tuvo un glioma de grado bajo/intermedio (no captaba contraste) que recidivó con un grado de malignidad superior (glioblastoma: capta contraste y necrosis), algo típico de este tipo de tumores.

160. ¿Qué tenemos que hacer cuando en una pancreatitis aguda grave se demuestra por el cultivo, realizado en la punción-aspiración con aguja fina guiada por TAC abdominal, infección de la necrosis pancreática?:

1. Iniciar tratamiento antibiótico y mantener actitud conservadora.
2. Cambiar la nutrición parenteral por enteral.
3. Tratamiento quirúrgico: desbridamiento o necrosectomía.
4. Necrosectomía guiada por ecoendoscopia: Necro-gastrostomía con prótesis de aposición luminal y desbridamiento endoscópico de la colección.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de la PA necrotizante infectada es la antibioterapia de amplio espectro, siendo el Imipenem de elección. No está indicado cambiar la nutrición a parenteral (en la PA SIEMPRE se prefiere la enteral salvo contraindicación importante como el íleo). El tratamiento quirúrgico debe reservarse como última opción y actualmente casi no se utiliza. Si el paciente no evolucionara bien con AB debería plantearse el desbridamiento mediante métodos poco invasivos, siendo el más utilizado en la actualidad el que se comenta en la opción 4.

161. Un paciente de 60 años, fumador, con historia de disnea de un año de evolución presenta una auscultación de crepitantes y se comprueban acropaquias. La TC torácica demuestra una afectación reticular en la periferia del pulmón. El diagnóstico más probable es:

1. Neumonitis por hipersensibilidad.
2. Neumonía organizada criptogénica.
3. Fibrosis pulmonar idiopática.
4. Neumonía intersticial no específica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El paciente tiene una clínica sugerente de enfermedad intersticial: varón de 40-60 años, disnea progresiva, con aparición de acropaquias y crepitantes rudos en ambas bases. La enfermedad intersticial "por defecto" es la fibrosis pulmonar idiopática. Aparece en pacientes varones de 40-60 años, sin antecedentes relevantes, y cursa con la clínica general de enfermedad intersticial. Si se añadiera algún dato extraño, deberíamos plantearnos alternativas. Por ejemplo, en fumadores, con macrofagos pigmentados en esputo, hablaríamos de neumonitis intersticial descamativa. Por ejemplo, si tuviera asma y eosinofilia y cuadro constitucional nos plantearíamos neumonía eosinofílica crónica. Por ejemplo si tuviera clínica sugerente de neumonía bacteriana aguda pero con infiltrados radiológicos intersticiales y con el antecedente de haber empezado a trabajar en una tienda de animales, pensaríamos en neumonía por hipersensibilidad aguda. Pero en ausencia de otra clínica, el diagnóstico más probable es fibrosis pulmonar idiopática. En la placa de tórax o el CT de alta resolución se encuentra típicamente tres tipos de hallazgos, que representan distintos momentos evolutivos de la enfermedad (y por tanto no podemos encontrarlos simultáneamente, sino de forma sucesiva): patrón en vidrio deslustrado, patrón intersticial reticular o retículo-nodulillar, y patrón de fibrosis en panal. Dichos hallazgos aparecen con predominio basal, y en localización fundamentalmente periférica/subpleural.

162. Indique qué estructura nerviosa más frecuentemente puede ser lesionada ante un paciente con lesión incisocutánea en región preauricular derecha:

1. Nervio hipogloso derecho.
2. Nervio glosofaríngeo derecho.
3. Nervio neumogástrico derecho.
4. Nervio facial derecho.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las causas más frecuentes de lesiones traumáticas del nervio facial son las heridas en región preauricular y la cirugía de glándula parótida. El nervio facial es el nervio motor de los músculos de la expresión facial, recoge la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y lleva fibras parasimpáticas para la secreción de las glándulas lacrimal, sublingual y submaxilar. (OJO, el control parasimpático de la glándula parótida depende del nervio glosofaríngeo (IX par). Abandona el peñasco por el agujero estilomastoideo, se introduce en el espesor de la parótida y después se divide en sus dos ramas temporales la temporofacial y la cervicofacial.

163. Un niño de 10 años sufrió un accidente de bicicleta y hubo que intervenirle quirúrgicamente por

un hemoperitoneo. Existía una ruptura del bazo y hubo que practicar una esplenectomía urgente. Todas las entidades que se refieren a continuación son más frecuentes en este niño que en la población normal, SALVO una. Señale ésta:

1. Bacteriemias.
2. Úlcera duodenal.
3. Trombosis profunda.
4. Neumonías.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un niño que ha sido esplenectomizado. Esto le predispone a sufrir infecciones por bacterias encapsuladas como el meningococo, haemophilus o neumococo. Por esta razón está predispuesto a sufrir bacteriemias, meningitis y neumonías (opciones 1 y 4 correctas). También tiene un mayor riesgo de trombosis profunda por la trombocitosis subsiguiente (que además se debe a elementos alterados que deberían haber sido lavados por el bazo) (Opción 3 correcta). Sin embargo, este niño no tiene un mayor riesgo de sufrir una úlcera duodenal, cuya causa más importante es la infección por Helicobacter Pylori que no se relaciona con la esplenectomía (Opción 2 falsa). Es importante revisar en toda persona esplenectomizada que tenga las vacunas recomendadas puestas.

164. En relación con los hipoglucemiantes orales es cierto que:

1. La acarbosa aumenta la secreción de insulina.
2. Las tiazolidindionas bloquean la alfa-glucosidasa intestinal.
3. La metformina reduce la producción hepática de glucosa.
4. No pueden asociarse a la administración de insulina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Es importante conocer el mecanismo de acción de los antidiabéticos orales. Hay fármacos secretagogos de insulina, como las sulfanilureas y la repaglinida. Son fármacos que aumentan la secreción endógena de insulina. Pueden provocar hipoglucemias, y producen aumento de peso al aumentar la síntesis de insulina (hormona lipogénica). Las biguanidas son fármacos que reducen la resistencia insulínica a nivel hepático, disminuyendo la neoglucogénesis. La única en España es la metformina, pues tiene menor tasa que las demás de acidosis láctica. La metformina es el antidiabético de primera elección salvo contraindicación o intolerancia, por lo que conviene conocerlo perfectamente para el MIR. Las tiazolidindionas o glitazonas son fármacos que aumentan la sensibilidad a insulina en tejido muscular y adiposo, por activación del receptor PPAR-gamma. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa retrasan la digestión intestinal de hidratos de carbono, por lo que retrasan su absorción y reducen el pico de glucemia postprandial. Con

excepción de las tiazolinodionas (por riesgo de retención hidrosalina), todos los antidiabéticos orales están aprobados en asociación con la insulina.

165. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene una indicación más clara de tratamiento quirúrgico de enfermedad por reflujo?:

1. Paciente de 80 años con hernia hiatal de mediano tamaño y pirosis frecuente que responde bien a 20 mg/día de omeprazol.
2. Paciente de 56 años con molestias epigástricas tipo flatulencia y pirosis intermitente que responde sólo ligeramente al tratamiento con omeprazol.
3. Paciente de 66 años de edad con esofagitis erosiva y antecedentes de infarto de miocardio hace 1 año con insuficiencia cardíaca residual.
4. Paciente de 58 años con pirosis diaria diurna y nocturna de más de 10 años de evolución y que permanece asintomático en los períodos que es tratado con dosis de omeprazol de 40 mg/día o superiores y cuyos síntomas recidivan inmediatamente al reducir esta dosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La cirugía en los pacientes con ERGE está reservada en jóvenes con síntomas claros de ERGE y que responden mal o dependen de los IBP. En el primer caso se trata de un paciente muy mayor que responde bien a dosis estándar de IBP por lo que mejor seguir con ese tratamiento; el segundo no tiene clínica clásica de ERGE (tiene más bien dispepsia. La dispepsia NO es un síntoma de ERGE) y no responde a los IBP por lo que deberían ser estudiados más a fondo. El paciente de la opción 3 sólo presenta esofagitis y tiene un alto riesgo quirúrgico por lo que sería mejor tratarlo con IBP. La opción correcta es la cuatro porque se trata de un paciente joven con clínica clásica importante de ERGE que necesita dosis elevadas de IBP para mantenerse asintomático.

166. En relación con el empleo de la trombolisis en el infarto agudo de miocardio, señale la afirmación FALSA:

1. Es útil para disminuir el tamaño de la zona infartada.
2. Es útil para disminuir las arritmias.
3. Es útil para disminuir la mortalidad.
4. Es útil para limitar la disfunción ventricular izquierda.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta pregunta se formuló en el examen MIR 2008, como novedad, y por ello resulta algo complicada a la hora de encontrar la correcta, pues todas ellas parecen lógicas como efectos del tratamiento fibrinolítico en un IAM. Piensa que

lo que se pretende con la fibrinólisis es repermeabilizar la arteria coronaria que está ocluida por un trombo en su luz. Cuanto antes se abra, menos zona infartada y por lo tanto mejor función ventricular. Además, los fibrinolíticos, sobre todo asociados a AAS disminuyen la mortalidad en un IAM. Por otra parte, la fibrinólisis es tanto más eficaz cuanto menor tiempo de evolución tiene el paciente (cuanto “más fresco esté el trombo”). La mayor eficacia aparece en las 3 primeras horas. Pasadas 6 horas de evolución el trombo está muy organizado y es muy difícil que la fibrinólisis sea eficaz. Por ello, la fibrinólisis sólo es útil en las primeras horas tras un IAM. Se prefiere la angioplastia primaria sobre la fibrinólisis si se puede realizar el cateterismo en menos de 2 horas o si hay shock cardiogénico o contraindicación para la fibrinólisis. Con respecto a las arritmias, cuando se repermeabiliza una arteria ocluida se favorecen un tipo de arritmias que denominamos “arritmias de reperfusión” y se producen por el paso de sustancias retenidas en la circulación por el trombo. La más frecuente es la aparición de RIVAs (la clásica arritmia de reperfusión que indica que la arteria se ha abierto), pero también aparece BAV o incluso FV (respuesta 2 es la falsa).

167. Paciente de 65 años de edad, con antecedentes de haber sufrido un infarto de miocardio hace dos años. Acude al Hospital por un cuadro de malestar general, sudoración y palpitaciones. En el electrocardiograma se observa un ritmo regular a 170 latidos por minuto con complejos QRS de 0.14 segundos. ¿Cuál sería su primer diagnóstico?:

1. Fibrilación auricular paroxística.
2. Taquicardia nodal.
3. Taquicardia ventricular.
4. Taquicardia paroxística supraventricular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que no debes fallar pues es básica para el MIR. Dentro del grupo de las taquiarritmias, las más preguntadas son la FA, las TV y las TSVP. En el MIR, ante una taquicardia regular de QRS ancho (>120 mseg) debes pensar en una TV. No puedes dudarlo si además nos cuentan que tiene antecedentes de IAM previo (la cicatriz del IAM es el sustrato en el que se produce la reentrada que da lugar a la TV) o bien nos cuentan la aparición en el ECG de capturas, fusiones o disociación aurículo-ventricular. En la imagen te ponemos un ejemplo de TV a 150 lpm, regular, de QRS ancho (mayor de 120 mseg).

168. ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA con respecto a las artritis inducidas por microcristales?:

1. Pueden ser producidas por cualquiera de los siguientes cristales: urato monosódico, pirofosfato cálcico, hidroxipatita cálcica y oxalato cálcico.

2. El depósito de cristales puede producir cuadros clínicos similares a la artritis reumatoide o a la artritis séptica.
3. Los cuadros clínicos producidos son específicos para cada uno de los tipos de cristales depositados.
4. Para hacer el diagnóstico es imprescindible el estudio del líquido sinovial con microscopio de luz polarizada para identificar el tipo de cristales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Para diferenciar las artritis por microcristales (urato, pirofosfato, hidroxiapatita y oxalato cálcico) no es suficiente con los hallazgos clínicos y debes acudir a las pruebas complementarias (fundamentalmente, y de manera indispensable, al análisis del líquido sinovial, que mostrará en la mayoría de los casos un líquido de características inflamatorias, pero también a través de algunos datos radiológicos o analíticos en sangre) ya que el cuadro clínico puede ser similar en los diferentes tipos de afectación por microcristales, e incluso similar al de otras entidades como la artritis reumatoide o la artritis séptica (Opción que debes marcar: 3).

169. Se considera indicación de desfibrilador implantable:

1. Extrasístoles ventriculares complejos sintomáticos en paciente sin cardiopatía.
2. Taquicardia ventricular incesante.
3. Fibrilación ventricular que ocurre en la primera hora tras un infarto agudo de miocardio.
4. Parada cardíaca por fibrilación ventricular en paciente con infarto de miocardio crónico anterior extenso.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Este concepto se ha preguntado en varias ocasiones en el MIR. Por ello se incluyó en el manual una tabla que las resume: 1) PREVENCIÓN SECUNDARIA: TV o FV de causa no corregible. 2) PREVENCIÓN PRIMARIA: -IAM crónico (>40 días) y FEVI >30% independiente de NYHA. - Disfunción VI de cualquier etiología con FEVI <35% y NYHA ≥ 2 a pesar de tratamiento médico óptimo. -Miocardiopatías y canalopatías familiares con riesgo de muerte súbita (diferente para cada patología). Por lo tanto, la correcta es la 4: FV sin causa corregible (el infarto no es agudo). - Los extrasístoles en un paciente sin cardiopatía sólo se tratan si son sintomáticos y se hace con beta-bloqueantes. - El DAI trata las arritmias ventriculares malignas (TV o FV) cuando éstas aparecen. La TV incesante es una TV que no se quita (es una tormenta arritmica) y que ocurre ante alteraciones hidroelectrolíticas importantes, isquemia miocárdica o en la fase terminal de una cardiopatía. En esta situación hay que buscar y corregir la causa y es una contraindicación del DAI, pues estaría dando choques

continuos sin poder quitar la arritmia y con el riesgo de degenerarla en FV o provocar depresión de la contractilidad cardíaca. - La FV en las primeras horas de un IAM es muy frecuente y no empeora el pronóstico pues se debe a la inestabilidad eléctrica que produce la isquemia ventricular. Precisa tratamiento con B-bloqueantes y generalmente se asocia amiodarona.

170. Una biopsia renal muestra con el microscopio óptico numerosos glomérulos con semilunas. La inmunofluorescencia presenta un patrón lineal con la IgG. ¿Cuál es el diagnóstico?:

1. Granulomatosis de Wegener.
2. Enfermedad de Goodpasture.
3. Lupus eritematoso sistémico.
4. Poliarteritis microscópica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil que no debes fallar. Recuerda que la ÚNICA glomerulonefritis que cursa con depósitos LINEALES de IgG en la inmunofluorescencia es la GNRP de tipo I (también llamada enfermedad de Goodpasture) (respuesta 1 CORRECTA). Las GMN extracapilares cursan con proliferación inflamatoria en la cápsula de Bowman, con formación de semilunas, dada la intensísima inflamación glomerular. Cursan con síndrome nefrítico con FRA rápidamente progresivo. Hay tres tipos: - Tipo I (Enfermedad de Goodpasture): presencia de IgG anti-MB glomerular en suero. Cursa con depósitos lineales en la inmunofluorescencia - Tipo II: debido a inmunocomplejos. Cursa con hipocomplementemia en sangre - Tipo III (pauciinmune): no hay depósitos inmunológicos en la inmunofluorescencia. Cursa con ANCA en sangre (sobre todo p-ANCA).

171. Un paciente de 52 años con el diagnóstico de úlcus pilórico y vómitos de repetición de una semana de duración acude al Hospital con una tensión arterial de 100/58 mmHg y la siguiente analítica: Plasma: Na⁺ 140 mmol/l, K⁺ 2.2 mmol/l, Cl⁻ 86 mmol/l, CO₃H 42 mmol/l, pH 7.53, pCO₂ 53 mmHg y creatinina 2,9 mg/dl; Orina Na⁺ 2 mmol/l, K⁺ 21 mmol/l, pH 5. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es cierto?:

1. Alcalosis mixta.
2. Acidosis metabólica con vacío aniónico normal.
3. Alcalosis metabólica.
4. Alcaluria paradójica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recuerda que el pH = HCO₃/pCO₂. El paciente presenta un pH superior a 7.45, por tanto en rango de alcalosis. La presencia de alcalosis puede deberse a un defecto de carbonico (alcalosis respiratoria, definida con pCO₂ < 35mmHg) o a un exceso de bicarbonato (alcalosis metabólica, definida

con $\text{HCO}_3^- > 28$). Nuestro paciente tiene HCO_3^- 42 (alto), por lo que se trata de una alcalosis metabólica, estando asimismo la pCO_2 53 (alta) en un intento de compensar el pH. La alcalosis metabólica de este paciente se debe fundamentalmente a deshidratación. El úlcus péptico con estenosis pilórica le provoca vómitos, con pérdida digestiva de agua y HCl, lo que conduce a leve alcalosis por pérdida del ácido clorhídrico gástrico, pero sobre todo a un estado de depleción de volumen que activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona (con retención renal de sodio para elevar la volemia, que se acompaña de expulsión activa de potasio, acompañada de H^+ por intercambio en el túbulo colector). Por ello, pese a que el paciente tiene potasio y H^+ bajos en sangre, están elevados en orina.

172. En un niño de 11 años con asma persistente moderada, y sensibilización a ácaros de polvo doméstico y pólenes de arizónicas, gramíneas y olea, todas las siguientes medidas son recomendables EXCEPTO una:

1. Vacunar anualmente contra la gripe.
2. Emplear como tratamiento de mantenimiento betaagonistas de acción larga en monoterapia.
3. Enseñarle a medir el flujo espiratorio máximo en su domicilio.
4. Evitar o reducir la exposición a los alérgenos a los que esté sensibilizado y a otros irritantes de la vía respiratoria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente asmático. Como a todo asmático, se le debe educar en su enfermedad: evitar factores de riesgo, no fumar, vacunación antigripal, evitar AINE y AAS. Además deberán tratarse otros problemas asociados a su atopía: dermatitis atópica con jabones de avena y leche hidratante, rinitis con antihistamínicos, etc. Debe aprender además a manejar su enfermedad, conociendo el manejo del pico-flujo y la técnica inhalatoria, y los signos de alarma para solicitar atención médica. Sin embargo, dado que se trata de un asma persistente moderado, su tratamiento de elección será beta-agonistas de acción prolongada y corticoides inhalados, a dosis lo más baja posible, de forma pautada, junto con rescates de beta-agonista de acción corta. En caso de tratarse de asma persistente leve usaríamos corticoides inhalados junto con rescates de acción corta. No se usan beta-agonistas de acción prolongada en monoterapia en el asma (pueden aumentar la mortalidad al enmascarar síntomas).

173. ¿Por qué mecanismo aparece la “hiperinsuflación dinámica” durante el ejercicio en los enfermos con EPOC?:

1. Por alteraciones en la relación “ventilación/perfusión”.
2. Por vaciado incompleto de unidades alveolares a causa del aumento de la frecuencia respiratoria.

3. Por vaciado incompleto de unidades alveolares a causa de una disminución en la “orden respiratoria”.
4. Por los problemas mecánicos asociados a una alcalosis metabólica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La espiración es un fenómeno generalmente pasivo, en ocasiones activo, mediado por un gradiente de presión entre el alveolo y el exterior, que fuerza el flujo del aire de las vías aéreas. En la espiración puede aparecer retención de aire en alveolos por dos mecanismos patológicos, la “hiperinsuflación dinámica” y el “atrapamiento dinámico”.

ATRAPAMIENTO DINAMICO: En condiciones normales, la presión intrapleurales debe exceder en algún momento de la espiración a la presión en la vía aérea, puesto que en esta última hay un gradiente entre la presión alveolar (que será la suma de la presión intrapleurales y la presión obtenida durante la inspiración) y la presión exterior (que equiparamos a cero). Sin embargo, en condiciones normales este punto de igual presión está situado en grandes vías aéreas, no colapsables, y la vía aérea se mantiene permeable. En la espiración activa hay un aumento de presión intrapleurales, por lo que el punto de igual presión se desplaza hacia presiones más altas, y por tanto hacia vías aéreas más distales (que son más “proximales al inicio de la espiración”, que es el alveolo), que carecen de cartilago y son por tanto colapsables. Esto provoca colapso de la vía aérea, con atrapamiento de aire en las unidades con bronquiolos colapsados, y por tanto descenso de la CVP y aumento del VR. A este mecanismo lo llamamos atrapamiento dinámico. La presencia de obstrucción de la vía aérea, al favorecer el colapso, facilita este mecanismo.

HIPERINSUFLACION DINAMICA: La espiración es un proceso que “requiere su tiempo”, que funciona por un gradiente que va disminuyendo con el paso de la espiración. Por ello, cuando la espiración se alarga, como ocurre en la patología obstructiva, es típico que se produzca un alargamiento del tiempo espiratorio para permitir el vaciado completo de los alveolos. En situaciones de taquipnea, como pueden ser el simple ejercicio físico, el tiempo de cada ciclo respiratorio se acorta; no tiene ninguna repercusión en cuanto a la inspiración (tan solo, que se requiere mayor esfuerzo ventilatorio para permitir una inspiración más rápida), pero si en la espiración, puesto que al acortarse impide el vaciado completo de los alveolos. Este mecanismo dinámico provoca de forma efectiva un vaciado incompleto de los alveolos, por tanto descenso de la CVP y aumento del volumen residual, equivalente a nivel práctico al colapso de la vía aérea con atrapamiento aéreo real. Se denomina “hiperinsuflación dinámica”, y aunque reduce la CVP no se debe a un empeoramiento de la obstrucción (si se realiza espirometría, no hay descenso del VEMS, salvo que el tiempo espiratorio haya caído por debajo de 1 seg), y se acompaña de una presión espiratoria positiva en la vía aérea al final de la espiración, denominada habitualmente “autoPEEP” por los intensivistas.

174. Acude a urgencias un paciente de 80 años con enfermedad de Alzheimer que presenta desde hace 2 días alteración del nivel de consciencia de forma fluctuante con lenguaje incoherente, agitación y desorientación. La familia refiere que durante la última semana al paciente se le ha prescrito lormetazepam por dificultad para conciliar el sueño. En la exploración física el paciente se encuentra afebril con TA 140/70 y sin focalidad neurológica motora ni sensitiva, con lenguaje incoherente y agitado. La frecuencia cardíaca era rítmica a 65 lpm. ¿Cuál de las afirmaciones le parece correcta?:

1. Se trata de un paciente que ha sufrido un accidente vascular cerebral y debe realizarse una TAC cerebral urgente y administrar benzodiazepinas para controlar la agitación.
2. Se trata de una clínica sugestiva de crisis comicial y debe realizarse un electroencefalograma urgente y administrar benzodiazepinas endovenosas.
3. Se trata de un delirium y debe retirarse el lormetazepam y administrar un neuroléptico para controlar la agitación.
4. Debería realizarse una punción lumbar para descartar posible etiología infecciosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El paciente ha presentado una reacción adversa (reacción paradójica) a las benzodiazepinas. Ante un cuadro confusional lo primero es buscar desencadenantes como infecciones o fármacos. Si no los hay, habrá que intentar manejar la alteración conductual con medidas higiénico-dietéticas, y si con ello no es posible, recurriremos a los fármacos para controlar la agitación.

175. A un paciente de 60 años, sin antecedentes familiares de cáncer colorrectal o de poliposis, se le halla en una colonoscopia, un único pólipo sesil de 0,5 cm en el sigma que se reseca por completo en un solo fragmento en el mismo acto endoscópico. La colonoscopia ha sido completa hasta el ciego y la preparación del colon era excelente. La anatomía patológica del pólipo revela un adenoma tubular con displasia de bajo grado. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones de seguimiento sería la más adecuada?:

1. Programar un nuevo control colonoscópico dentro de 1 año.
2. Programar un nuevo control colonoscópico dentro de 5 años.
3. No hace falta programar una nueva colonoscopia porque el pólipo ya ha sido resecado y no tenía displasia de alto grado.
4. Programar un nuevo control colonoscópico dentro de 3 años.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el cáncer colorrectal (CCR) se ha establecido de forma precisa la secuencia pólipo-cáncer que tarda aproximadamente 10 años en producirse. Por esta razón, todo pólipo debe ser siempre extirpado y posteriormente se realizan controles periódicos. Dado que en nuestro paciente la colonoscopia ha sido perfecta y el enunciado nos asegura que no existen más alteraciones, podemos esperar hasta 5 años para realizar la siguiente colonoscopia dado el tamaño y el grado de displasia (opción 2 correcta, opciones 1 y 4 incorrectas). Al ser un paciente joven sí que requiere seguimiento aunque el pólipo haya sido resecado (opción 3 incorrecta). Nos podríamos plantear dejar el seguimiento endoscópico en pacientes más mayores (> 80 años) o con esperanza de vida estimada < de 5-10 años.

176. Un hombre de 52 años acude a consulta refiriendo un cuadro de cansancio generalizado, leve pérdida de peso, dolores articulares en muñecas y rodillas y disminución de la libido. No refiere hábitos tóxicos ni ingesta de medicamentos. A la exploración llama la atención un bronceado de la piel (no relacionado con toma de sol) y discreta hepatomegalia. En la analítica realizada destaca: glucosa basal 180 mg/dl; GOT: 78 U/l; GPT: 89 U/l; ferritina 650 ng/ml; transferrina: 260 mg/dl; saturación de transferrina: 66,6%; hierro sérico: 220 ug/dl. ¿Qué otra prueba complementaria entre las siguientes solicitaría inicialmente para llegar al diagnóstico?:

1. Prueba de sobrecarga oral a la glucosa.
2. Estudio genético de la mutación C282Y.
3. Carga viral del virus de la hepatitis C.
4. Resonancia magnética de las articulaciones de la muñeca.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta pregunta ha sido preguntada varios años de forma muy similar. Se trata de un paciente que tiene molestias articulares, disminución de la libido (hipogonadismo), piel bronceada, hepatomegalia, diabetes, alteraciones de las enzimas hepáticas y marcadores férricos elevados. Sabiendo esto es fácil deducir que la siguiente prueba a realizar sería una determinación de la mutación C282Y, que nos confirmaría el diagnóstico (respuesta 2 correcta) si la mutación fuera homocigota. MIR HEMOCROMATOSIS = piel bronceada, diabetes y hepatopatía.

177. En una paciente de 40 años se encuentra una cifra de calcio de 11,8 mg/dl (normal menos de 10,5 mg/dl) en un análisis realizado por otro motivo. La determinación de PTH solicitada en el estudio de la hipercalcemia arrojó una cifra de 115 pg/ml (límite superior de la normalidad, 45 pg/ml). La densidad ósea, el aclaramiento de creatinina y la calciuria son normales. ¿Cuál debe ser la conducta a seguir?:

1. Administración de bisfosfonatos.
2. Paratiroidectomía.
3. Administración de quelantes del calcio.
4. Observación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia en el paciente asintomático. Se debe generalmente a adenomas paratiroides, siendo la hiperplasia la segunda causa en frecuencia, y la más frecuente en el contexto de trastornos familiares, como los síndromes MEN. Se considera indicado el tratamiento quirúrgico del hiperparatiroidismo primario en pacientes menores de 50 años; y en los mayores de 50 años con calcemia mayor de 11,5, o con una descompensación hipercalcémica previa potencialmente letal, o con descenso de la función renal en más del 30%, o con presencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis, o con osteoporosis con t score menor de 2,5 DS, o con dificultad para el manejo o seguimiento médico del paciente, o cuando el paciente así lo prefiera. Recuerda que la presencia de calciuria mayor de 400 mg/24 horas asintomática se ha eliminado como criterio quirúrgico recientemente. Previo a la cirugía, se puede localizar la lesión con la gammagrafía con tecnecio-sestamibi, pero no es necesaria, pues el mejor método de localización son las manos de un cirujano experto en el propio acto quirúrgico. Nuestro paciente, para empezar tiene menos de 50 años, luego ya tiene una indicación absoluta, pero aunque no fuera así tiene además un calcio sérico por encima de un punto sobre el límite de normalidad, lo que constituiría indicación de paratiroidectomía incluso por encima de los 50 años.

178. ¿Qué microorganismo es el principal responsable de las bacteriemias asociadas a catéter intravascular?:

1. P. aeruginosa.
2. C. albicans.
3. S. aureus.
4. S. epidermidis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La causa más frecuente de bacteriemias de catéter son los estafilococos, especialmente, los Staphylococcus coagulans negativos, sobre todo S. epidermidis; seguido de S. aureus y Enterococcus sp.

179. Un paciente de 43 años acude a urgencias por disnea, tos y fiebre de una semana de evolución y en la radiografía de tórax presenta una cavidad de paredes lisas en lóbulo superior derecho rodeada por áreas de consolidación alveolar. ¿Cuál es la conducta inicial más correcta?:

1. El paciente puede ser dado de alta con tratamiento antibiótico y realizar una radiografía de control en un mes.

2. Se debe realizar un estudio de tomografía computarizada (TC) torácica ante la sospecha de neoplasia pulmonar.
3. El paciente puede ser bacilífero y se debe realizar una baciloscopia del esputo.
4. Se debe obtener un diagnóstico citológico mediante broncoscopia o punción percutánea.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante la sospecha de una TUBERCULOSIS PULMONAR CAVITADA (habitualmente por reactivación), dado que potencialmente se tratará de un paciente bacilífero, se debe indicar de entrada aislamiento respiratorio y abordarse el diagnóstico con el estudio de muestras respiratorias (esputo, BAL.) para descartar o confirmar la tuberculosis.

180. Una mujer de 57 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 y artrosis de ambas rodillas acude al servicio de urgencia por fiebre de hasta 39°C junto con dolor y tumefacción de 24 horas de evolución en la rodilla derecha. ¿Cuál de las siguientes actitudes o exploraciones complementarias está más indicada en este momento?:

1. Artrocentesis, examen del líquido sinovial con microscopio de luz polarizada y test de Gram urgente.
2. Realización de Tomografía Axial Computerizada.
3. Estudio inmunológico completo, incluyendo factor reumatoide.
4. Lavado articular y tratamiento con antibióticos intravenosos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El concepto que se busca en este pregunta ha sido preguntado con frecuencia en el MIR, así que es muy rentable que no lo olvides: el análisis de líquido sinovial es la prueba diagnóstica más rentable en el estudio de las enfermedades reumatológicas y la primera prueba a realizar ante una monoartritis aguda, antes de optar por cualquier terapia. No obstante, sí que debes pautar tratamiento antibiótico tras la artrocentesis si la sospecha principal es una artritis séptica, sin ser necesario esperar a los resultados del cultivo. No debe realizarse punción si existe celulitis periarticular (por el riesgo de contaminar e infectar la articulación). Su análisis proporciona datos fundamentales para el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades y es la clave diagnóstica de las artritis sépticas y microcristalinas. (Opción 1 Correcta).

181. Acude a la urgencia una mujer de 53 años tratada dos días antes con una reducción cerrada y yeso antebraquial cerrado por una fractura de Colles en su muñeca izquierda. Aqueja dolor muy intenso y progresivo en mano y muñeca, así como incapacidad de mover los dedos y falta de

sensibilidad en ellos. El yeso presenta un aspecto adecuado. Los dedos presentan buen relleno capilar y una coloración aceptable, pero están muy hinchados, con nula movilidad activa, y su movilización pasiva produce intenso dolor. La actitud más correcta será:

1. Abrir el yeso, antiinflamatorios, estimular la movilidad activa, y si no mejora rápidamente fasciotomía urgente.
2. Mantener el yeso, elevar la mano, ingresar a la paciente en observación instándole a mover activamente los dedos.
3. Abrir el yeso, antiinflamatorios, estimular la movilidad activa, y si no mejora rápidamente osteosíntesis de la fractura.
4. Abrir el yeso, administrar antiinflamatorios y remitir a la paciente a consultas externas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla (ha sido motivo de pregunta MIR en numerosas ocasiones) acerca del manejo inicial de una sospecha de síndrome compartimental. Recordad que se trata de una alteración de la microvasculatura por lo que tanto el pulso como el relleno capilar están presentes. Lo más importante en el manejo de esta patología es sospecharla y que no se nos pase por alto. La primera medida es retirar el yeso (opción 2 falsa). Lo siguiente es mantener la extremidad por encima del corazón para favorecer el retorno venoso, administrar analgesia y pedirle al paciente que movilice los dedos. Para confirmar su existencia es preciso medir las presiones intracompartimentales (positivo si es mayor de 30mmHg). Si los síntomas no ceden en unos 30 min estaría indicada la realización de una fasciotomía urgente. Respuesta 1 correcta.

182. Un chico de 20 años, jugando al fútbol hace una semana, sufrió una torsión en su rodilla al clavar los tacos de la bota en el césped y girar bruscamente el tronco. A la exploración no se aprecia derrame articular, la palpación del tercio posterior de la interlínea articular medial es dolorosa, duele al forzar la flexión, la maniobra de Lachman es negativa y los bostezos a varo y valgo son indoloros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Lesión meniscal del menisco medial.
2. Lesión capsular posteromedial.
3. Lesión del ligamento cruzado anterior.
4. Lesión del complejo ligamentario posterolateral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla acerca de la patología traumática de la rodilla. Para acertar la pregunta es esencial entender el mecanismo de producción de la lesión, el paciente ha sufrido una torsión sobre el eje principal de la rodilla

mientras mantenía su pie se mantenía fijo en el suelo. Lo más probable es que se hayan podido lesionar el menisco medial y/o algún ligamento colateral. La exploración física practicada al paciente nos dice que la rodilla es estable tanto en varo como en valgo (descartamos colaterales). La maniobra de Lachman (desplazamiento anterior de la meseta tibial con la rodilla flexionada a 30°, una maniobra de alta sensibilidad para detectar lesión de lig cruzado anterior) es negativa, por lo que descartamos la tercera opción. El dolor a la palpación de la interlínea articular medial es muy sugestiva de una lesión de menisco medial. Recordad que el tratamiento es conservador inicialmente, con carga parcial según el dolor que tenga el paciente y un vendaje compresivo o una rodillera.

183. ¿Qué diagnóstico debe sospecharse en un hombre de 53 años, fumador, que inicia de manera insidiosa un síndrome miccional irritativo con tacto rectal normal, flujo urinario no obstructivo, ecografía renovesicoprostática normal, sedimento urinario con microhematuria y urocultivo negativo, cistoscopia normal y citología urinaria con atipias?:

1. Esquistosomiasis.
2. Litiasis uretral.
3. Carcinoma in situ vesical.
4. Hipernefoma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El síndrome miccional es característico de: ITU, Carcinoma in situ vesica, TBC y Cistitis intersticial. En este caso el antecedente de varón fumador con atipias en la citología es típico de carcinoma in situ, así como el sedimento urinario negativo y la ecografía sin hallazgos (por ser una lesión plana).

184. En un paciente con un traumatismo pélvico y sospecha de rotura uretral por incapacidad de orinar espontáneamente, globo vesical y uretrorragia. ¿Cuál de estas maniobras debe evitarse?:

1. Sondaje vesical.
2. Colocación de cistostomía suprapúbica.
3. Palpación abdominal.
4. Tacto rectal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las lesiones traumáticas de uretra se sospechan por la uretrorragia asociada a la incapacidad para la micción que condiciona globo vesical palpable. Si realizamos un tacto rectal podemos encontrar la próstata elevada, la siguiente maniobra es la realización de una uretrografía urgente para valorar el grado de lesión uretral y en la mayoría de los casos el tratamiento es la punción suprapúbica, aunque en casos seleccionados el sondaje es una opción terapéutica, pero de no ser así está contraindicado de inicio.

185. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) es FALSA?:

1. En pacientes con TVP confirmada objetivamente, recomendamos tratamiento agudo con heparina de bajo peso subcutánea o heparina no fraccionada.
2. Para pacientes con elevada sospecha clínica de trombosis, se recomienda tratamiento anticoagulante mientras se espera el resultado de las pruebas diagnósticas.
3. En los pacientes tratados con heparina de bajo peso es necesario hacer mediciones sistemáticas de la actividad antiXa con el fin de ajustar la dosis.
4. Se recomienda iniciar la administración de anticoagulantes orales junto con heparina en el primer día del tratamiento, e interrumpir la administración de heparina cuando el INR sea estable y superior a 2.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La TVP y el TEP deben tratarse con heparina tanto si el diagnóstico está confirmado como si existe elevada sospecha clínica en espera a los resultados de las pruebas diagnósticas. (respuesta 1 y 2 correctas). Cuando se inicia un tratamiento con anticoagulantes orales se administran conjuntamente durante unos días ACO y heparina, puesto que la heparina actúa en horas y los ACO tardan unos días en actuar. Cuando el ACO alcanza el nivel de anticoagulación esperado (INR óptimo que suele ser en torno a 2) se retira la heparina. (respuesta 4 correcta) Para el control de la anticoagulación se usa: -Heparinas no fraccionadas. :Tiempo parcial de tromboplastina (APTT) -ACO: Tiempo de protrombina (TP) e INR (índice normalizado internacional del TP) -Heparinas de bajo peso molecular: No necesitan control del tiempo de coagulación (respuesta 3 incorrecta) excepto en casos concretos en los que se usaría la actividad anti Xa (insuficiencia renal, obesidad, cáncer.).

186. A un paciente obeso y roncador intenso, sin somnolencia diurna, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, se le practica una polisomnografía después de haber detectado su pareja pausas respiratorias durante el sueño. El registro muestra un índice de apnea-hipopnea (IAH) de 4/hora a expensas de apneas obstructivas, una SaO₂ media durante el sueño de 94% y una SaO₂ mínima de 86%. El diagnóstico es:

1. Se trata de un roncador simple que no precisa tratamiento.
2. Se trata de un síndrome de apnea del sueño subsidiario de tratamiento con CPAP nasal.
3. Se trata de un síndrome del sueño subsidiario de dieta hipocalórica y dormir en decúbito lateral.

4. Se trata de un síndrome de apneas centrales secundarias a la insuficiencia cardíaca.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las apneas del sueño son pausas en el flujo aéreo, cuasifisiológicas en cierta medida. Si son muy profundas, condicionan una hipoxemia con descenso en la profundidad del sueño (arousal), que reestablece el flujo aéreo. No todo paciente con apneas tiene síndrome de apnea-hipopnea del sueño, en el que la desestructuración del sueño condiciona una hipersomnia diurna (con aumento de la siniestralidad) y la hipoxemia provoca alteraciones cardiovasculares. Se denomina apnea obstructiva a la que se debe a cese del flujo por obstrucción de la vía aérea, y cursa con estímulo ventilatorio y actividad muscular respiratoria normal. Se denomina apnea central a la que cursa con descenso del estímulo ventilatorio y por tanto sin actividad muscular. El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) es una patología prevalente (se cree que cercana al 5%). Para su diagnóstico se usan la poligrafía (se considera un screening, mide el índice de eventos respiratorios) o la polisomnografía (se considera diagnóstico de elección, mide el índice de apnea-hipopnea IAH). Se asume equiparable el índice IER y el IAH. Es fisiológico un índice IAH <10. Se considera diagnóstico de SAHS o bien tener un IAH >15 aun con clínica leve, o bien un IAH >5 con clínica grave. Este paciente tiene un IAH de 4, no patológico, luego no cumpliría el criterio diagnóstico ni con la peor afectación clínica imaginable. Además, la clínica es banal y no tiene repercusión respiratoria: su satO₂ mínima es tan solo de 88% y la media es de 94%. Por tanto, debemos considerarlo tan solo como un roncador simple. Se le debería recomendar higiene del sueño, pérdida de peso, y evitar depresores del SNC en las horas previas al descanso nocturno.

187. Niña de 2 años que estando previamente bien sufre episodio brusco de desconexión del medio e hipertensión, con estridor y sialorrea, durante aproximadamente 2 minutos, quedando posteriormente somnolienta durante aproximadamente 5 minutos. A su llegada al Centro de Salud se objetiva temperatura axilar de 38,9°C. En relación con esta niña, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. Presenta un proceso benigno pero que casi siempre recurre.
2. Debe remitirse a un Centro Hospitalario para realización de una prueba de neuroimagen.
3. Si el foco causal de la fiebre es claro y banal y la recuperación clínica completa, puede manejarse con antitérmicos y observación domiciliar sin realizar ninguna prueba complementaria.
4. Será necesaria la realización de un EEG más adelante.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las crisis febriles típicas son procesos relativamente benignos, que no precisan evaluaciones complementarias si el foco de la fiebre es conocido (si se sospecha meningitis habrá que realizar punción lumbar) y que se trata con antitérmicos profilácticos cuando exista fiebre y benzodiacepinas para yugular la crisis si es prolongada. No se usan antiepilépticos y no es necesario EEG ni neuroimagen si la crisis febril es típica.

188. Un paciente politoxicómano de 28 años ingresó hace 3 días por fractura subtrocantérea de fémur izquierdo, fractura de rótula derecha y fractura diafisaria conminuta de tibia izquierda que se inmovilizaron provisionalmente en espera de cirugía de osteosíntesis. Bruscamente inicia un cuadro de estupor y obnubilación intensos acompañado de disnea y de aparición de petequias difusas. Debemos sospechar:

1. Neumonía nosocomial por encamamiento.
2. Shock hipovolémico.
3. Síndrome de embolia grasa.
4. Shock neurogénico por dolor.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla si tenemos en cuenta el principal antecedente de este paciente, fracturas de huesos largos. Después de unos días sin síntomas (intervalo libre) comienza con disnea y disminución del nivel de conciencia además de la aparición de petequias. El síndrome de embolia grasa (respuesta 3 correcta) se caracteriza por: - $pO_2 < 60$ mmHg - Alteraciones del nivel de conciencia. - Petequias difusas en la mitad superior del cuerpo, incluyendo conjuntivas. - Anemia, trombopenia, grasa en orina y/o esputo. - RX con "imagen en tormenta de nieve" Tratamiento estabilización de las fracturas, oxigenoterapia y corticoides a altas dosis.

189. La esclerosis múltiple es un proceso inflamatorio y desmielinizante del SNC. En el diagnóstico de esta enfermedad es muy útil la presencia de:

1. Elevaciones del ácido úrico en plasma.
2. Bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo.
3. Más de 100 linfocitos por microlitro en el líquido cefalorraquídeo.
4. Cifras elevadas de ácidos grasos de cadena muy larga en plasma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta fácil, las bandas oligoclonales en LCR son típicas de esclerosis múltiple. Recordad que hay pocas células en LCR (menos de 50 y son linfocitos).

190. ¿Cuál cree usted que es el trastorno endocrino que provoca mayor prevalencia de disfunción eréctil?:

1. Diabetes Mellitus.
2. Síndrome de deficiencia androgénica asociada a la edad.
3. Hipogonadismo hipogonadotrofo.
4. Síndrome de Cushing.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La principal causa de disfunción eréctil es la patología vascular; siendo la principal causa la diabetes, seguida de la HTA, hipercolesterolemia y tabaquismo.

191. Hombre de 27 años, con antecedentes de enfermedad de Crohn y resección de ileon terminal hace 3 años, presenta intensa astenia y palidez cutáneomucosa. En la bioquímica destaca LDH 2730 UI/L y bilirrubina 1,7 mg/dL. En el hemograma muestra $2,9 \times 10^9$ leucocitos/L con recuento diferencial normal, hemoglobina 7,5 g/dL, hematocrito 22%, VCM 135 fl y 105×10^9 plaquetas/L. El recuento de reticulocitos es 1% y en el frotis de sangre periférica se observan abundantes neutrófilos hipersegmentados. ¿Cuál sería su juicio diagnóstico más probable y su actitud terapéutica inicial?:

1. Anemia de probable origen inflamatorio. Transfundir concentrado de hemáties.
2. Anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Iniciar vitamina B12 parenteral y ácido fólico oral.
3. Anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. Iniciar ácido fólico oral.
4. Síndrome mielodisplásico. Transfundir concentrado de hemáties.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta es una pregunta típica de anemias en la que nos dan muchos datos numéricos de la analítica, pero en la que sólo con saberse las características básicas de cada anemia puede sacarse sin problema. Los datos clave de esta pregunta son: paciente con resección de ileon terminal (lugar donde se absorbe la vit B12, el fólico se absorbe en yeyuno), anemia con VCM muy aumentado (típico de las anemias megaloblásticas) y neutrófilos hipersegmentados (característico también de las anemias megaloblásticas). Con estos tres datos ya deberíamos acertar la respuesta. Además nos dan otros valores que acompañan a este tipo de anemia: disminución de otras líneas celulares (leucopenia) y signos de aborto intramedular (bilirrubina y LDH muy aumentadas). Al comenzar el tratamiento con vit B12 es recomendable asociar ácido fólico para evitar la aparición de una crisis megalobástica secundaria a hiperconsumo de ácido fólico.

192. Mujer de 55 años, postmenopáusica y fumadora activa, que consulta por dolor de hombro izquierdo irradiado a brazo de varias semanas

de duración. En la exploración física destaca ptosis y miosis del ojo izquierdo. ¿Cuál sería su actitud?:

1. Solicitar radiografía simple de tórax.
2. Solicitar estudio oftalmológico.
3. Realizar anticuerpos antireceptor de acetilcolina.
4. Solicitar TAC cerebral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La asociación de ptosis y miosis sugiere síndrome de Horner, por afectación del simpático cervical. Su causa más frecuente NO es el tumor de Pancoast, sino la afectación del paquete vascular carotideo. Sin embargo, sus causas más temibles son la disección carotídea y el tumor de Pancoast. El dolor en el territorio del brazo izquierdo, unido a la afectación del simpático cervical, ya si que es altamente sugestivo de afectación del plexo braquial, y por tanto de un tumor de Pancoast. Es obligatorio realizar una placa de tórax a esta paciente. Probablemente se deba realizar a cualquier paciente con síndrome de Horner, dado que el riesgo de yatrogenia es muy bajo y el beneficio es muy alto. En caso de presentar dolor cervical o cefalea, sería obligado un estudio vascular cervical (la RM tiene mejor sensibilidad que la ecografía-doppler) para descartar disección carotídea.

193. Mujer de 88 años, natural del Pirineo, donde siempre ha vivido, que consulta por un gran bocio multinodular junto con arritmia y hallazgo de un hipertiroidismo por T3 (T4 libre normal, T3 libre 8 pmol/L, normal de 4 a 6.8, y TSH de 0.15 mUL, normal de 0.3 a 5). Reconoce que su bocio existe desde hace más de 30 años sin claro crecimiento reciente. No refiere disfagia ni estridor. Lleva tratamiento para hipertensión arterial, controlada con hidroclorotiacida y potasio, así como broncodilatadores y corticoides inhalados por una EPOC. ¿Cuál será, probablemente, la actitud terapéutica más indicada?:

1. No tratar, ya que la T4 libre es normal.
2. Hemitiroidectomía más istectomía.
3. Iniciar L-tiroxina sódica.
4. Tratamiento con yodo radioactivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La paciente presenta un bocio multinodular asociado a hipertiroidismo, es decir: un bocio multinodular tóxico (BMT). El tratamiento sintomático inicial del BMT puede hacerse con anti-tiroideos, pero el manejo definitivo (curativo) precisa siempre de radioyodo o cirugía (a diferencia del Graves, donde hasta un 30% de los casos acaban remitiendo tras 1-2 años de anti-tiroideos). En general se prefiere el radioyodo a la cirugía por su gran efectividad, menores complicaciones y menores riesgos asociados. La cirugía se reserva para pacientes de bajo riesgo con

glándulas muy grandes que produzcan defectos estéticos, síntomas compresivos, etc, o cuando asocien malignidad. En nuestro caso, a pesar de tratarse de un bocio grande, no refiere síntomas compresivos y, lo que es más importante, tiene 88 años y EPOC, por lo que el riesgo quirúrgico es elevado. Por otro lado, fíjate que la cirugía indicada en un BMT sería una tiroidectomía total (la hemitiroidectomía no reseca todos los nódulos hiperfuncionantes), por lo que en este caso, la única opción plausible es el radioyodo.

194. Hombre de 29 años: accidente de tráfico. Ingresa en servicio de Traumatología con cuadro de pérdida progresiva de fuerza en miembros inferiores, los reflejos osteotendinosos están abolidos. El estudio con radiografías simples muestran una fractura por compresión de L1 con desplazamiento del muro posterior y acúñamiento anterior de un 50%. ¿Qué prueba diagnóstica indicaría para valorar la ocupación del canal raquídeo?:

1. Una termografía.
2. Una resonancia magnética.
3. Una TAC vertebral centrada en región dorso lumbar.
4. Una gammagrafía ósea.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla acerca de la prueba de imagen de elección ante una fractura de columna lumbar a nivel L1. La primera prueba de imagen a realizar ante la sospecha de una fractura vertebral es una RX simple AP y lateral. Los hallazgos anormales pueden ser ensanchamiento interpedicular, pérdida de la altura vertebral normal. La TC proporciona mayor detalle de las estructuras óseas y es la prueba de elección inicial en la urgencia. Dado que se trata de una fractura, ¿qué ocuparía el canal medular? El hueso. El TC mostraría la ocupación del canal medular por un fragmento de hueso (respuesta 3 correcta). Sin embargo, si quisiéramos definir la afectación nerviosa, un TC no sería suficiente. Para ello, necesitaríamos una RM, con la que podríamos observar muy bien el posible daño medular, los discos intervertebrales o del complejo ligamentario posterior (estructuras no óseas).

195. Una maestra jubilada de 74 años con diabetes mellitus presenta frecuentes episodios de retención urinaria. No presenta incontinencia al toser o cambiar de postura. En la exploración física se detecta una neuropatía sensitiva en extremidades inferiores. El residuo postmiccional es de 400 mL. La maniobra de Valsalva realizada en bipedestación no provoca pérdida de orina. El estudio urodinámico muestra un detrusor acontráctil sin obstrucción al vaciamiento vesical. Los estudios de laboratorio son normales y el tratamiento farmacológico ha sido inefectivo. ¿Cuál es la opción terapéutica más apropiada?:

1. Sondajes intermitentes.
2. Sonda urinaria permanente.
3. Dilatación uretral.
4. Uretrolisis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta paciente presenta una vejiga neurogena como consecuencia de una neuropatía por su diabetes, esto determina un detrusor arreflexico lo que limita el vaciado vesical con residuo postmiccional elevado; por lo tanto en estos enfermos la mejor medida es la evacuación de esa orina retenida. Por lo tanto es necesario un sondaje, que siempre que sea posible es mejor de forma intermitente por el menor riesgo de complicaciones asociadas como infecciones. El sondaje intermitente consiste en cateterizaciones periódicas diarias para el vaciado vesical.

196. Ante un paciente con insuficiencia renal crónica y sospecha de uropatía obstructiva en una exploración ecográfica. ¿Qué exploración es la idónea para evaluar el nivel de obstrucción y la causa?:

1. Pielografía retrógrada con contraste yodado.
2. Cistoscopia.
3. Tomografía axial computarizada con contraste yodado.
4. Urografía mediante resonancia magnética con gadolinio.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Para establecer el nivel de obstrucción y la causa es necesario una prueba con contraste con fase urográfica (respuesta 2 falsa). Mensajes importantes - El contraste yodado no se puede administrar de forma intravenosa en pacientes alérgicos o con enfermedad renal crónica (produce fracaso renal agudo). (respuesta 3 falsa) - El gadolinio no se puede administrar en pacientes con enfermedad renal crónica (produce fibrosis sistémica nefrogénica). (respuesta 4 falsa).

197. ¿Cuál de los siguientes antiepilépticos administrado en mujeres embarazadas puede producir, en el recién nacido, una deficiencia de factores de la coagulación dependientes de vitamina K?:

1. Carbamazepina.
2. Fenitoína.
3. Etosuximida.
4. Valproato sódico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La fenitoína puede interferir con los factores dependientes de vitamina K, así como con la vitamina D y el folato.

198. Las vacunas frente a la gripe que se utilizan actualmente se caracterizan por:

1. Impedir mediante la inmunidad que generan que aparezca una pandemia.
2. Precisar solo la administración de una dosis a lo largo de la vida.
3. Ser más eficaces en ancianos, ya que responden con títulos de anticuerpos más elevados.
4. Variar su composición antigénica cada año, como consecuencia de la deriva antigénica de los virus gripales A y B.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace públicas sus recomendaciones sobre la composición de la vacuna de la gripe para el Hemisferio Norte cada año en base a los datos recabados por los laboratorios del programa Mundial contra la Gripe de esta agencia. Los virus de la gripe varían su composición antigénica cada año, como consecuencia de la deriva antigénica de los virus influenza A y B. Por lo tanto, cada año el Programa Mundial contra la Gripe convoca reuniones para analizar los datos mundiales sobre las cepas circulantes de virus de la gripe y formular recomendaciones acerca de las vacunas que hay que utilizar en la temporada de gripe siguiente. Obviamente los ancianos responden con títulos de anticuerpos más bajos que los pacientes jóvenes.

199. Las siguientes estructuras desembocan en la aurícula derecha, EXCEPTO:

1. Vena cava superior.
2. Vena cava inferior.
3. Seno coronario.
4. Vena pulmonar derecha.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de anatomía que es muy sencilla. Es sencillo pensar que todas las estructuras venosas poco oxigenadas desembocan en la AD para ir a la circulación pulmonar. pero no olvides que el concepto de vena hace referencia a la estructura vascular que desemboca en el corazón. Así, las venas pulmonares llevan sangre oxigenada desde el pulmón y desembocan en la AI.

200. Un paciente con carcinoma de pulmón de células escamosas inoperable desarrolla una hipercalcemia de 14 mg/dl. Se inicia una perfusión con suero salino y, una vez bien hidratado, furosemida, con lo que horas más tarde la calcemia es de 11,5 mg/dl. ¿Cuál es el paso terapéutico siguiente más apropiado?:

1. Corticoides.
2. Nitrato de galio.
3. Alendronato.
4. Zoledronato intravenoso.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

^regunta clave para el MIR por ser un concepto muy repetido. Una hipercalcemia con alteración del nivel de conciencia es una urgencia médica que requiere tratamiento enérgico. Hay varios fármacos capaces de controlar la calcemia, y de todos ellos el que consigue un control más rápido es el suero salino. La sobrecarga salina provoca a nivel renal un aumento del sodio filtrado, que debe reabsorberse en el túbulo, y para ello se intercambia con calcio, aumentando su excreción. La adición de furosemida, al bloquear la absorción de sodio por el canal de sodio-potasio-cloruro del asa ascendente, produce un mayor flujo intraluminal de sodio al túbulo distal, donde se intercambia con calcio; el problema es que la hipercalcemia puede provocar fallo renal agudo, y por tanto no se debe administrar furosemida hasta que el paciente “rompa a orinar”. Clásicamente, se admitía que el segundo fármaco en rapidez de acción es la calcitonina parenteral (unas 24 horas), que tiene la desventaja de producir taquifilaxia, y los bifosfonatos eran un fármaco de inicio de acción lento, en un par de días, pero acción más mantenida. Un bifosfonato, el ácido zoledrónico, tiene un efecto más precoz que el resto de bifosfonatos e incluso que la calcitonina, de inicio en unas 18 horas, y está especialmente indicado en la hipercalcemia tumoral. Los glucocorticoides son tan sólo útiles en caso de hipercalcemia tumoral o hipercalcemia por hipervitaminosis D; su efecto es lento, en 3-5 días, y mantenido durante semanas.

201. Una mujer de 46 años acude a urgencias por paresia de miembros derechos de instauración brusca. Sufrió un cuadro de astenia y anorexia desde hacia 2 meses. La paciente estaba icterica. Su tasa hemática de Bilirrubina era 6 mg/dL (Bi directa: 5 mg/dL). La fosfatasa alcalina 406 u/L (n<127); El Ag. carcinoembrionario (CEA), 18,5 ng/mL (n<5); CA 19,9: 980 u/mL (n<37); Alfafetoproteína: 2 ng/mL (n<15). Señale la respuesta correcta:

1. La presencia de marcadores tumorales elevados, aún usados como método de screening, tiene gran sensibilidad y especificidad diagnóstica.
2. La endocarditis marántica es una situación potencialmente embolígena, asociada a estados de hipercoagulabilidad en procesos neoplásicos.
3. La elevación de la enzima fosfatasa alcalina, en este caso, refleja la presencia de metástasis ósea.
4. El cuadro, en conjunto es diagnóstico de Hepatocarcinoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil y que no debe estresarte. Lo que sí queda claro es que la paciente tiene un proceso neoplásico, por la clínica consuntiva y la elevación del CEA. La endocarditis marántica o también llamada trombótica bacteriana, es una endocarditis que afecta generalmente a pacientes de edad avanzada o a pacientes en el curso de

estadios terminales de enfermedades consuntivas, como tumores malignos epiteliales o tuberculosis. Se caracteriza por el depósito de fibrina, plaquetas y eritrocitos, que forman verrugas o vegetaciones en los velos valvulares del corazón, sin signos inflamatorios ni presencia de gérmenes. Por lo general, asienta sobre válvulas previamente dañadas por procesos anteriores y sobre todo a la mitral y a la aórtica. Al parecer, estas formaciones trombóticas son un equivalente de los microtrombos de la coagulopatía de consumo. Ellas se desprenden con facilidad y suelen originar infartos, especialmente en el cerebro. La predilección por las válvulas izquierdas parece deberse a la mayor sobrecarga mecánica a la que están sometidas, con formación de pequeñas erosiones endoteliales, que favorecen la trombosis.

202. En la definición de hipertensión arterial resistente, se consideran las siguientes causas, EXCEPTO:

1. Cifras de Tensión Arterial Sistólica por encima de 180 mmHg.
2. Apnea Obstructiva del sueño.
3. Lesión orgánica irreversible o difícilmente reversible.
4. Cumplimiento deficiente del plan terapéutico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta de Cardiología fue la más difícil del examen del 2008, pues piden algo muy concreto de la HTA y que fue sacado textualmente de un cuadro de las guías europeas de HTA (recientemente actualizadas en 2018, en las que se mantiene la misma definición): Situación en que la presión arterial no disminuye por debajo de 140/90 mmHg, a pesar del cumplimiento de las medidas higiénico-dietéticas y un tratamiento correcto con dosis adecuada con triple terapia (incluyendo diuréticos). En el paciente anciano con HTA sistólica aislada se define como la situación en la que no se consigue el descenso de PAS por debajo de 160 mmHg. Ante esta situación se deben analizar las causas de inadecuada respuesta al tratamiento, y ajustar y corregir las que sean modificables, derivando al hospital en el caso de no poder corregirlas. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, la amilorida y la doxazosina son fármacos que pueden ser útiles en estos casos. Como último recurso, en pacientes seleccionados y en centros especializados se puede proceder a la denervación renal o a la estimulación de barorreceptores. Las causas de inadecuada respuesta al tratamiento son: - Seudoresistencia (HTA de bata blanca, seudohipertensión ancianos, brazalete inapropiado). - Mal cumplimiento del tratamiento. - Exceso de ingesta de sal. - Tratamiento diurético inadecuado. - Daño renal progresivo. - Dosis bajas de fármacos antihipertensivos. - Uso de fármacos: simpaticomiméticos, descongestionantes nasales, cafeína, cocaína, anorexígenos, anticonceptivos orales, esteroides, ciclosporina, eritropoyetina, antidepresivos, AINE. - Problemas asociados: tabaquismo, obesidad, apnea del sueño, hiperinsulinismo, exceso de ingesta de alcohol, arteritis, ansiedad-ataque de pánico. - Hipertensión arterial secundaria.

203. Usted ve en consulta por primera vez a un paciente de 45 años diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Desde los 25 años había fumado 5 cigarrillos al día (5 paquetes/año). El síntoma fundamental es una disnea de mínimos esfuerzos. La auscultación pulmonar es normal, aunque en la exploración física destaca la presencia de aumento de presión venosa y edemas en ambos miembros inferiores. ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera errónea en este paciente?:

1. Realizar una espirometría con prueba broncodilatadora para demostrar la existencia de obstrucción crónica al flujo aéreo.
2. Iniciar inmediatamente tratamiento con altas dosis de broncodilatadores, corticoides inhalados y teofilina para mejorar su situación clínica.
3. Cuestionar el diagnóstico de EPOC y valorar otras patologías que cursen con insuficiencia cardíaca derecha.
4. Ampliar el estudio del paciente con radiografía de tórax y ecocardiograma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente con un diagnóstico de EPOC que no tiene realizadas pruebas funcionales respiratorias. El diagnóstico de EPOC se basa en la demostración de obstrucción crónica no reversible al flujo aéreo, luego exige la realización de espirometría. No tiene por tanto un diagnóstico de EPOC, sino que se trata de una sospecha de EPOC (está "acusado" de EPOC). Y se trata de una sospecha de EPOC poco fundada: escaso consumo de tabaco (tan solo 5 paquetes-año, el riesgo de EPOC aparece por encima de 20 paquetes-año, y de confirmarse con consumos inferiores debe descartarse déficit de alfa-1-antitripsina), rápida evolución con aparición de disnea de mínimos esfuerzos y cor pulmonale crónico. Una clínica poco compatible debe hacernos dudar de este diagnóstico de sospecha de EPOC. No estaría indicado comenzar con un tratamiento intensivo de EPOC con betagónistas a dosis altas y teofilina, puesto que a) no hay datos de broncoespasmo b) presenta datos de insuficiencia cardíaca, que puede empeorar con el tratamiento beta-adrenergico. Realmente, de este paciente lo que sabemos es que se presenta con clínica de insuficiencia cardíaca, y datos semiológicos de afectación predominantemente derecha, pero no conocemos su causa ni si existe un componente de insuficiencia cardíaca izquierda. Para confirmar o descartar el diagnóstico de EPOC necesitamos una espirometría. Para saber que le pasa al paciente necesitamos un estudio de insuficiencia cardíaca, puesto que es lo que realmente hemos objetivado en él: electrocardiograma + placa de tórax + ecocardiograma transtorácico. Dado que tiene una disnea progresiva con sospecha de origen pulmonar, estaría indicado realizar un

escaner torácico, para valorar datos de patología intersticial/vascular y decidir posteriormente si sería útil una biopsia pulmonar por fibrobroncoscopia, o un cateterismo derecho.

204. ¿Cuál de los siguientes parámetros resulta más útil en el diagnóstico diferencial de la necrosis tubular aguda por fármacos?:

1. Creatinina plasmática.
2. Urea plasmática.
3. Sodio urinario.
4. Eosinofilia en plasma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Debes memorizar muy bien los criterios de prerrenalidad, ya que son preguntados todos los años en el MIR. Lo más importante es distinguir el FRA prerrenal (el más frecuente) del FRA parenquimatoso. Así, son criterios de prerrenalidad (sugierentes de FRA prerrenal): - Osmolaridad urinaria alta (> 500 mOsm/L) - Sodio urinario bajo (< 10 - 20 mEq/L), EFNa baja ($< 1\%$) e índice de insuficiencia renal bajo (< 1 ; es comparable a la EFNa) - Aumento de los cocientes que relacionan Urea con Creatinina: $BUN/Cr > 20$, Urea orina/Urea plasma > 10 , Cr orina/ Cr plasma > 40 EN ESTA PREGUNTA EN CONCRETO: - El parámetro más útil es el sodio urinario, ya que es uno de los principales criterios de prerrenalidad (o bien solo, o bien enfrentado a la creatinina para calcular la EFNa urinaria) (respuesta 3 CORRECTA).

205. Paciente de 70 años de edad sin antecedentes de interés que ingresa en el hospital por una neumonía neumocócica. Es tratado con Ceftriaxona evolucionando satisfactoriamente. A los 7 días del ingreso comienza con fiebre, diarrea líquida maloliente, dolor cólico abdominal y leucocitosis. ¿Cuál, de los siguientes, le parece el diagnóstico más probable?:

1. Giardiasis.
2. Salmonelosis.
3. Diarrea asociada a Clostridium difficile.
4. Adenoma veloso.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Diarrea asociada a C.difficile, causa más frecuente de diarrea nosocomial después de un tratamiento antibiótico.

206. Mutaciones del gen X25 situado en la región cromosómica 9q13 son causa de ataxia de Friedreich, de herencia recesiva. Un paciente afecto de 30 años acude a la consulta de consejo genético con su pareja, sana y sin conocido parentesco. La frecuencia de portadores sanos en España se estima en uno entre setenta (1/70). ¿Qué probabilidad presenta la pareja de transmitir la enfermedad?:

1. El riesgo de tener un hijo afecto es 1/140.
2. Ninguna. Todos sus hijos serán sanos respecto a la citada enfermedad.
3. Un 50% serán portadores, un 25% afectados y un 25% sanos no portadores.
4. Todos sus hijos serán afectados.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una enfermedad de herencia recesiva por lo que si el paciente está afecto, tiene los dos alelos afectados por lo que transmitirá al 100% de su descendencia uno de los dos alelos afectados. La pareja, por ser sana y sin parentesco; tiene una posibilidad de ser portadora de 1/70. No nos podemos olvidar que en el caso de que la pareja fuera portadora, podría transmitir el alelo afecto o el alelo sano, es decir, sería un 50% de probabilidades o 1/2 que da lugar a unas probabilidades totales de transmisión de 1/140 (1/2x70) (RESPUESTA 1 CORRECTA).

207. Un paciente de 60 años es diagnosticado de carcinoma epidermoide del lóbulo inferior del pulmón derecho (T2 N1 M0). Tiene un FEV1 del 83% (superior a 2,5 L). ¿Cuál sería la mejor opción terapéutica?:

1. Quimioterapia neoadyuvante y cirugía posterior.
2. Radioterapia con intención curativa.
3. Cirugía y radioterapia posterior.
4. Cirugía sólo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un cancer no microcitico en estadio IIb (T2N1M0). En este estadiaje e inferiores, la cirugía es curativa, y aumenta significativamente la supervivencia, luego de ser operable el mejor tratamiento posible es quirurgico. Dado que tiene un FEV1 igual o superior al 80% del teórico (superior además a 2 litros en valores absolutos, que es el punto de corte "clásico"), el paciente es operable, luego el esquema terapeutico debe incluir cirugía. Los estadios IIa y IIb se benefician de quimioterapia; se recomienda a día de hoy que sea coadyuvante (posterior a la cirugía) para no postponerla, pero no es un flagrante delito que sea neoadyuvante. La cirugía en monoterapia es una opción valida pero solo en pacientes de alto riesgo de toxicidad (o que desarrollan toxicidad tras el primer ciclo de quimioterapia); en cambio, en un estadiaje IIIa de tipo T3N1M0 no cabe la opción de cirugía en monoterapia. La radioterapia aislada no es curativa, y sería incorrecta en este paciente.

208. Durante la celebración de un concierto multitudinario de rock, un asistente al mismo sufre un colapso súbito y se solicita su participación profesional entre tanto no llega el Sistema de Emergencias Médicas ya contactado. Su primera valoración del paciente es que está inconsciente, con movimientos respiratorios de

lucha, cianótico y con pulso carotídeo presente. En esta situación. ¿Cuál debe ser su prioridad terapéutica?:

1. Iniciar la respiración boca a boca.
2. Aplicar una desfibrilación eléctrica 200 joules.
3. Asegurar que no existen cuerpos extraños en la boca, levantar la mandíbula e hiperextender la cabeza.
4. Hacer compresiones torácicas a razón de 80-100 por minuto tras colocar al paciente sobre plano duro.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta hace referencia al algoritmo básico de asistencia ante un paciente inconsciente y que, como recuerdas se basa en el ABC: - A: vía aérea permeable. Es la primera actitud Siempre. - B (breathing): respiración: si el paciente no respira, hay que realizar de manera inmediata dos insuflaciones pulmonares generalmente con el Boca-boca. - C (circulation): verificar la presencia de pulso. Si no está presente, iniciar masaje cardíaco. En nuestro paciente lo prioritario es garantizar la vía aérea permeable ya que probablemente tenga un cuerpo extraño en la vía aérea (él hace movimientos respiratorios y tiene pulso). La desfibrilación sólo debe realizarse por personal entrenado en reanimación cardiopulmonar avanzada cuando la causa de la parada cardíaca sea una FV.

209. Una mujer de 30 años con 8 semanas de amenorrea acude a urgencias por presentar metrorragias y dolor hipogástrico desde hace unas horas. La tensión arterial es de 120/80 mm Hg. El test de embarazo es positivo. Por ecografía transvaginal se observa un endometrio de 14 mm de espesor sin imagen de saco gestacional dentro del útero. Tampoco se observa imagen de saco gestacional extrauterino. El hemograma es normal y la determinación de gonadotropina coriónica en plasma es de 3.000 mUI/ml. ¿Cuál es la conducta más aconsejable?:

1. Repetir la determinación de gonadotropina coriónica en plasma y la ecografía cada 2-3 días y si la hormona aumenta adecuadamente a lo esperado en un embarazo y sigue sin verse saco gestacional intrauterino, indicar una laparoscopia.
2. Laparoscopia.
3. Legrado uterino.
4. Laparotomía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Lo más importante para acertarla es conocer el diagnóstico diferencial de las hemorragias del primer trimestre. Se puede descartar la enfermedad trofoblástica por los niveles bajos de gonadotropina coriónica. El enunciado no es sospechoso

de aborto, no hay contracciones ni se visualiza el feto. La tercera alternativa es el embarazo ectópico. Esta pregunta es difícil, porque aunque se llegue al diagnóstico, se debe conocer el protocolo de sospecha de embarazo ectópico. Cuando las pruebas complementarias no han sido eficaces en su localización y la sospecha es alta, se realizará una laparoscopia y anatomía patológica. Estas dos pruebas darán el diagnóstico de certeza. (opción 2 correcta).

210. ¿Cuál de los siguientes fármacos debe ser utilizado con gran precaución por el riesgo derivado de su capacidad para inducir la actividad de varias de las isoenzimas CYP450 provocando interacciones peligrosas?:

1. Cloramfenicol.
2. Eritromicina.
3. Rifampicina.
4. Ritonavir.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Existen determinados fármacos y sustancias que aumentan la síntesis de proteínas metabolizantes (CYP450.), son los inductores enzimáticos. Al aumentar la concentración del CYP450 disminuye la concentración de los fármacos metabolizados por ella. Entre ellos hay que destacar los barbitúricos, hidantoínas, RIFAMPICINA, carbamacepina, tabaco y alcohol. Los inhibidores enzimáticos ejercen la acción contraria, p.ej cimetidina.

